

Bunga Rampai
**PENDEKATAN HOLISTIK
DALAM ASUHAN KEBIDANAN
DARI REMAJA HINGGA LANSIA**

Ardiana Batubara • Ani Kristianingsih • Dwi Retno Wati
Dwi Dianita Irawan

Editor: Heni Elmiani Sari



BUNGA RAMPAI

PENDEKATAN HOLISTIK DALAM ASUHAN

KEBIDANAN: DARI REMAJA HINGGA LANSIA

Penulis:

Ardiana Batubara, SST., M.Keb.

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Dwi Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb.

Editor:

Heni Elmiani Sari, SST., MPH.



BUNGA RAMPAI PENDEKATAN HOLISTIK DALAM ASUHAN KEBIDANAN: DARI REMAJA HINGGA LANSIA

Penulis: Ardiana Batubara, SST., M.Keb.
Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.
Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Dwi Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb.

Editor: Heni Elmiani Sari, SST., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7426-04-8

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Bunga Rampai Pendekatan Holistik dalam Asuhan Kebidanan: Dari Remaja Hingga Lansia dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian akademisi dan praktisi kebidanan dalam mengembangkan ilmu yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, spiritual, dan kultural.

Isi buku disusun secara sistematis mulai dari asuhan kebidanan pada remaja, masa pra konsepsi dan kehamilan, masa nifas, hingga pendampingan kebidanan pada lansia. Setiap chapter membahas konsep dasar, pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, serta dilengkapi dengan perspektif praktis, kearifan lokal, dan refleksi berbasis kasus. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif sekaligus aplikatif dalam bidang kebidanan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan, menginspirasi, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa, bidan, dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkesinambungan, beretika, peka budaya, dan selaras dengan perkembangan zaman. Pendekatan holistik yang diuraikan dalam buku ini menjadi sangat penting di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih humanis dan berkualitas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis, penyunting, dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat sebagai rujukan dalam pendidikan, penelitian, maupun praktik kebidanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan keluarga di Indonesia.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA SECARA HOLISTIK..... 1

Ardiana Batubara, SST., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Dasar Asuhan Holistik pada Remaja	3
C. Karakteristik Remaja dalam Perspektif Holistik	5
D. Pengkajian Holistik pada Remaja	7
E. Identifikasi Kebutuhan Khusus Remaja secara Holistik	9
F. Perencanaan Asuhan Kebidanan Holistik pada Remaja.....	11
G. Implementasi Asuhan Kebidanan Holistik	13
H. Evaluasi Asuhan Kebidanan Holistik.....	15
I. Tantangan dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Holistik pada Remaja.....	17
J. Simpulan.....	19
K. Referensi.....	21
L. Glosarium.....	22

CHAPTER 2 KONSEP HOLISTIK PADA MASA PRA KONSEPSI DAN KEHAMILAN.....25

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Konsep Holistik pada masa Pra Konsepsi	27
C. Konsep Holistik pada masa Kehamilan	34
D. Referensi.....	37

CHAPTER 3 ASUHAN KEBIDANAN HOLISTIK MASA NIFAS 39

A. Pendahuluan/Prolog	39
B. Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas	40
C. Pemenuhan Nutrisi pada Masa Nifas	42
D. Dukungan Psikologis dan Emosional pada Masa Nifas	44
E. Promosi dan Dukungan Menyusui pada Masa Nifas	46
F. Aktivitas Fisik dan Istirahat dalam Masa Nifas.....	49

G. Asuhan Kebidanan Berbasis Spiritual dan Budaya Lokal	50
H. Dukungan Sosial dan Peran Keluarga.....	52
I. Pencegahan dan Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas.....	54
J. Simpulan.....	56
K. Referensi.....	57
L. Glosarium.....	58

CHAPTER 4 PENDAMPINGAN KEBIDANAN HOLISTIK PADA LANSIA 61

A. Pendahuluan/Prolog	61
B. Landasan Konseptual.....	63
C. Profil Lansia Perempuan dan Determinan Kesehatan.....	66
D. Peran, Kewenangan, dan Kompetensi Bidan.....	70
E. Pengkajian Holistik Terintegrasi	73
F. Penetapan Permasalahan dan Prioritas Asuhan	78
G. Perencanaan Asuhan Individual dan Berbasis Keluarga	81
H. Intervensi Klinis Non-Farmakologis Utama	85
I. Intervensi Berbasis Komunitas.....	89
J. Kolaborasi Interprofesional dan Alur Rujukan.....	92
K. Keselamatan Pasien di Rumah dan Komunitas	95
L. Etika, Hukum, dan Perlindungan Hak Lansia.....	98
M. Teknologi dan Transformasi Digital	100
N. Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi Mutu	104
O. Kearifan Lokal dan Sensitivitas Budaya	107
P. Studi Kasus dan Refleksi Praktik	111
Q. Simpulan.....	114
R. Referensi.....	115
S. Glosarium.....	117

PROFIL PENULIS 123

CHAPTER 1

ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA SECARA HOLISTIK

Ardiana Batubara, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Asuhan kebidanan pada remaja dengan pendekatan holistik merupakan bentuk pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, utuh, dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi psikologis, emosional, sosial, budaya, serta spiritual yang saling terkait dalam kehidupan seorang remaja. Hal ini sangat penting karena masa remaja merupakan periode kritis yang ditandai oleh berbagai perubahan signifikan dalam seluruh aspek kehidupan individu.

Remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana mereka mengalami perubahan fisik yang sangat cepat dan kompleks seperti pubertas, perubahan hormonal, serta perkembangan organ reproduksi. Perubahan ini seringkali menimbulkan kebingungan, kecemasan, serta ketidaknyamanan pada remaja, khususnya bila mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup dan tepat mengenai kondisi yang sedang dialami. Pada saat yang bersamaan, remaja juga mengalami perubahan psikologis yang signifikan seperti mencari identitas diri, kemandirian, serta keinginan untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, asuhan kebidanan pada remaja secara holistik menjadi relevan karena pendekatan ini memberikan perhatian khusus pada keseluruhan aspek yang mempengaruhi kehidupan remaja.

Pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa kesehatan reproduksi tidak bisa dipisahkan dari aspek kehidupan lainnya. Sebagai contoh, kondisi psikologis seorang remaja seperti kecemasan, depresi, dan stres memiliki hubungan erat dengan kesehatan reproduksi. Masalah psikologis tersebut dapat berdampak pada siklus menstruasi yang tidak teratur, nyeri menstruasi yang berlebihan, bahkan pada kasus tertentu, dapat mengganggu fungsi organ reproduksi secara lebih luas. Sebaliknya, masalah fisik seperti gangguan menstruasi, nyeri pada organ reproduksi, ataupun kondisi kesehatan reproduksi lainnya juga dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup remaja. Dengan demikian, dalam menjalankan asuhan kebidanan, seorang bidan harus mampu melihat remaja

sebagai individu yang utuh dengan berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan.

Asuhan kebidanan secara holistik juga menekankan pentingnya komunikasi efektif antara bidan dengan remaja. Dalam konteks ini, bidan dituntut tidak hanya memiliki keterampilan teknis klinis yang baik, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan sensitif terhadap kebutuhan remaja. Remaja membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, dan terpercaya untuk berbagi segala keluhan, ketakutan, atau masalah yang sedang mereka hadapi. Bidan, dengan pendekatan holistik, harus dapat menciptakan hubungan terapeutik yang harmonis sehingga remaja merasa dihargai, didengar, dan dipahami.

Selain aspek fisik dan psikologis, pendekatan holistik juga memperhatikan pengaruh aspek sosial, budaya, serta spiritual dalam kehidupan remaja. Aspek sosial meliputi bagaimana hubungan remaja dengan keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Masalah yang sering muncul pada aspek sosial di antaranya bullying, kekerasan berbasis gender, tekanan sosial dari teman sebaya, serta relasi yang tidak sehat. Kondisi sosial ini berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan reproduksi remaja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, tekanan sosial atau bullying dapat menyebabkan remaja menarik diri, stres, hingga mengalami gangguan makan yang selanjutnya berisiko mengganggu kesehatan reproduksi.

Aspek budaya juga penting diperhatikan dalam asuhan kebidanan holistik, karena setiap remaja tumbuh dalam lingkungan budaya tertentu dengan nilai-nilai dan norma yang berbeda-beda. Norma budaya sering kali mempengaruhi persepsi remaja tentang seksualitas, menstruasi, kehamilan remaja, penggunaan kontrasepsi, serta pola asuh dalam keluarga. Mengetahui dan memahami aspek budaya remaja merupakan bagian penting dari pemberian asuhan yang tepat dan efektif.

Selain itu, aspek spiritual juga tidak boleh diabaikan karena spiritualitas dapat mempengaruhi bagaimana remaja menghadapi berbagai tantangan hidupnya, termasuk persoalan reproduksi dan seksual. Remaja yang memiliki spiritualitas kuat biasanya lebih mampu mengatasi stres, mengelola emosi, serta menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan positif. Oleh karena itu, dalam pendekatan holistik, bidan perlu mengenali bagaimana remaja memaknai kehidupannya dan keyakinan spiritualnya dalam konteks pelayanan kesehatan yang diberikan.

Melalui pendekatan holistik ini, tujuan akhir dari asuhan kebidanan pada remaja tidak hanya terbatas pada pencapaian kesehatan reproduksi fisik semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Remaja diharapkan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, psikologis,

sosial, budaya, dan spiritual sehingga mampu menjalani masa transisi menuju dewasa dengan sehat, bahagia, dan produktif. Bidan dalam hal ini berperan penting sebagai pendamping dan fasilitator yang tidak hanya memberikan intervensi klinis, tetapi juga memberikan dukungan secara emosional, sosial, serta spiritual yang dibutuhkan oleh remaja dan keluarganya. Dengan demikian, asuhan kebidanan holistik ini diharapkan menjadi model pelayanan yang efektif dan optimal dalam merawat serta mendampingi remaja menuju kualitas hidup yang lebih baik.

B. Konsep Dasar Asuhan Holistik pada Remaja

Dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif kepada remaja, sangat penting bagi seorang bidan untuk memahami konsep dasar dari pendekatan holistik. Pendekatan holistik sendiri dapat diartikan sebagai pendekatan yang memandang manusia secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, bukan semata-mata sebagai individu dengan masalah kesehatan fisik yang terpisah dari aspek kehidupannya yang lain. Asuhan holistik bertumpu pada pemahaman bahwa seorang remaja tidak hanya terdiri atas tubuh fisik semata, tetapi juga terdiri dari aspek psikologis, emosional, sosial, budaya, serta spiritual yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara dinamis.

Secara filosofis, pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan memiliki dasar pemikiran bahwa setiap individu, termasuk remaja, memiliki karakter unik yang tidak dapat disamaratakan. Setiap remaja memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman hidup yang khas, serta nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda pula. Oleh karena itu, asuhan yang diberikan pun harus dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang melekat pada individu tersebut. Filosofi ini juga menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, di mana setiap remaja harus dihormati martabatnya sebagai manusia yang utuh. Bidan sebagai tenaga kesehatan dalam pendekatan ini dituntut untuk tidak sekadar merawat atau mengatasi gejala fisik semata, tetapi juga membantu remaja dalam menghadapi tantangan hidup secara keseluruhan, mencakup aspek emosional, mental, sosial, budaya, serta spiritual.

Pentingnya pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan pada remaja tidak bisa diabaikan. Masa remaja merupakan periode penuh tantangan, di mana remaja menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan kompleks, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka harus beradaptasi dengan berbagai perubahan tubuh yang kadang menimbulkan ketidaknyamanan, kebingungan, bahkan kecemasan. Di samping itu, remaja juga mulai mengeksplorasi jati dirinya, menghadapi berbagai tekanan dari teman sebaya, tuntutan akademik, serta berbagai harapan dari keluarga dan lingkungannya. Tekanan yang datang dari berbagai sisi ini jika tidak

dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih luas, seperti gangguan emosional, gangguan makan, depresi, gangguan kecemasan, perilaku berisiko, bahkan hingga masalah kesehatan reproduksi yang serius.

Pendekatan holistik menjadi krusial karena memungkinkan seorang bidan memberikan asuhan yang tidak hanya fokus pada satu aspek saja, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan remaja secara menyeluruh. Sebagai contoh, ketika seorang remaja datang dengan keluhan nyeri menstruasi yang hebat, pendekatan holistik tidak hanya akan fokus pada pengobatan nyeri menstruasi saja, tetapi juga akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor psikologis seperti kecemasan atau stres yang mungkin menjadi pemicu, aspek sosial seperti hubungan dengan keluarga dan teman sebaya yang bisa menjadi sumber stres, serta aspek budaya seperti stigma atau kepercayaan lokal yang mempengaruhi cara remaja memandang kesehatan reproduksinya. Dengan memahami keseluruhan aspek ini, seorang bidan dapat memberikan intervensi yang lebih tepat, komprehensif, dan efektif.

Dalam pelaksanaan asuhan kebidanan secara holistik pada remaja, ada beberapa prinsip penting yang harus dipahami oleh tenaga kesehatan, terutama bidan. Salah satu prinsip utama adalah memandang remaja sebagai individu yang unik dengan kebutuhan khusus yang tidak sama antara satu remaja dengan yang lain. Bidan perlu menghindari generalisasi dalam memberikan asuhan, karena setiap remaja memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk perbedaan budaya, agama, nilai, maupun kondisi keluarga. Prinsip berikutnya adalah pentingnya partisipasi aktif remaja dalam setiap tahap asuhan. Remaja bukan hanya menjadi objek intervensi tetapi juga sebagai subjek aktif yang berhak menyuarakan kebutuhan, perasaan, serta pandangannya terhadap kondisi kesehatan yang dialaminya. Prinsip ini menempatkan remaja sebagai mitra dalam proses asuhan sehingga hasilnya menjadi lebih optimal karena remaja merasa dihargai dan didengar pendapatnya.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah prinsip kerja sama dan kolaborasi interprofesional. Pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan tidak bisa dilakukan secara maksimal jika hanya bergantung pada satu bidang keahlian saja. Bidan perlu bekerja sama dengan profesional lain seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, ahli gizi, bahkan tokoh masyarakat atau pemuka agama jika diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan remaja secara komprehensif. Kolaborasi interprofesional ini memungkinkan setiap aspek kehidupan remaja mendapat perhatian yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Prinsip berikutnya adalah kesinambungan asuhan atau kontinuitas pelayanan. Prinsip ini menegaskan bahwa asuhan kebidanan holistik harus berkelanjutan, tidak

hanya bersifat episodik atau sekali kunjungan saja. Remaja membutuhkan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terjaga, baik fisik maupun emosional. Selain itu, prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai privasi, kerahasiaan, serta sensitivitas terhadap kebutuhan remaja juga menjadi bagian integral dalam pelaksanaan asuhan holistik. Remaja sangat peka terhadap isu privasi dan kerahasiaan, sehingga bidan harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman selama proses asuhan berlangsung.

Dengan mengacu pada konsep dasar, filosofi, pentingnya pendekatan, dan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan asuhan kebidanan secara holistik pada remaja dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan remaja secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, diharapkan remaja tidak hanya menjadi sehat secara fisik tetapi juga mampu berkembang secara optimal di semua dimensi kehidupannya, menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan produktif di masa depan.

C. Karakteristik Remaja dalam Perspektif Holistik

Memahami karakteristik remaja dalam perspektif holistik merupakan langkah krusial dalam memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dan bermakna. Masa remaja adalah periode transisi yang ditandai oleh perubahan drastis di hampir semua aspek kehidupan, baik secara fisik, biologis, psikologis, emosional, sosial, budaya, maupun spiritual. Setiap dimensi ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, sehingga pendekatan yang bersifat parsial akan kurang efektif dalam memahami dan menjawab kebutuhan kesehatan remaja secara utuh. Dalam konteks asuhan kebidanan, mengenali karakteristik remaja dari berbagai dimensi ini memungkinkan bidan untuk memberikan intervensi yang lebih tepat, menyeluruh, serta sensitif terhadap kebutuhan dan konteks kehidupan individu remaja tersebut.

Dari sisi perkembangan fisik dan biologis, remaja mengalami perubahan yang sangat cepat dan kompleks akibat proses pubertas. Pubertas menandai kematangan sistem reproduksi yang ditandai dengan munculnya ciri-ciri seksual sekunder, seperti menstruasi pertama (menarche) pada perempuan, perubahan bentuk tubuh, pertumbuhan tinggi badan yang pesat, perubahan suara, dan peningkatan produksi hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Perubahan ini seringkali membingungkan dan menimbulkan kekhawatiran, terutama jika tidak diiringi dengan pemahaman yang baik tentang proses-proses yang sedang terjadi dalam tubuh mereka. Sebagian remaja juga mengalami ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan masalah seperti nyeri haid, keputihan, jerawat, bahkan gangguan emosional yang berkaitan dengan siklus hormonal tersebut. Kondisi-kondisi ini dapat berdampak langsung pada kesehatan reproduksi dan citra diri remaja, sehingga membutuhkan pemahaman dan pendampingan yang sensitif dari bidan.

Perkembangan psikologis dan emosional pada masa remaja sama pentingnya untuk diperhatikan. Remaja berada dalam fase pencarian jati diri, berusaha memahami siapa diri mereka dan apa peran mereka dalam masyarakat. Mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini diajarkan, mengeksplorasi ide-ide baru, serta mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan ekstrem. Ketidakstabilan emosional yang khas pada masa ini sering kali membuat remaja menjadi lebih sensitif, mudah marah, cepat tersinggung, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kondisi ini dapat diperparah jika remaja mengalami tekanan dari keluarga, lingkungan sekolah, atau teman sebaya, misalnya dalam bentuk tuntutan akademik, konflik keluarga, perundungan (bullying), atau ekspektasi sosial tertentu. Dalam konteks asuhan kebidanan, pemahaman terhadap aspek psikologis dan emosional ini memungkinkan bidan untuk memberikan pendekatan yang lebih empatik dan suportif. Bidan tidak hanya fokus pada pengobatan gejala fisik, tetapi juga mampu menjadi pendengar yang baik dan pemberi dukungan emosional yang dibutuhkan remaja.

Selain aspek fisik dan psikologis, perkembangan sosial, budaya, dan spiritual juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk karakteristik remaja. Secara sosial, remaja mulai membentuk identitas diri mereka melalui interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. Mereka belajar tentang hubungan, kepercayaan, kerja sama, serta bagaimana bersikap dalam kelompok. Namun, tidak semua remaja memiliki dukungan sosial yang kuat. Beberapa remaja mungkin hidup dalam kondisi keluarga yang disfungsi, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau berada di lingkungan yang kurang kondusif untuk tumbuh kembang optimal. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan gangguan perilaku, kecemasan, atau bahkan depresi yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan reproduksi dan gaya hidup seksual mereka.

Budaya juga berperan besar dalam membentuk persepsi dan sikap remaja terhadap tubuh dan kesehatan reproduksi. Di beberapa komunitas, misalnya, pembicaraan tentang seksualitas dianggap tabu, sehingga remaja tidak memperoleh informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, atau risiko penyakit menular seksual. Dalam kondisi demikian, remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap informasi keliru dan perilaku seksual berisiko. Pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang dianut remaja sangat penting agar bidan dapat memberikan edukasi dan konseling yang tepat, sensitif, dan diterima oleh remaja tanpa menimbulkan penolakan atau konflik nilai.

Tak kalah penting adalah aspek spiritual dalam kehidupan remaja. Meskipun sering diabaikan, spiritualitas berperan sebagai sumber makna, harapan, dan kekuatan batin bagi banyak remaja, terutama ketika menghadapi tekanan atau krisis

identitas. Remaja yang memiliki pegangan spiritual yang kuat cenderung memiliki daya tahan mental dan emosional yang lebih baik, serta mampu membuat keputusan yang lebih bijak terkait gaya hidup dan kesehatan reproduksinya. Dalam asuhan kebidanan yang holistik, aspek spiritual tidak harus dikaitkan dengan agama tertentu, tetapi lebih pada pemahaman tentang bagaimana remaja memaknai hidup, nilai-nilai yang mereka yakini, dan harapan mereka terhadap masa depan.

D. Pengkajian Holistik pada Remaja

Pengkajian holistik pada remaja merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses asuhan kebidanan yang menyeluruh. Dalam pendekatan holistik, pengkajian tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau keluhan klinis yang tampak, melainkan mencakup seluruh dimensi yang membentuk kehidupan dan kesejahteraan seorang remaja, yaitu aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, budaya, dan spiritual. Masa remaja adalah periode yang sarat dengan perubahan, pencarian jati diri, serta proses penyesuaian terhadap berbagai tekanan internal dan eksternal. Oleh karena itu, proses pengkajian harus dilakukan secara hati-hati, penuh empati, dan bersifat partisipatif agar remaja merasa aman, diterima, dan terbuka dalam mengungkapkan kondisi yang mereka alami.

Dalam hal pengkajian kesehatan fisik dan reproduksi, bidan perlu memeriksa kondisi tubuh remaja secara umum serta fungsi dan kesehatan organ reproduksi secara khusus. Pengkajian fisik dapat mencakup penilaian terhadap status gizi, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, serta tanda-tanda vital lainnya yang relevan. Dalam konteks kesehatan reproduksi, bidan harus menilai perkembangan pubertas, riwayat menstruasi, pola haid, keluhan saat menstruasi, keputihan, riwayat hubungan seksual (jika ada), serta pengetahuan remaja tentang fungsi dan anatomi sistem reproduksi. Pengkajian ini sangat penting karena banyak remaja mengalami perubahan fisiologis yang membingungkan dan tidak memahami apakah perubahan tersebut tergolong normal atau merupakan tanda gangguan. Dalam pengkajian ini, penting bagi bidan untuk bersikap tidak menghakimi dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan usia agar remaja merasa nyaman untuk terbuka. Pemeriksaan fisik juga sebaiknya dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu prosedurnya dan meminta persetujuan remaja, agar mereka merasa dihargai dan dilindungi privasinya.

Selain aspek fisik, pengkajian psikologis dan emosional memegang peranan penting dalam memahami kondisi remaja secara menyeluruh. Masa remaja sering kali ditandai dengan ketidakstabilan emosi, fluktuasi suasana hati, dan pencarian identitas diri yang intens. Bidan perlu mengeksplorasi kondisi psikologis remaja melalui percakapan yang terbuka dan empatik, menggali bagaimana perasaan

mereka terhadap diri sendiri, keluarga, teman, serta bagaimana mereka mengatasi tekanan atau konflik. Pengkajian ini dapat mencakup identifikasi adanya gejala stres, kecemasan, depresi, kepercayaan diri rendah, atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri. Remaja yang mengalami tekanan psikologis yang berat dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai sangat rentan terhadap perilaku berisiko seperti seks bebas, penyalahgunaan zat, dan perilaku menyakiti diri. Oleh karena itu, bidan tidak hanya berperan sebagai pemeriksa kesehatan, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami dinamika emosi remaja. Dalam hal ini, penggunaan instrumen skrining psikologis ringan seperti kuesioner depresi atau kecemasan dapat digunakan sebagai alat bantu, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan kenyamanan remaja.

Pengkajian holistik tidak akan lengkap tanpa memperhatikan aspek sosial, budaya, dan spiritual yang memengaruhi kehidupan remaja. Aspek sosial berkaitan dengan lingkungan tempat remaja tumbuh dan berkembang, seperti keluarga, sekolah, pertemanan, serta komunitas. Bidan perlu mengevaluasi bagaimana relasi remaja dengan anggota keluarga, apakah mereka mendapatkan dukungan emosional yang cukup, atau justru mengalami tekanan, konflik, atau kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan dengan teman sebaya juga perlu dikaji karena pada fase ini, pengaruh teman sangat besar terhadap pola pikir, keputusan, dan perilaku remaja. Remaja yang terisolasi secara sosial atau mengalami bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial, sangat berisiko mengalami gangguan psikologis maupun gangguan kesehatan reproduksi.

Dari sisi budaya, pengkajian perlu menggali nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh remaja dan keluarganya. Misalnya, dalam beberapa budaya, pembicaraan mengenai menstruasi, seksualitas, atau penggunaan kontrasepsi dianggap tabu. Hal ini tentu akan memengaruhi cara remaja memahami tubuh dan kesehatan reproduksinya. Dengan memahami konteks budaya yang melingkupi remaja, bidan dapat menyesuaikan pendekatan edukasi dan konseling yang lebih sensitif, tidak menyinggung keyakinan, namun tetap memberikan informasi yang benar dan mendidik.

Tak kalah penting adalah aspek spiritual yang menjadi fondasi dalam pembentukan nilai, makna hidup, serta harapan remaja. Bagi banyak remaja, spiritualitas merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi tekanan hidup. Oleh karena itu, bidan perlu mengeksplorasi bagaimana remaja memaknai peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, bagaimana ia mengatasi kesulitan, serta apakah ia memiliki praktik spiritual tertentu seperti berdoa, bermeditasi, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Pengkajian spiritual tidak dimaksudkan untuk mengarahkan remaja kepada agama tertentu, tetapi lebih kepada memahami bagaimana nilai-nilai

spiritual yang dianutnya dapat menjadi sumber dukungan atau justru menjadi hambatan dalam menjaga kesehatannya.

Melalui pengkajian holistik yang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, bidan akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi remaja yang didampinginya. Dengan begitu, intervensi yang dirancang akan lebih tepat sasaran, personal, dan relevan dengan konteks kehidupan remaja tersebut. Pengkajian ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara bidan dan remaja, menciptakan ruang aman di mana remaja merasa didengar, dihargai, dan didampingi dengan penuh empati. Pengkajian holistik bukan hanya langkah awal dari proses asuhan kebidanan, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktik pelayanan yang bermartabat dan berfokus pada kebutuhan individu secara menyeluruh.

E. Identifikasi Kebutuhan Khusus Remaja secara Holistik

Identifikasi kebutuhan khusus remaja secara holistik adalah proses mengenali secara mendalam berbagai aspek penting yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan remaja. Proses ini memerlukan pemahaman menyeluruh yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik atau kesehatan semata, tetapi juga mencakup aspek psiko-emosional, sosial, budaya, dan spiritual yang saling berkaitan. Mengidentifikasi kebutuhan remaja secara holistik memungkinkan bidan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang tepat dan menyeluruh, sesuai dengan karakteristik khusus remaja yang kompleks dan multidimensi.

Salah satu kebutuhan dasar remaja yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksual. Pada fase ini, remaja menghadapi perubahan signifikan pada sistem reproduksinya yang sering kali menimbulkan ketidaknyamanan, kebingungan, bahkan rasa malu. Mereka membutuhkan edukasi yang akurat tentang perkembangan seksual, anatomi dan fisiologi organ reproduksi, siklus menstruasi, masalah kesehatan reproduksi umum seperti nyeri menstruasi dan keputihan, serta risiko kesehatan reproduksi seperti infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan tidak direncanakan. Edukasi ini penting agar remaja memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga serta melindungi kesehatan reproduksi mereka secara mandiri.

Di samping informasi, remaja juga membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Layanan ini harus memberikan ruang privasi yang aman, memungkinkan remaja bertanya secara terbuka tanpa rasa takut dihakimi atau mendapat stigma. Remaja perlu diberikan bimbingan yang jelas tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, penggunaan alat perlindungan seksual jika diperlukan, serta pentingnya pemahaman tentang hubungan seksual yang

bertanggung jawab. Pelayanan yang diberikan harus sensitif terhadap usia, menghargai hak remaja untuk memperoleh informasi, serta membantu mereka dalam mengambil keputusan yang sehat terkait tubuh dan masa depan mereka.

Selanjutnya, kebutuhan psiko-emosional atau kesehatan mental juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan secara khusus dalam pendekatan holistik. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas, di mana remaja sering kali dihadapkan pada tantangan emosional yang kuat, tekanan sosial yang tinggi, serta berbagai harapan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Tidak jarang remaja mengalami ketidakstabilan emosional, stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Kondisi psiko-emosional ini tidak boleh dianggap sepele, karena jika dibiarkan tanpa intervensi dapat menyebabkan gangguan yang lebih serius, seperti gangguan perilaku, penyalahgunaan zat, atau bahkan tindakan menyakiti diri sendiri.

Dalam menghadapi tantangan psiko-emosional, remaja membutuhkan lingkungan yang suportif, di mana mereka merasa aman dan nyaman untuk berbagi perasaan serta pikiran mereka. Mereka membutuhkan orang dewasa, dalam hal ini bidan atau tenaga kesehatan lain, yang dapat mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi, serta mampu memberikan bimbingan dan konseling yang diperlukan. Di sisi lain, remaja juga memerlukan keterampilan hidup dasar seperti pengelolaan stres, kemampuan berkomunikasi secara efektif, pengambilan keputusan secara sehat, dan mekanisme coping yang positif. Jika dibutuhkan, remaja dapat dirujuk ke tenaga kesehatan mental profesional seperti psikolog atau konselor, untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.

Selain aspek fisik dan psiko-emosional, kebutuhan remaja juga mencakup aspek sosial, budaya, dan spiritual yang tidak kalah pentingnya. Secara sosial, remaja membutuhkan hubungan yang positif dengan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan yang lebih luas. Mereka sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial sehari-hari, baik dalam lingkungan rumah, sekolah, maupun komunitas. Remaja yang tumbuh di lingkungan sosial yang suportif cenderung memiliki kepercayaan diri yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, serta mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, remaja yang mengalami tekanan sosial, seperti perundungan, konflik dalam keluarga, atau isolasi sosial, akan lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan fisik maupun mental.

Di sisi budaya, remaja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, serta kepercayaan yang dianut oleh keluarga maupun komunitas tempat mereka tumbuh. Budaya sangat menentukan bagaimana remaja memandang dirinya sendiri, tubuhnya, serta konsep seksualitas. Remaja membutuhkan pemahaman yang tepat dan bijak tentang nilai-nilai budaya mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sehat tanpa merasa bertentangan dengan norma yang berlaku.

Oleh karena itu, bidan perlu peka terhadap latar belakang budaya remaja, mampu berkomunikasi secara efektif sesuai konteks budaya yang relevan, serta memberikan edukasi yang menghormati norma-norma lokal tanpa mengorbankan informasi kesehatan yang esensial.

Terakhir, aspek spiritual juga merupakan kebutuhan yang signifikan bagi remaja. Spiritualitas bukan semata-mata berkaitan dengan agama tertentu, tetapi lebih luas lagi mencakup pencarian makna hidup, rasa tujuan, harapan, serta hubungan pribadi remaja dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, seperti Tuhan atau konsep moral tertentu. Remaja yang memiliki kehidupan spiritual yang sehat akan cenderung lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidup, lebih mampu menemukan makna dalam pengalaman mereka, serta lebih positif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini, bidan dapat membantu remaja dengan mendukung dan menghormati kebutuhan spiritual mereka, memberikan kesempatan pada mereka untuk mengeksplorasi serta mengekspresikan spiritualitasnya, serta membantu mereka menemukan cara-cara yang positif dalam menyalurkan keyakinan spiritual tersebut.

F. Perencanaan Asuhan Kebidanan Holistik pada Remaja

Perencanaan asuhan kebidanan holistik pada remaja merupakan langkah strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang utuh dan menyeluruh. Langkah ini didasarkan pada hasil pengkajian dan identifikasi kebutuhan khusus yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini, perencanaan tidak hanya memperhatikan satu aspek saja, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan remaja, seperti aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, budaya, dan spiritual yang saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, perencanaan asuhan kebidanan holistik perlu dirancang secara matang, sistematis, terpadu, dan berorientasi pada individu, sehingga mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi remaja secara efektif.

Dalam penyusunan rencana asuhan kebidanan secara terpadu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan seluruh hasil pengkajian yang telah diperoleh dari berbagai dimensi kehidupan remaja. Bidan harus mampu mensintesis informasi yang diperoleh dari aspek kesehatan fisik, perkembangan reproduksi, kondisi psikologis dan emosional, situasi sosial dan budaya, hingga aspek spiritual yang berpengaruh pada kehidupan remaja. Setelah informasi ini diperoleh, tahap selanjutnya adalah merancang tujuan asuhan yang spesifik, realistis, dan relevan sesuai kondisi unik setiap remaja. Tujuan asuhan yang disusun harus mencerminkan kebutuhan nyata remaja, memperhatikan kemampuan mereka, serta

mempertimbangkan latar belakang keluarga dan komunitas yang mendukung proses pelaksanaan asuhan.

Selain tujuan, rencana asuhan yang terpadu juga harus merinci langkah-langkah intervensi yang jelas, terukur, serta terstruktur secara sistematis. Intervensi yang disusun tidak hanya terbatas pada pemberian edukasi kesehatan atau tindakan klinis semata, tetapi juga mencakup intervensi psikososial, dukungan emosional, konseling kesehatan mental, serta intervensi sosial budaya yang relevan. Dalam hal ini, bidan perlu mengidentifikasi prioritas intervensi, menetapkan jadwal kegiatan atau pertemuan secara rutin, serta menentukan alat ukur atau indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitas intervensi tersebut.

Dalam proses perencanaan yang komprehensif ini, strategi kolaborasi interprofesional merupakan salah satu aspek kunci yang perlu diperhatikan secara khusus. Mengingat kompleksitas dan multidimensionalitas kebutuhan remaja, pendekatan tunggal dari satu profesi kesehatan saja tidak cukup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Oleh karena itu, bidan perlu membangun kerja sama dan kolaborasi yang erat dengan tenaga kesehatan profesional lain seperti dokter, psikolog, konselor kesehatan mental, ahli gizi, pekerja sosial, dan bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat jika diperlukan. Kolaborasi interprofesional ini bertujuan agar intervensi yang diberikan kepada remaja bersifat komprehensif dan mampu menjangkau setiap dimensi kehidupan mereka secara optimal.

Dalam penerapan kolaborasi interprofesional ini, penting bagi bidan untuk membangun komunikasi yang efektif dan terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Pertemuan tim lintas disiplin secara berkala perlu dilakukan guna memastikan bahwa seluruh tenaga profesional memiliki pemahaman yang sama tentang kondisi remaja yang mereka tangani. Selain itu, melalui kerja sama ini, bidan juga bisa mendapatkan masukan tambahan serta pandangan dari berbagai perspektif profesional lain yang dapat memperkaya strategi intervensi, serta memperluas sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses asuhan secara keseluruhan.

Pendekatan partisipatif bersama remaja dan keluarga juga menjadi unsur penting dalam proses perencanaan asuhan kebidanan secara holistik ini. Remaja tidak boleh dianggap sebagai objek pasif dalam proses asuhan, melainkan harus dilibatkan secara aktif sejak tahap awal hingga evaluasi akhir. Pendekatan partisipatif menempatkan remaja sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, harapan, kebutuhan, serta kekhawatiran mereka terhadap asuhan yang diterima. Dengan demikian, remaja merasa dihargai, didengar, dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri mereka sendiri.

Selain remaja, keterlibatan keluarga dalam perencanaan asuhan holistik juga merupakan bagian integral yang tidak boleh diabaikan. Keluarga, khususnya orang tua atau wali, memiliki peran sentral dalam memberikan dukungan sosial, emosional, serta budaya yang sangat dibutuhkan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan hidupnya. Bidan harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, mengedukasi mereka tentang pentingnya dukungan keluarga, serta mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pelaksanaan asuhan kebidanan.

Pendekatan partisipatif ini dapat diwujudkan melalui diskusi kelompok, konseling keluarga, maupun pertemuan secara individu antara bidan, remaja, dan keluarganya. Dalam pertemuan tersebut, berbagai keputusan tentang jenis intervensi, jadwal kegiatan, serta evaluasi perkembangan remaja dapat ditentukan bersama-sama. Keterlibatan remaja dan keluarga secara aktif dalam perencanaan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas intervensi yang diberikan, tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik antara bidan dengan remaja dan keluarganya, sehingga terbangun kepercayaan, keterbukaan, serta kerja sama yang baik.

G. Implementasi Asuhan Kebidanan Holistik

Implementasi asuhan kebidanan holistik pada remaja adalah proses nyata dalam menerapkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya ke dalam tindakan konkret. Pada tahap ini, seluruh hasil pengkajian, identifikasi kebutuhan khusus, serta rencana yang terpadu diwujudkan dalam bentuk intervensi praktis dan langsung. Implementasi tidak sekadar berorientasi pada aspek fisik atau klinis, melainkan juga mencakup aspek psikososial, budaya, dan spiritual yang melekat pada kehidupan remaja. Oleh sebab itu, penerapan asuhan kebidanan secara holistik menuntut bidan untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan remaja, kemampuan komunikasi yang efektif, serta keterampilan intervensi yang beragam dan sesuai dengan karakteristik individu remaja.

Dalam aspek kesehatan reproduksi, implementasi asuhan kebidanan mencakup pelaksanaan intervensi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan khusus terkait kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Pada masa remaja, intervensi ini dapat meliputi pemberian edukasi kesehatan yang akurat tentang perubahan fisiologis selama masa pubertas, cara menjaga kebersihan organ reproduksi, pengelolaan nyeri menstruasi, serta pengenalan terhadap tanda-tanda gangguan kesehatan reproduksi seperti keputihan patologis atau infeksi menular seksual (IMS). Implementasi juga mencakup layanan konseling remaja tentang hubungan seksual yang aman dan bertanggung jawab, termasuk pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan melalui edukasi mengenai penggunaan

kontrasepsi. Pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja ini perlu disediakan dalam suasana yang nyaman, bersahabat, menjaga privasi, serta memberikan ruang bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi secara terbuka tanpa merasa malu atau takut dihakimi. Bidan, dalam proses ini, berperan sebagai fasilitator sekaligus sumber informasi terpercaya yang membantu remaja untuk membuat keputusan sehat yang sesuai dengan kondisi pribadi mereka.

Selain aspek fisik dan reproduksi, implementasi asuhan kebidanan holistik juga melibatkan pemberian dukungan psikososial yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental remaja. Remaja sering kali menghadapi berbagai tantangan psikologis dan emosional seperti stres akibat tuntutan akademik, konflik keluarga, tekanan sosial dari teman sebaya, serta ketidakpastian dalam menghadapi masa depan. Dalam situasi seperti ini, dukungan psikososial yang diberikan bidan menjadi sangat krusial. Dukungan ini dapat berupa konseling emosional yang bertujuan membantu remaja mengatasi kecemasan, mengelola stres dengan efektif, serta meningkatkan kepercayaan diri. Pendekatan yang empatik, hangat, dan terbuka dari bidan akan membantu remaja untuk merasa nyaman dalam mengungkapkan perasaan, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

Di samping itu, implementasi dukungan psikososial juga dapat diwujudkan melalui pendekatan kelompok, seperti kelompok diskusi atau kelompok dukungan sebaya yang dipandu oleh bidan. Dalam kelompok ini, remaja mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, saling mendukung secara emosional, serta belajar berbagai keterampilan hidup dasar seperti manajemen stres, penyelesaian konflik, serta komunikasi efektif. Ketika ditemukan indikasi adanya gangguan psikologis yang lebih serius, seperti depresi atau gangguan kecemasan yang berat, bidan bertugas merujuk remaja ke profesional kesehatan mental seperti psikolog atau konselor yang dapat memberikan intervensi yang lebih intensif dan spesifik.

Selain dukungan psikososial, intervensi sosial dan spiritual juga memainkan peran penting dalam implementasi asuhan kebidanan holistik pada remaja. Dari sisi sosial, bidan perlu memastikan bahwa remaja mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sekitarnya, khususnya keluarga dan teman sebaya. Bidan dapat bekerja sama dengan keluarga untuk memperkuat hubungan emosional yang positif antara remaja dengan orang tuanya, membantu keluarga memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi remaja, serta mengedukasi keluarga tentang cara memberikan dukungan yang tepat dan efektif. Dalam konteks sosial yang lebih luas, bidan juga dapat berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak remaja, seperti

perlindungan terhadap kekerasan, bullying, serta pelecehan seksual, melalui kerja sama dengan sekolah, komunitas, serta institusi sosial yang relevan.

Sementara itu, dari aspek spiritual, implementasi asuhan kebidanan holistik melibatkan upaya untuk mendukung remaja dalam menemukan makna dan tujuan hidup, membantu mereka dalam mengeksplorasi nilai-nilai spiritual yang dianut, serta memperkuat ketahanan batin mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Implementasi ini dapat dilakukan melalui pemberian ruang dialog yang terbuka tentang spiritualitas, ajakan untuk melakukan refleksi diri, serta dorongan bagi remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif yang mendukung pertumbuhan spiritual mereka, seperti meditasi, doa, atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, bidan bertugas sebagai fasilitator yang menghormati keyakinan remaja, tidak memaksakan pandangan tertentu, melainkan memberikan kesempatan dan dukungan bagi remaja untuk menemukan makna yang positif dalam kehidupan mereka.

H. Evaluasi Asuhan Kebidanan Holistik

Evaluasi asuhan kebidanan holistik merupakan tahap penting dalam rangkaian proses pemberian pelayanan kesehatan pada remaja yang dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, tetapi juga sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi asuhan di masa depan. Dalam konteks pelayanan holistik, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan remaja, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, serta mempertimbangkan keterlibatan remaja dan keluarganya dalam seluruh proses asuhan.

Indikator keberhasilan asuhan kebidanan holistik pada remaja merupakan parameter atau ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari asuhan telah tercapai. Indikator-indikator ini mencakup seluruh aspek kehidupan remaja yang telah ditargetkan dalam proses asuhan sebelumnya. Misalnya, dalam aspek kesehatan fisik dan reproduksi, indikator keberhasilan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang pubertas, menstruasi, kesehatan seksual, penggunaan kontrasepsi yang benar, serta pengelolaan gangguan kesehatan reproduksi seperti nyeri menstruasi atau keputihan patologis. Indikator lain dalam aspek fisik bisa berupa meningkatnya perilaku sehat seperti menjaga kebersihan organ reproduksi atau rutin melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi.

Dalam aspek psiko-emosional atau kesehatan mental, indikator keberhasilan yang relevan meliputi peningkatan kemampuan remaja dalam mengelola stres,

pengurangan tingkat kecemasan, serta peningkatan rasa percaya diri dan harga diri. Keberhasilan juga dapat dilihat dari adanya perubahan positif dalam perilaku remaja, misalnya kemampuan mereka untuk mengekspresikan emosi dengan lebih sehat dan terbuka, serta meningkatnya kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam aspek sosial, budaya, dan spiritual, indikator keberhasilan dapat berupa peningkatan kualitas hubungan remaja dengan keluarga dan teman sebaya, pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kesadaran spiritual yang memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku remaja sehari-hari.

Setelah menentukan indikator keberhasilan, langkah berikutnya dalam evaluasi asuhan kebidanan holistik adalah memilih teknik dan instrumen evaluasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan serta indikator yang telah ditetapkan. Teknik evaluasi yang umum digunakan dalam asuhan kebidanan holistik meliputi observasi langsung terhadap perubahan perilaku atau kondisi remaja, wawancara mendalam atau konseling lanjutan dengan remaja dan keluarga untuk mengetahui persepsi serta pengalaman mereka selama proses asuhan, serta penggunaan kuisioner atau skala psikometrik khusus, seperti skala kecemasan atau depresi, yang dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang perubahan kondisi psikologis remaja.

Instrumen evaluasi yang dipilih harus valid dan reliabel, sehingga dapat memberikan hasil yang akurat dan objektif mengenai perkembangan kondisi remaja. Contoh instrumen evaluasi tersebut antara lain lembar observasi perkembangan kesehatan fisik dan reproduksi, kuisioner pengetahuan kesehatan reproduksi, skala psikometrik untuk kesehatan mental seperti skala depresi Beck (BDI) atau skala kecemasan Hamilton (HAM-A), serta format wawancara terstruktur atau panduan konseling yang telah divalidasi. Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan bidan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai perubahan kondisi remaja selama dan setelah proses asuhan berlangsung.

Setelah proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen tersebut, hasil evaluasi harus didokumentasikan secara sistematis dan lengkap. Dokumentasi evaluasi meliputi pencatatan hasil observasi, hasil wawancara, maupun hasil kuisioner dan instrumen psikometrik yang digunakan. Dokumentasi yang baik sangat penting sebagai bukti autentik mengenai proses asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan, serta sebagai dasar untuk tindak lanjut asuhan berikutnya.

Dalam dokumentasi evaluasi ini, perlu dicatat secara jelas dan terperinci mengenai kondisi remaja sebelum, selama, dan setelah asuhan diberikan. Selain itu, dokumentasi juga harus mencatat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses implementasi asuhan. Informasi ini sangat berharga untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kendala

yang dialami selama proses asuhan berlangsung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang.

Selain dokumentasi, pelaporan evaluasi merupakan tahapan akhir yang tidak kalah penting dalam proses evaluasi asuhan kebidanan holistik. Pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan tertulis yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti keluarga, tim kesehatan, atau pihak lain yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada remaja. Laporan evaluasi tersebut biasanya mencakup deskripsi singkat tentang profil remaja, tujuan asuhan, intervensi yang diberikan, hasil evaluasi yang mencakup perubahan kondisi remaja berdasarkan indikator yang telah ditentukan, serta rekomendasi yang diperlukan untuk tindak lanjut atau intervensi lanjutan.

Pelaporan evaluasi ini tidak hanya menjadi dokumentasi penting yang menunjukkan akuntabilitas profesional dari bidan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi efektif untuk berbagai pihak terkait. Melalui laporan yang jelas, keluarga atau pihak lain dapat memahami secara komprehensif mengenai dampak asuhan yang telah diberikan, sehingga mereka dapat ikut mendukung dan melanjutkan proses pemeliharaan kesehatan remaja secara mandiri setelah proses asuhan formal selesai dilakukan oleh bidan.

I. Tantangan dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Holistik pada Remaja

Dalam pelaksanaan asuhan kebidanan holistik pada remaja, bidan sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini muncul baik dari faktor internal yang berasal dari diri remaja itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar remaja, seperti keluarga dan komunitas. Memahami tantangan ini secara menyeluruh sangat penting, karena tantangan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan, serta menentukan sejauh mana pelayanan tersebut berhasil memenuhi kebutuhan remaja secara utuh.

Faktor internal yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan asuhan holistik adalah sikap, keyakinan, dan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta berbagai aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam kehidupan mereka. Secara umum, masa remaja merupakan masa eksplorasi dan pencarian identitas diri yang sering kali diwarnai dengan perasaan bingung, rasa tidak percaya diri, maupun rasa ingin tahu yang besar. Di satu sisi, rasa ingin tahu ini positif karena mendorong remaja mencari informasi yang bermanfaat. Namun, di sisi lain, remaja sering kali memiliki sikap skeptis atau bahkan penolakan terhadap nasihat atau edukasi yang diberikan oleh orang dewasa, termasuk bidan. Selain itu, rasa malu, takut, atau khawatir terhadap stigma sosial juga membuat remaja

cenderung tertutup atau enggan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Remaja juga memiliki keyakinan yang beragam tentang isu-isu sensitif, seperti seksualitas, menstruasi, kesehatan mental, hingga penggunaan kontrasepsi. Keyakinan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, atau bahkan mitos yang berkembang di komunitasnya. Keyakinan yang keliru atau kurang tepat ini sering kali menghambat remaja untuk menerima asuhan yang diberikan. Selain itu, minimnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan asuhan. Remaja yang kurang informasi mungkin tidak memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi atau tidak mampu mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental, sehingga mereka terlambat mencari bantuan atau menolak layanan kesehatan yang tersedia.

Di samping tantangan internal, faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan komunitas juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asuhan kebidanan holistik pada remaja. Keluarga, sebagai lingkungan sosial terdekat, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional, fisik, serta sosial kepada remaja. Namun, tidak semua keluarga mampu memberikan dukungan yang memadai. Dalam beberapa kasus, keluarga justru menjadi hambatan karena kurangnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, adanya pola asuh otoriter, atau sikap orang tua yang tabu dalam membahas isu kesehatan reproduksi dan seksual. Kondisi ini menyebabkan remaja kesulitan dalam mengakses layanan atau edukasi yang seharusnya mereka terima.

Selain keluarga, komunitas atau lingkungan sosial yang lebih luas juga turut menjadi tantangan yang signifikan. Komunitas dengan norma sosial dan budaya yang konservatif sering kali menempatkan remaja dalam situasi sulit, di mana membicarakan isu-isu kesehatan reproduksi dianggap tidak pantas atau bahkan tabu. Dalam konteks demikian, remaja cenderung mendapatkan informasi yang kurang akurat, tertutup, dan bahkan takut memanfaatkan layanan kesehatan yang ada karena khawatir mendapat stigma negatif atau sanksi sosial dari komunitas mereka. Lingkungan yang tidak kondusif ini sangat mempengaruhi akses serta kualitas asuhan kebidanan yang diberikan kepada remaja.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam praktik asuhan kebidanan holistik pada remaja, dibutuhkan solusi yang integratif dan menyeluruh. Salah satu solusi penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi kesehatan yang ramah remaja, dengan pendekatan yang santai, komunikatif, serta tidak menghakimi. Edukasi ini perlu diberikan secara bertahap, berkelanjutan, serta disampaikan melalui bahasa yang mudah dipahami oleh remaja. Strategi edukasi ini dapat

memanfaatkan berbagai media, seperti brosur, video edukasi, aplikasi berbasis digital, atau program interaktif di sekolah dan komunitas. Dengan demikian, sikap skeptis dan kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan mental dapat dikurangi secara bertahap.

Selain itu, solusi lain yang tidak kalah penting adalah melibatkan keluarga secara aktif dalam proses asuhan kebidanan holistik. Bidan perlu berperan dalam memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dengan remaja serta dukungan emosional yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan remaja. Strategi ini dapat dilakukan melalui pertemuan keluarga secara rutin, konseling keluarga, atau seminar parenting yang mendidik orang tua tentang bagaimana mendampingi remaja secara efektif. Dengan melibatkan keluarga, remaja akan mendapatkan dukungan kuat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan secara holistik.

Pada level komunitas, upaya sosialisasi dan advokasi secara luas perlu dilakukan secara konsisten. Bidan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, sekolah, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), dapat mengembangkan program edukasi komunitas yang bertujuan untuk mengubah norma sosial yang membatasi akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi dan mental. Program-program ini harus dirancang secara sensitif, menghormati nilai-nilai budaya lokal, namun tetap mampu memberikan informasi yang benar, ilmiah, serta mendukung kesehatan remaja secara keseluruhan.

Selain pendekatan edukasi dan advokasi, kolaborasi interprofesional juga menjadi solusi penting dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan asuhan holistik. Bidan perlu menjalin kerja sama erat dengan profesional lain seperti psikolog, dokter, konselor, pekerja sosial, dan tokoh komunitas untuk memberikan layanan yang komprehensif dan saling mendukung. Dengan kolaborasi ini, layanan yang diberikan kepada remaja menjadi lebih efektif, terintegrasi, serta mampu mengatasi tantangan yang kompleks.

J. Simpulan

Asuhan kebidanan pada remaja secara holistik merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan integratif, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik atau klinis semata, tetapi juga meliputi dimensi psikologis, emosional, sosial, budaya, dan spiritual yang saling berkaitan. Pendekatan ini sangat relevan mengingat masa remaja merupakan periode transisi penting yang penuh perubahan fisik maupun emosional yang kompleks, sehingga remaja membutuhkan dukungan khusus dalam menjalani fase perkembangan tersebut.

Pendekatan holistik memiliki konsep dasar bahwa setiap remaja adalah individu unik yang tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus mampu memahami berbagai karakteristik khusus remaja secara menyeluruh, mulai dari perkembangan fisik dan reproduksi, kondisi emosional dan psikologis, hingga situasi sosial, budaya, dan spiritual yang mereka alami. Dalam pendekatan ini, bidan tidak hanya bertugas sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mampu mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan yang tepat kepada remaja secara empatik dan sensitif.

Pengkajian holistik pada remaja menjadi fondasi penting dalam praktik asuhan kebidanan. Melalui pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek kehidupan remaja, bidan dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka secara tepat. Proses identifikasi ini mencakup kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksual, kebutuhan kesehatan mental dan psiko-emosional, serta kebutuhan sosial, budaya, dan spiritual. Identifikasi kebutuhan yang tepat akan membantu bidan dalam menyusun perencanaan asuhan yang terpadu, kolaboratif, dan partisipatif bersama remaja serta keluarganya.

Implementasi asuhan kebidanan holistik mencakup pelaksanaan intervensi yang nyata, baik dalam bidang kesehatan reproduksi seperti pemberian edukasi, konseling, dan layanan kesehatan yang ramah remaja, maupun dalam bidang dukungan psikososial untuk menjaga kesehatan mental dan emosional mereka. Di samping itu, intervensi sosial dan spiritual juga dilakukan untuk membantu remaja memperoleh dukungan penuh dari keluarga, lingkungan sosial, serta komunitas tempat mereka tinggal, sehingga mereka mampu menemukan makna hidup yang positif dan memiliki ketahanan batin yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Evaluasi secara holistik juga merupakan tahapan krusial untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang diberikan. Melalui indikator keberhasilan yang jelas serta teknik dan instrumen evaluasi yang tepat, efektivitas dari asuhan kebidanan holistik dapat diketahui secara objektif. Dokumentasi dan pelaporan yang sistematis turut menjadi bagian integral yang memastikan asuhan ini dapat terus berkembang dan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hidup remaja secara menyeluruh.

Pelaksanaan asuhan kebidanan holistik pada remaja tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal remaja sendiri, seperti sikap, keyakinan, dan pengetahuan mereka yang terbatas, maupun faktor eksternal dari lingkungan keluarga dan komunitas yang sering kali memiliki nilai dan norma yang tabu terhadap isu kesehatan reproduksi dan mental. Untuk itu, pendekatan edukatif yang ramah remaja, peningkatan peran aktif keluarga, advokasi komunitas,

serta kolaborasi interprofesional menjadi solusi penting yang perlu terus dikembangkan.

K. Referensi

- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Cherry, B., & Jacob, S. R. (2018). *Contemporary Nursing: Issues, Trends, & Management* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Craven, R. F., Hirnle, C. J., & Henshaw, C. (2019). *Fundamentals of Nursing: Human Health and Function* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Falvo, D. R. (2019). *Effective Patient Education: A Guide to Increased Adherence* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Kolcaba, K. (2003). *Comfort Theory and Practice: A Vision for Holistic Health Care and Research*. Springer Publishing Company.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K., & Ashwill, J. (2017). *Maternal-Child Nursing* (5th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2019). *Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing* (7th ed.). Saunders Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Santrock, J. W. (2020). *Adolescence* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2021). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2019). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health.
- World Health Organization. (2014). *Health for the World's Adolescents: A second chance in the second decade*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *Adolescent mental health*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

L. Glosarium

Adolescence (Remaja)

Periode transisi antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, sosial, emosional, budaya, dan spiritual yang kompleks.

Asuhan Kebidanan Holistik

Pendekatan pelayanan kebidanan yang komprehensif, utuh, dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, budaya, dan spiritual secara terintegrasi dalam perawatan remaja.

Bullying

Perilaku agresif dan intimidatif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok tertentu terhadap seseorang, yang menyebabkan dampak negatif baik secara fisik maupun emosional.

Depresi

Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, kelelahan, perubahan pola tidur dan makan, serta perasaan putus asa yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Identitas Diri

Konsep atau persepsi seseorang tentang siapa dirinya yang berkembang secara signifikan pada masa remaja, mencakup nilai-nilai, kepercayaan, tujuan hidup, dan peran sosial.

Intervensi Klinis

Tindakan medis atau kebidanan yang bertujuan mengatasi gangguan kesehatan tertentu secara langsung, misalnya pemeriksaan fisik, pemberian obat, atau prosedur medis lainnya.

Intervensi Psikososial

Pendekatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis, emosional, dan sosial, seperti konseling, terapi kelompok, serta dukungan emosional.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama antarprofesi kesehatan, seperti bidan, dokter, psikolog, konselor, pekerja sosial, ahli gizi, maupun tokoh masyarakat, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi kepada remaja.

Komunikasi Terapeutik

Proses komunikasi yang dilakukan secara empatik, penuh perhatian, terbuka, serta sensitif untuk membangun hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien, khususnya remaja.

Kesehatan Mental Remaja

Kondisi psikologis dan emosional remaja yang sehat, yang ditandai dengan kemampuan mengelola stres, emosi, menjalin hubungan sosial positif, serta mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Menarche

Menstruasi pertama kali pada remaja perempuan, menandakan awal kematangan sistem reproduksi dan fase pubertas.

Pendekatan Partisipatif

Metode pemberian asuhan yang melibatkan secara aktif remaja dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, sehingga remaja merasa dihargai, didengar, serta memiliki tanggung jawab dalam proses asuhan yang diberikan.

Pengkajian Holistik

Proses pemeriksaan atau pengumpulan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi fisik, psikologis, emosional, sosial, budaya, serta spiritual seorang remaja untuk menentukan intervensi kesehatan yang tepat.

Pubertas

Periode perkembangan biologis pada remaja yang ditandai dengan kematangan sistem reproduksi serta munculnya ciri-ciri seksual sekunder seperti menstruasi, perubahan bentuk tubuh, pertumbuhan cepat, dan perubahan suara.

Spiritualitas

Aspek dalam kehidupan manusia yang mencakup pencarian makna hidup, tujuan, nilai-nilai, dan hubungan pribadi dengan sesuatu yang lebih besar (misalnya Tuhan, moralitas, atau nilai universal), yang memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup.

Stigma Sosial

Pandangan atau sikap negatif yang dilekatkan kepada seseorang atau kelompok tertentu, yang menyebabkan individu merasa malu, terasing, atau takut dalam mencari bantuan, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi dan mental remaja.

Tekanan Sosial

Tuntutan, ekspektasi, atau pengaruh yang berasal dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, maupun masyarakat yang menyebabkan remaja mengalami stres atau perilaku berisiko.

Transisi Masa Remaja

Proses peralihan yang dialami remaja dari status anak-anak menjadi dewasa, yang melibatkan berbagai perubahan signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan individu.

Privasi dan Kerahasiaan

Prinsip penting dalam pemberian asuhan kebidanan yang melindungi hak remaja untuk menjaga informasi pribadi tetap rahasia, menciptakan rasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan masalah kesehatan mereka.

CHAPTER 2

KONSEP HOLISTIK PADA MASA PRA KONSEPSI DAN KEHAMILAN

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Masa pra konsepsi dan kehamilan merupakan periode yang sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan, status gizi, serta kesiapan fisik dan psikologis seorang perempuan sebelum hamil memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kehamilan, proses persalinan, dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perhatian tidak hanya difokuskan pada masa kehamilan, tetapi juga pada periode pra konsepsi sebagai fase persiapan yang menentukan. (World Health Organization, 2022)



Gambar 2,1: Kesehatan Ibu Hamil - Perumperindo.co.id

Masa pra konsepsi merupakan periode kritis yang berlangsung sebelum terjadinya pembuahan, yakni saat ovum dan sperma matang, idealnya sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Pada periode ini, dilakukan persiapan yang meliputi identifikasi dan modifikasi risiko biomedis, mekanis, dan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan wanita maupun pasangan usia subur yang berencana untuk hamil. Konsep holistik dalam asuhan kebidanan pada masa pra konsepsi dan kehamilan mengedepankan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang menyatukan aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual guna mendukung kesehatan ibu dan calon bayi secara menyeluruh.(Jaya, 2019)

Pendekatan kesehatan modern menekankan pentingnya konsep holistik, yaitu melihat individu sebagai satu kesatuan yang utuh, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan. Dalam konteks pra konsepsi dan kehamilan, konsep holistik mengarahkan intervensi bukan hanya pada aspek medis seperti pemeriksaan kesehatan dan nutrisi, tetapi juga pada keseimbangan mental-emosional, dukungan keluarga, kesiapan spiritual, serta faktor lingkungan yang mendukung tercapainya kehamilan sehat.(Hidayati & Farah, 2023)

Kesehatan reproduksi ibu tidak dapat dipisahkan dari faktor gaya hidup, status ekonomi, budaya, hingga lingkungan sosial. Misalnya, kecukupan nutrisi dan pencegahan anemia pada masa pra konsepsi akan menentukan perkembangan organ janin pada trimester pertama, sementara kesiapan psikologis ibu akan memengaruhi adaptasi terhadap perubahan fisiologis selama kehamilan. Selain itu, nilai-nilai spiritual dan budaya dapat menjadi sumber kekuatan serta strategi koping bagi ibu dalam menghadapi dinamika kehamilan.(Rangkuti et al., 2019)

Pendekatan holistik ini mencakup pengkajian data subyektif dan objektif, analisis, perencanaan, dan implementasi asuhan kebidanan berbasis bukti (evidence-based practice) dengan melibatkan keluarga dan dilakukan melalui kolaborasi lintas profesi. Upaya promotif dan preventif sangat ditekankan mulai dari masa pra konsepsi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan hasil kehamilan yang optimal.

Kesehatan ibu pada masa pra konsepsi sangat ditentukan oleh status gizi dan pola hidup sehat selama masa ini, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi bayi yang akan lahir. Selain itu, kesiapan psikologis dan sosial calon ibu dan keluarga juga ditekankan sebagai bagian dari pendekatan holistik sehingga kehamilan dapat direncanakan dengan baik dan proses kehamilan berlangsung secara optimal.

Dengan demikian, penerapan konsep holistik pada masa pra konsepsi dan kehamilan bukan hanya fokus pada aspek medis semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan psikososial dan kebudayaan yang menyeluruh, mendukung kesehatan ibu, janin, serta keluarganya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

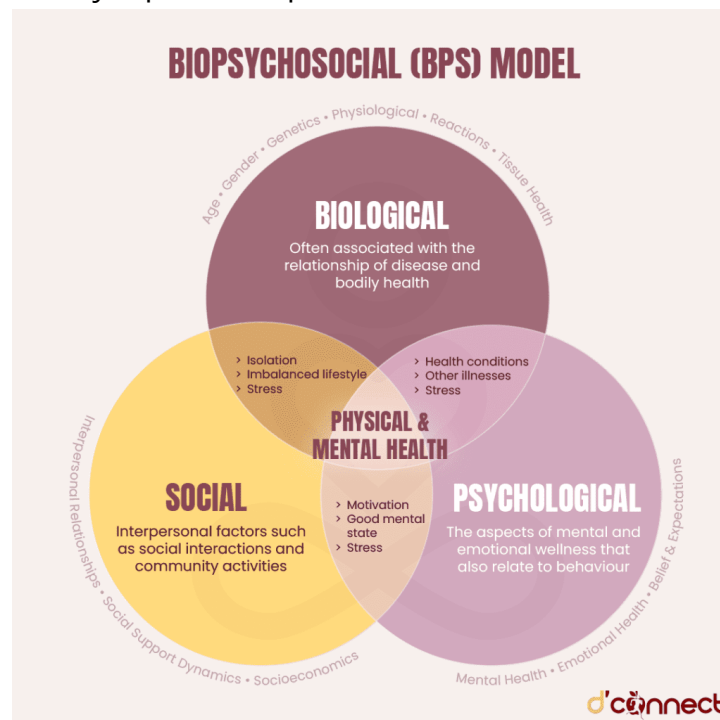
B. Konsep Holistik pada masa Pra Konsepsi

Periode pra-konsepsi (≥ 3 –6 bulan sebelum konsepsi) adalah jendela emas untuk memodifikasi faktor biologis, perilaku, psikososial, lingkungan, dan spiritual yang akan menentukan kualitas kehamilan serta kesehatan jangka panjang anak. Konsultasi teknis WHO (2024–2025) menegaskan kebutuhan “reframing” layanan ke arah model pra-konsepsi yang terintegrasi lintas sektor—bukan hanya paket klinis, tetapi juga dukungan perilaku, sosial, dan kebijakan publik (World Health Organization, 2020).

Perawatan pra-konsepsi adalah intervensi kesehatan yang diberikan kepada individu atau pasangan sebelum kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mereka dan mempromosikan hasil yang baik bagi ibu dan bayi. Pendekatan holistik dalam perawatan ini mencakup berbagai aspek kesehatan, termasuk fisik, mental, sosial, dan spiritual, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi konsepsi dan perkembangan janin.

1. Kerangka Holistik: Bio-Psycho-Social-Spiritual-Environmental (BPSSE)

Pendekatan holistik memadukan lima ranah berikut yang saling berinteraksi dan harus dinilai sejak pra-konsepsi:

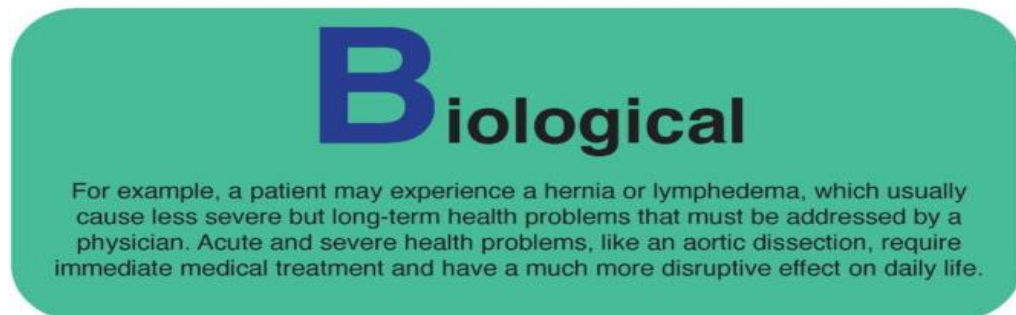


Gambar 2.2: Three Aspects of Health and Healing: The Biopsychosocial Model in Medicine | Department of Surgery | Washington University in St. Louis

Model biopsikososial (BPS) tentang kesehatan dan kedokteran mempelajari bagaimana tiga aspek – biologis, psikologis, dan sosial – berperan dalam

kesehatan atau penyakit seseorang. Model ini menekankan keterkaitan erat antara ketiga faktor tersebut.

a. Biologis (bio-)

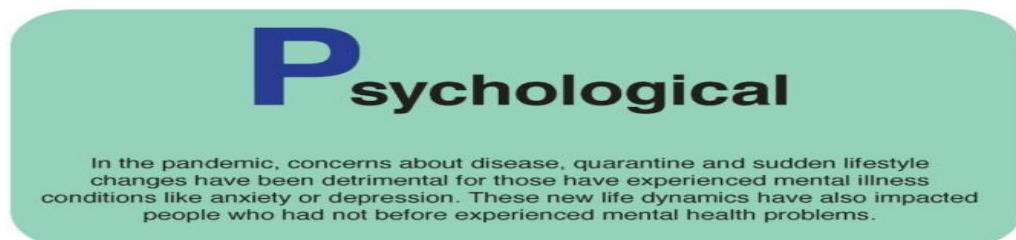


Gambar 2.3: Three Aspects of Health and Healing: The Biopsychosocial Model in Medicine | Department of Surgery | Washington University in St. Louis

- 1) Berkaitan dengan hubungan antara penyakit dan kondisi tubuh.
- 2) Contoh: pasien mengalami hernia atau limfedema, yang biasanya menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang namun kurang parah dan perlu ditangani oleh dokter.
- 3) Masalah kesehatan yang akut dan serius, seperti diseksi aorta, memerlukan penanganan medis segera dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari.
- 4) Kesehatan fisik dan reproduksi: pemeriksaan medis, status gizi, imunisasi, dan deteksi penyakit kronis atau genetik.
- 5) Gaya hidup sehat: olahraga, pola makan seimbang, menghindari alkohol, rokok, dan zat berbahaya.
- 6) Kesiapan reproduksi: perencanaan kehamilan, mengatur ovulasi, serta konsultasi pra-konsepsi.

Contoh: Seorang calon ibu dengan anemia perlu suplemen zat besi sebelum hamil agar mencegah komplikasi selama kehamilan.

b. Psikologis (-psycho-)



Gambar 2.4: Three Aspects of Health and Healing: The Biopsychosocial Model in Medicine | Department of Surgery | Washington University in St. Louis

- 1) Berkaitan dengan kesehatan mental dan emosional, termasuk perilaku.

- 2) Contoh: selama pandemi, kekhawatiran tentang penyakit, karantina, dan perubahan gaya hidup secara mendadak berdampak buruk bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi.
- 3) Perubahan hidup ini juga memengaruhi orang yang sebelumnya tidak memiliki masalah mental.
- 4) **Kesehatan mental dan emosi:** kesiapan mental untuk menjadi orang tua, manajemen stres, dan coping terhadap perubahan hidup.
- 5) **Edukasi dan kesadaran diri:** pemahaman tentang risiko kesehatan, kehamilan sehat, dan persiapan mental menghadapi peran baru.
- 6) **Dukungan psikologis:** konseling pra-kehamilan bagi pasangan yang cemas atau memiliki riwayat gangguan mental.

Contoh: Pasangan yang pernah mengalami keguguran dapat membutuhkan dukungan psikologis untuk mengurangi kecemasan pada kehamilan berikutnya.

c. Sosial (-social)



Gambar 2.5: Three Aspects of Health and Healing: The Biopsychosocial Model in Medicine | Department of Surgery | Washington University in St. Louis

- 1) Berkaitan dengan faktor interpersonal, seperti interaksi sosial dan kegiatan komunitas.
- 2) Isolasi, baik yang disengaja maupun akibat penyakit yang membatasi aktivitas, merugikan kemampuan seseorang untuk bersosialisasi atau menjaga hubungan yang sehat di luar rumah.
- 3) Kekurangan interaksi sosial dapat menyebabkan rasa kesepian dan gaya hidup yang tidak seimbang.
- 4) Dukungan keluarga dan pasangan: keterlibatan suami/partner dalam perencanaan kehamilan dan gaya hidup sehat.
- 5) Lingkungan sosial dan komunitas: akses ke layanan kesehatan, kelompok pendukung, dan edukasi pra-konsepsi di komunitas.
- 6) Faktor budaya dan ekonomi: norma sosial, agama, pekerjaan, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kesiapan kehamilan.

Contoh: Calon ibu yang mendapatkan dukungan keluarga dalam nutrisi dan kegiatan sehat cenderung lebih siap menghadapi kehamilan.

Model BPS menekankan bahwa kesehatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh kesehatan mental dan kualitas hubungan sosial. Semua aspek ini saling memengaruhi, sehingga perawatan kesehatan yang efektif sebaiknya mempertimbangkan ketiganya secara bersamaan. Model BPS menekankan interaksi dinamis antara aspek biologis, psikologis, dan sosial:

- Misalnya, stres (psikologis) dapat memengaruhi siklus menstruasi (biologis) dan motivasi untuk menjalani pemeriksaan pra-konsepsi (sosial).
- Dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan calon ibu terhadap suplemen dan pola hidup sehat.

d. Biomedis & Nutrisi

- 1) Mikronutrien kunci. WHO merekomendasikan asam folat 400 µg/hari sejak mulai merencanakan kehamilan hingga 12 minggu untuk mencegah cacat tabung saraf. Suplementasi Fe/FA harian pada kehamilan dan program Fe-FA untuk remaja/wanita di setting anemia tinggi juga ditekankan sebagai kesinambungan dari upaya pra-konsepsi. Diskusi terkini menempatkan multiple micronutrient supplements (MMS) sebagai opsi yang menjanjikan (penurunan LBW/SGA), dengan catatan konteks riset imple-mentasi.(World Health Organization, 2025)
- 2) Intervensi diet & gaya hidup. Telaah 2025 menunjukkan intervensi gizi/lifestyle pra-konsepsi dapat memperbaiki pola makan, aktivitas fisik, dan berat pra-hamil—faktor yang terkait kelahiran janin lebih baik. Fokusnya bukan hanya “apa” yang diberikan, tapi bagaimana (teknik perubahan perilaku/BCTs) intervensi dirancang.(Barbosa et al., 2019)



Gambar 2.6: Makanan yang baik dikonsumsi dan dihindari bumil

<https://id.pinterest.com/pin/70437485676014/>

- 3) Bukti regional. Ulasan 2025 di Asia Selatan merangkum efek intervensi nutrisi pra-konsepsi terhadap luaran kehamilan, menyorot pentingnya kebijakan dan program berskala populasi (Amstutz, 2020)

e. Psikologis & Kesehatan Mental

Kecemasan, depresi, dan stres pra/antenatal memengaruhi kepatuhan, kualitas hubungan, bahkan lama persalinan. Bukti baru mendukung **yoga kehamilan** dan **hypnobirthing/hypnotherapy** sebagai terapi non-farmakologis yang menurunkan stres, kecemasan, dan memperbaiki kesiapan melahirkan—relevan dimulai sejak pra-konsepsi sebagai pembiasaan coping. (Askar, 2024)



Gambar 2.7: Kata Kata Untuk Kesehatan Mental - Perumperindo.co.id

f. Perilaku & Edukasi Kesehatan

Ulasan sistematis terbaru menegaskan intervensi perubahan perilaku pra-konsepsi (skrining, konseling, edukasi) meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku sehat, dan beberapa indikator biometrik; intervensi digital (kursus hipnosis daring) juga menjanjikan untuk skala luas (Umaroh & Karjoso, 2021)

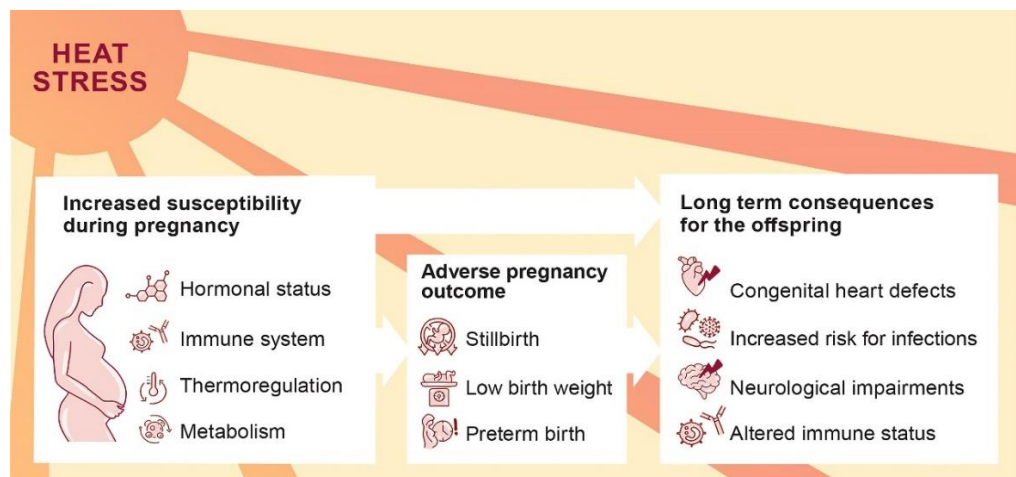
g. Sosial & Budaya (termasuk pasangan & keluarga)

Data 2025 menunjukkan tingginya beban faktor risiko pra-konsepsi yang bersifat medis-perilaku-sosial, sehingga layanan primer perlu mengintegrasikan penilaian determinan sosial (dukungan pasangan, pekerjaan, pendidikan, keamanan pangan). Pendekatan berpusat keluarga dan

sensitif budaya meningkatkan keterlibatan dan keberlanjutan perubahan perilaku.(Rahman & Abdullah, 2024)

h. Lingkungan & Iklim

Pemaparan polusi udara dan campuran pestisida sebelum konsepsi terkait cacat bawaan, LBW, dan komplikasi kehamilan; literatur terbaru juga menyorot manfaat ruang hijau. Konseling pra-konsepsi perlu memasukkan mitigasi paparan (ventilasi/HEPA, hindari asap rokok & area berpolusi tinggi, kewaspadaan pestisida)(WHO, 2020)



Gambar 2.8: Frontiers | Climate change and pregnancy complications: From hormones to the immune response

Ibu hamil lebih rentan mengalami dampak buruk dari paparan panas berlebih (misalnya cuaca ekstrem atau suhu tinggi), yang tidak hanya memengaruhi proses kehamilan (seperti risiko komplikasi), tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan janin/anak di kemudian hari.

2. Prioritas Intervensi Pra-Konsepsi (Ringkas & Praktis)

- Optimasi status gizi & anemia: skrining Hb, IMT, diet seimbang; FA 400 µg/hari saat mulai merencanakan hamil; evaluasi kebutuhan Fe/MMS sesuai konteks.(World Health Organization, 2025)
- Perubahan perilaku bertahap: modul edukasi berlandas BCTs (goal-setting, self-monitoring, problem-solving) untuk diet, aktivitas fisik, berhenti merokok/alkohol, tidur, dan manajemen stres.(Torkel et al., 2024)
- Kesehatan mental & kesiapan persalinan: program yoga prenatal/tele-yoga, relaksasi, hypnobirthing/hypnotherapy; skrining risiko psikologis sejak pra-konsepsi.(Ganjekar et al., 2024)

- d. Mitigasi paparan lingkungan: kurangi polusi (masking/HEPA, pantau AQI), hindari pestisida rumah tangga, dorong paparan ruang hijau.(Tika et al., 2022)
- e. Konteks Indonesia—integrasi program: gunakan pendampingan calon pengantin (Catin) dan aplikasi ELSIMIL untuk skrining risiko (IMT, LILA, anemia), konseling gizi, serta rujukan dini—sebagai jembatan dari pra-konsepsi ke hamil.(BKKBN, 2021)

3. Bukti Terkini yang Memperkuat Pendekatan Holistik

a. Nutrisi & Suplemen

- 1) Folat pra/perikonsepsi: rekomendasi WHO terbaru (ELENA) tetap konsisten—efektif mencegah NTD; mudah diimplementasikan pada tingkat populasi
- 2) MMS vs Fe/FA: ringkasan WHO menunjukkan penurunan SGA (~10%), LBW, dan stillbirth dengan MMS; pemilihan perlu mempertimbangkan ketersediaan, biaya, dan keselarasan panduan nasional.
- 3) Intervensi pra-konsepsi: telaah 2025 (South Asia & global) menegaskan potensi peningkatan luaran jika intervensi dilakukan sebelum pembuahan, termasuk untuk berat lahir.

b. Kesehatan Mental & Mind-Body

Yoga kehamilan (termasuk tele-yoga) dan hypnobirthing/hypnotherapy menunjukkan penurunan stres, kecemasan, dan perbaikan ekspektasi serta regulasi HPA axis; cocok sebagai kebiasaan pra-konsepsi yang dibawa ke fase antenatal.(Ningrum, N. P., Andarwulan, S., & Rihardini, 2022)

c. Lingkungan

Polusi udara pra-konsepsi berkorelasi dengan berbagai luaran buruk (cacat bawaan paling konsisten) menurut ulasan 2022; studi 2024–2025 memperkuat asosiasi dengan LBW dan menyorot risiko campuran pestisida (Huang, 2019).

4. Implementasi Layanan: Dari Klinik ke Komunitas

- a. Desain layanan: WHO menyerukan integrasi pra-konsepsi ke layanan primer, kesehatan remaja, dan program keluarga—diperkuat sistem rujukan, pencatatan digital, serta konseling berbasis bukti. (World Health Organization, 2020)
- b. Indonesia: pemanfaatan TPK (Tim Pendamping Keluarga), kelas Catin, dan ELSIMIL untuk skrining dini (IMT, LILA, anemia, perilaku), KIE gizi & KB, serta rencana kehamilan—sudah selaras dengan kerangka holistik.

5. Rekomendasi Praktik (Checklist Pra-Konsepsi)

- a. **Asesmen terpadu BPSSE:** status gizi (IMT, Hb), penyakit kronis, obat/suplemen; skrining depresi/kecemasan; dukungan pasangan/keluarga; audit paparan lingkungan rumah/kerja. British Journal of General Practice World Health Organization
- b. **Intervensi berlapis:** FA 400 µg/hari; konseling diet + BCTs; rencana aktivitas fisik; paket **yoga/hypnobirthing**; rencana berhenti merokok/alkohol; strategi mitigasi polusi/pestisida. World Health Organization Oxford Academic Lippincott MDPI PMC
- c. **Tautan ke program nasional:** gunakan jalur Catin/ELSIMIL, libatkan bidan/PKK/Kader KB, rujuk bila risiko tinggi (anemia, gizi kurang, distress psikologis, paparan toksik).

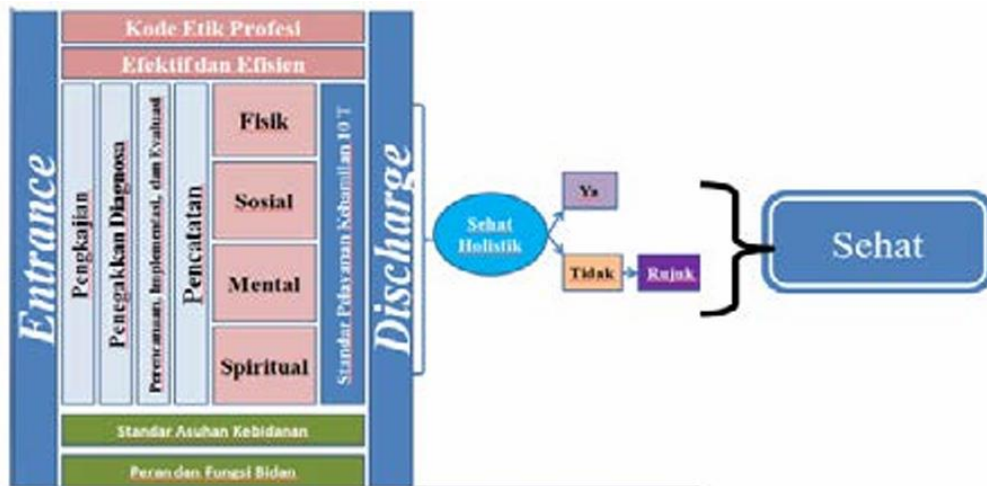
C. Konsep Holistik pada masa Kehamilan

1. Latar Belakang

Kehamilan adalah proses biologis yang dipengaruhi kuat oleh kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan: status gizi, penyakit kronis, kondisi psikososial, lingkungan fisik, dan dukungan sosial. Pendekatan holistik melihat ibu dan janin sebagai kesatuan yang dimediasi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan — yang semuanya saling memengaruhi hasil kehamilan dan kesehatan jangka panjang anak. WHO menekankan perawatan antenatal yang “berpusat pada wanita” dan pengalaman kehamilan yang positif, menggabungkan intervensi klinis dengan dukungan psikososial dan edukasi (Garcia et al., 2022).

2. Kerangka Konseptual: Pendekatan Holistik untuk Kehamilan

Gunakan kerangka BPSSE: Biologis — Psikologis — Sosial — Spiritual — Environmental. Setiap domain memiliki indikator penilaian, intervensi yang terbukti, dan titik rujukan untuk kolaborasi lintas profesi (dokter, bidan, psikolog, pekerja sosial, ahli gizi, pemerhati lingkungan).



Gambar Model Konseptual Pelayanan Kebidanan Holistik (Hasil FGD)

Gambar 2.9: kerangka BPSSE: Biologis — Psikologis — Sosial — Spiritual — Environmental (Tasikmalaya et al., 2022)

a. Biologis

1) Indikator Penilaian

- Status gizi ibu hamil (IMT, lingkaran lengan atas, hemoglobin)
- Kondisi kesehatan ibu (penyakit penyerta, riwayat obstetri).
- Pertumbuhan dan perkembangan janin (USG, detak jantung janin).

2) Intervensi Terbukti

- Antenatal care (ANC) sesuai standar.
- Suplementasi zat besi, kalsium, asam folat.
- Pencegahan komplikasi (preeklampsia, anemia, diabetes gestasional).

3) Titik Rujukan Kolaborasi

- Dokter spesialis obgyn dan penyakit dalam.
- Bidan untuk ANC primer dan persalinan normal.
- Ahli gizi untuk perencanaan diet seimbang.

b. Psikologis

1) Indikator Penilaian

- Tingkat kecemasan, stres, dan depresi kehamilan.
- Kesiapan menjadi ibu, persepsi diri.
- Kualitas tidur dan pola aktivitas harian.

2) Intervensi Terbukti

- Konseling psikologi perinatal.
- Teknik relaksasi (pernapasan, meditasi).
- Dukungan kelompok ibu hamil (*support group*).

3) Titik Rujukan Kolaborasi

- **Psikolog** klinis untuk skrining depresi/ansietas.
- **Bidan** untuk konseling dasar.

- **Keluarga** sebagai pendukung utama.

c. Sosial

1) Indikator Penilaian

- Dukungan keluarga dan pasangan.
- Status ekonomi dan akses pelayanan kesehatan.
- Jaringan sosial (komunitas ibu hamil, posyandu).

2) Intervensi Terbukti

- Program kelas ibu hamil.
- Edukasi pasangan & keluarga tentang peran dalam kehamilan.
- Bantuan sosial bagi ibu hamil kurang mampu.

3) Titik Rujukan Kolaborasi

- Pekerja sosial untuk pendampingan dan akses bantuan.
- Bidan/dokter untuk koordinasi program pemerintah (mis. BPJS, PKH).
- Komunitas/NGO peduli ibu dan anak.

d. Spiritual

1) Indikator Penilaian

- Kebutuhan spiritual dan praktik ibadah.
- Sikap menerima kehamilan sebagai anugerah.
- Peran nilai agama dalam menghadapi kecemasan.

2) Intervensi Terbukti

- Pendampingan rohani sesuai keyakinan ibu.
- Terapi doa / dzikir / mindfulness berbasis spiritualitas.
- Dukungan tokoh agama dalam penguatan mental.

3) Titik Rujukan Kolaborasi

- Rohaniawan
- Psikolog untuk integrasi spiritual-psikologis.
- Bidan/dokter sebagai fasilitator pendekatan holistik.

D. Referensi

- Amstutz, A. (2020). Home-based oral self-testing for absent and declining individuals during a door-to-door HIV testing campaign in rural Lesotho (HOSENG): a cluster-randomised trial. *The Lancet HIV*, 7(11). [https://doi.org/10.1016/S2352-3018\(20\)30233-2](https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30233-2)
- Askar, M. (2024). *Efektivitas Intervensi Non-Farmakologis dalam Mengurangi Nyeri Haid: Sebuah Studi Literatur*. XIX(2), 296–303.
- Barbosa, O. A., Teles, F. M., Maia, A. C. C., & ... (2019). Disseminated hematogenous tuberculosis in puerperium—case report. *Oxford Medical Case* <https://academic.oup.com/omcr/article-abstract/2019/11/479/5670820>
- BKKBN. (2021). Pendampingan Keluarga bagi Calon Pengantin. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 1–35. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Ganjekar, S., Harve, V. S., Bhargav, H., Kukreti, P., Dere, S., Thukral, U., Thamke, P., Puri, M., & Krishnamurthy, M. N. (2024). The Pregnancy Tele-yoga Module to Combat Stress, Anxiety, and Depression Associated with Pregnancy: An Exploratory Open-label Multicentric Study. *International Journal of Yoga*, 17(1), 46–52. https://doi.org/10.4103/ijoy.ijoy_1_24
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2022). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.
- Hidayati, R., & Farah, S. (2023). Model Kelas Persiapan Persalinan secara Holistik. *Journal of Telenursing (JOTING)*.
- Huang, K. (2019). Prevalence, risk factors, and management of asthma in China: a national cross-sectional study. *The Lancet*, 394(10196), 407–418. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31147-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31147-X)
- Jaya, M. (2019). Umi medical journal. *UMI Medical Journal*, 4(1), 117–129.
- Ningrum, N. P., Andarwulan, S., & Rihardini, T. (2022). Soft Prenatal Yoga Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil Di Wilayah Keputran Surabaya. *Locus Abdimas*, 1(1), 113–118. <https://journal.tritunas.ac.id/index.php/LoA/article/view/55>
- Rahman, F., & Abdullah, R. (2024). Faith, culture, and environment in holistic preconception care: An integrative approach. *Global Health Research and Policy*, 9(14). <https://doi.org/10.1186/s41256-024-00345-w>
- Rangkuti, L. F., Sanusi, S. R., & Lutan, D. (2019). Penyakit Ibu Terhadap Kejadian Abortus Imminens Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i1.1793>
- Tasikmalaya, P. K., Suptiani, L. P., & Sunjaya, D. K. (2022). *Model Konseptual Pelayanan Kebidanan Holistik pada Ibu Hamil di Bidan Praktik Mandiri*

Kabupaten Garut Conceptual Model of Holistic Midwifery Services in Pregnant Women at Midwives Independent Practice in Garut. 4(35), 84–89.

- Tika, T. T., Sidharti, L., Himayani, R., & Rahmayani, F. (2022). Metode ERACS Sebagai Program Perioperatif Pasien Operasi Caesaragus. *Jurnal Medika Utama, 03(02)*, 2386–2391.
- Torkel, S., Mantzioris, E., Villani, A., Kellow, N., Bhatnagar, D., Osei-Safo, E., McGowan, M., Jafar, N. A., Bogatzke, N., Alesi, S., Astarcioglu, T., Ben Mol, Norman, R. J., Cowan, S., Wang, R., & Moran, L. (2024). Preconception lifestyle interventions for women – a systematic review and meta-analysis of intervention characteristics and behaviour change techniques. *Obesity Research & Clinical Practice, 18(5)*, S41–S42. <https://doi.org/10.1016/j.orcp.2024.09.094>
- Umaroh, A. K., & Karjoso, T. K. (2021). KOMUNIKASI KESEHATAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL KOMPREHENSIF (Studi di Youth Center Pilar Jawa Tengah). *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(1)*, 210–227. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i1.1530>
- WHO. (2020). *Asthma*. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/asthma>
- World Health Organization. (2020). *WHO recommendations on preconception care: Policy brief*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240002319>
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.
- World Health Organization. (2025). *WHO maternal and perinatal health guidelines now available interactively on MAGICapp*.

CHAPTER 3

ASUHAN KEBIDANAN HOLISTIK MASA NIFAS

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan selama masa nifas memiliki arti yang sangat mendalam dan penting, mengingat masa nifas adalah periode transisi yang penuh tantangan bagi seorang ibu setelah melahirkan. Masa nifas berlangsung selama kurang lebih enam minggu setelah persalinan, di mana tubuh seorang ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis yang sangat signifikan. Perubahan tersebut meliputi proses pemulihan organ reproduksi, keseimbangan hormonal, adaptasi sistem tubuh secara keseluruhan, serta adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat menyeluruh, atau holistik, sangat diperlukan agar setiap kebutuhan ibu nifas bisa terpenuhi dengan optimal.

Pendekatan holistik berarti bahwa asuhan kebidanan tidak hanya fokus pada satu aspek tertentu seperti kesehatan fisik saja, melainkan juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Semua aspek ini saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga pendekatan yang hanya parsial tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ibu secara menyeluruh. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesehatan ibu nifas tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisiknya saja, melainkan juga oleh kondisi mental, emosional, hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, serta keyakinan spiritual yang ia miliki.

Pada aspek kesehatan fisik, asuhan kebidanan holistik bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulihan organ-organ reproduksi pasca persalinan berlangsung secara optimal, termasuk involusi rahim, penyembuhan luka-luka pada jalan lahir, hingga pemulihan keseimbangan hormonal. Dalam konteks ini, bidan berperan dalam melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi ibu, memberikan edukasi tentang tanda-tanda normal dan abnormal, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan lain yang mungkin terjadi selama masa nifas. Selain itu, bidan juga bertugas memastikan bahwa ibu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menunjang pemulihan fisiknya, terutama untuk mendukung proses menyusui.

Selain aspek fisik, pendekatan holistik juga sangat memperhatikan kondisi psikologis dan emosional ibu nifas. Masa setelah melahirkan sering kali membawa

berbagai tekanan emosional, seperti kecemasan akan tanggung jawab baru, perasaan tidak percaya diri dalam merawat bayi, kelelahan fisik yang berakumulasi, hingga gangguan emosional yang lebih serius seperti baby blues atau depresi postpartum. Dalam hal ini, peran bidan menjadi sangat krusial dalam memberikan dukungan emosional yang kuat kepada ibu. Bidan tidak hanya memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, tetapi juga secara aktif melakukan konseling atau pendampingan psikologis. Kehadiran bidan sebagai sosok yang dapat dipercaya, empati, dan penuh perhatian memberikan rasa nyaman dan aman kepada ibu, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan mentalnya.

Dalam konteks sosial, seorang ibu yang baru melahirkan tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungannya. Kualitas hubungan sosial dan dukungan yang diterima ibu dari keluarga maupun komunitasnya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pemulihan pada masa nifas. Asuhan kebidanan holistik memberikan perhatian besar terhadap aspek sosial ini, di mana bidan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ibu nifas mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Bidan berperan aktif dalam mengedukasi keluarga mengenai pentingnya dukungan yang positif, termasuk membantu keluarga memahami kebutuhan khusus ibu selama masa nifas. Keterlibatan keluarga yang positif dan proaktif mampu meningkatkan kualitas hidup ibu, mengurangi stres, serta mempercepat pemulihan baik fisik maupun psikologis.

Selanjutnya, aspek spiritual juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam pendekatan holistik ini. Setiap individu memiliki keyakinan dan nilai spiritual yang berbeda-beda, dan hal ini sering kali menjadi sumber kekuatan emosional yang besar bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan. Bidan, dalam memberikan asuhan holistik, perlu menghormati dan memahami nilai-nilai spiritual yang dianut oleh ibu nifas. Bidan juga berperan dalam mendorong ibu untuk menggunakan keyakinan spiritualnya sebagai sumber dukungan internal yang sangat berarti. Dalam beberapa kasus, kolaborasi antara bidan dengan pemuka agama atau tokoh spiritual yang dipercaya ibu juga sangat membantu dalam memberikan ketenangan batin serta membantu ibu melewati masa transisi ini dengan lebih positif dan optimis.

B. Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode penting yang dialami seorang ibu setelah melahirkan, berlangsung sekitar enam minggu atau 42 hari pasca persalinan. Selama masa ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan signifikan sebagai upaya untuk kembali ke kondisi sebelum hamil. Proses ini dikenal sebagai adaptasi fisiologis

masa nifas. Perubahan ini mencakup berbagai sistem tubuh ibu, di antaranya sistem reproduksi, sistem endokrin, serta proses penyembuhan tubuh secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari perubahan fisiologis yang dialami ibu pada masa nifas adalah adaptasi sistem reproduksi. Setelah persalinan, rahim ibu mengalami proses involusi atau pengecilan kembali ke ukuran normal seperti sebelum kehamilan. Pada masa awal nifas, rahim masih terasa keras dengan tinggi fundus uteri setara dengan setinggi pusat, kemudian secara bertahap turun setiap harinya hingga kembali ke rongga pelvis. Proses ini berlangsung sekitar 6 minggu hingga ukuran rahim benar-benar kembali normal. Selain rahim, organ-organ reproduksi lain seperti serviks, vagina, dan perineum juga mengalami adaptasi berupa pemulihan jaringan yang sebelumnya mengalami peregangan atau trauma selama persalinan. Serviks secara perlahan menutup kembali, meskipun bentuknya mungkin tidak akan benar-benar kembali seperti sebelum kehamilan. Demikian juga vagina yang mengalami peregangan akan kembali menyusut dan mengembalikan elastisitasnya secara bertahap.

Selama masa nifas, ibu juga mengalami keluarnya lochia, yaitu darah nifas yang berasal dari rahim akibat pelepasan jaringan yang tersisa dari kehamilan. Lochia ini muncul secara bertahap, dimulai dengan warna merah terang, lalu berubah menjadi kecoklatan, kekuningan, hingga akhirnya jernih sebelum berhenti sepenuhnya. Kondisi ini merupakan bagian normal dari proses pembersihan rahim, namun harus tetap dipantau secara hati-hati oleh bidan untuk memastikan tidak adanya komplikasi seperti perdarahan berlebih atau infeksi.

Selain perubahan sistem reproduksi, ibu nifas juga mengalami perubahan signifikan dalam sistem endokrin atau hormonal. Selama kehamilan, produksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan human placental lactogen (HPL) meningkat secara dramatis untuk mendukung pertumbuhan janin dan mempertahankan kehamilan. Setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon-hormon tersebut menurun secara drastis, menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kondisi fisik dan emosional ibu. Penurunan hormon estrogen dan progesteron secara mendadak ini memiliki implikasi terhadap kesehatan psikologis ibu, yang sering dikaitkan dengan mood swings, perasaan sensitif, atau kondisi yang dikenal dengan istilah baby blues. Di sisi lain, hormon prolaktin, yang berfungsi untuk merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI), akan meningkat signifikan pada masa nifas. Keseimbangan hormon yang baru ini penting untuk mendukung proses menyusui, tetapi di sisi lain juga menyebabkan perubahan emosi dan fisik yang perlu dipahami oleh ibu maupun tenaga kesehatan yang mendampingi.

Untuk memastikan ibu menjalani masa nifas yang sehat dan aman, monitoring secara rutin terhadap tanda-tanda vital serta proses penyembuhan fisik ibu pasca-

persalinan menjadi sangat penting. Bidan bertanggung jawab untuk memeriksa secara rutin tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, pernapasan, dan kondisi umum ibu, agar dapat dengan cepat mendeteksi adanya potensi komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi, hipertensi, atau masalah kesehatan lain yang sering muncul di masa nifas. Selain itu, bidan juga perlu melakukan evaluasi kondisi luka perineum atau luka operasi (pada ibu yang menjalani persalinan melalui bedah caesar), untuk memastikan bahwa penyembuhan luka berjalan optimal dan bebas dari tanda-tanda infeksi.

Pemantauan juga melibatkan pengawasan terhadap pola eliminasi (buang air kecil dan besar), nutrisi, aktivitas fisik, serta istirahat ibu, karena semua faktor ini sangat memengaruhi proses penyembuhan dan pemulihan fisik ibu secara keseluruhan. Ibu perlu didorong untuk mengonsumsi nutrisi yang seimbang, menjaga hidrasi yang cukup, serta mendapatkan istirahat yang berkualitas demi mempercepat pemulihan dan menjaga kondisi kesehatannya.

C. Pemenuhan Nutrisi pada Masa Nifas

Pemenuhan nutrisi yang tepat pada masa nifas merupakan hal penting dan vital yang tidak boleh diabaikan. Selama periode ini, tubuh ibu memerlukan asupan nutrisi yang seimbang dan mencukupi guna menunjang proses pemulihan optimal setelah persalinan, sekaligus memenuhi kebutuhan energi yang meningkat akibat aktivitas menyusui. Kebutuhan gizi yang esensial pada masa nifas mencakup berbagai zat makro dan mikro yang tidak hanya mendukung percepatan pemulihan fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan emosional ibu agar lebih stabil menghadapi tantangan baru pasca melahirkan.

Kebutuhan energi dan zat gizi ibu nifas mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelum kehamilan. Ibu yang sedang menyusui umumnya memerlukan tambahan sekitar 500 kalori per hari dibandingkan kebutuhan normalnya. Hal ini penting agar ibu mampu menjaga keseimbangan energi, mencegah kelelahan, serta mendukung proses produksi air susu ibu (ASI) yang cukup. Dalam memenuhi kebutuhan energi ini, penting bagi ibu nifas untuk memilih jenis makanan dengan kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang esensial.

Protein merupakan salah satu zat gizi utama yang sangat dibutuhkan pada masa nifas. Protein berperan penting dalam membantu mempercepat penyembuhan jaringan tubuh yang mengalami trauma atau luka akibat proses persalinan, baik luka perineum pada persalinan normal maupun luka operasi pada persalinan caesar. Konsumsi protein yang cukup juga mendukung regenerasi sel-sel tubuh dan menjaga kekuatan otot, sehingga ibu dapat pulih lebih cepat dan mampu

melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sumber protein yang disarankan antara lain daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe, serta produk susu.

Selain protein, kebutuhan akan zat besi pada masa nifas juga sangat penting. Zat besi membantu mencegah anemia yang umum terjadi setelah melahirkan akibat kehilangan darah selama proses persalinan. Anemia dapat menyebabkan ibu mengalami lelah berkepanjangan, mudah pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan mengganggu produksi ASI. Oleh karena itu, asupan zat besi harus benar-benar diperhatikan melalui konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati, bayam, kacang merah, serta sayuran berwarna hijau tua lainnya. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, disarankan agar ibu juga mengonsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan paprika.

Asupan kalsium dan vitamin D juga perlu mendapat perhatian khusus pada masa nifas, terutama karena kedua nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang ibu yang rentan terhadap pengeroposan setelah melahirkan. Selain itu, kalsium yang cukup juga akan mendukung kualitas ASI sehingga bayi mendapatkan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan tulangnya. Sumber kalsium terbaik bisa diperoleh dari susu dan produk olahan susu seperti yoghurt dan keju, serta makanan lain seperti brokoli, almond, dan ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya. Vitamin D sendiri dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari pagi secara rutin serta konsumsi makanan seperti ikan berlemak, telur, dan produk susu yang diperkaya vitamin D.

Asupan nutrisi yang baik pada masa nifas tidak hanya berdampak positif bagi pemulihan fisik ibu, tetapi juga secara langsung memengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi baru lahir yang sangat dipengaruhi oleh pola makan ibu. Kandungan nutrisi dalam ASI seperti protein, lemak esensial (omega-3 dan omega-6), vitamin, serta mineral ditentukan oleh asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Misalnya, konsumsi makanan tinggi asam lemak omega-3 seperti ikan salmon, tuna, alpukat, walnut, dan biji chia akan membantu meningkatkan kualitas lemak dalam ASI, yang sangat penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi.

Sebaliknya, pola makan yang buruk dan kurang seimbang dapat berdampak negatif terhadap kualitas ASI, menyebabkan ibu merasa cepat lelah, produksi ASI menurun, serta risiko gangguan kesehatan pada bayi akibat kurangnya asupan nutrisi yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu nifas untuk memahami bahwa makanan yang ia konsumsi secara langsung berdampak pada kesehatan bayinya, sehingga pola makan sehat harus menjadi prioritas utama.

Namun, dalam praktik sehari-hari, sering kali ibu nifas menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kesibukan baru dalam merawat bayi yang menyita banyak waktu dan energi sering membuat ibu sulit merencanakan pola makan yang ideal. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan strategi praktis yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu strateginya adalah dengan merencanakan menu harian secara sederhana tetapi bergizi tinggi, yang tidak memerlukan waktu lama dalam persiapannya. Menu makanan ibu nifas sebaiknya mencakup variasi makanan sehat seperti nasi merah atau roti gandum, sayuran segar yang mudah diolah, serta lauk seperti telur rebus, ikan panggang, atau sup ayam yang praktis namun kaya nutrisi.

Selain itu, ibu nifas juga perlu menyediakan camilan sehat yang mudah dikonsumsi di sela-sela aktivitas menyusui atau merawat bayi, misalnya buah segar, yoghurt, kacang almond, atau granola bar. Penting pula untuk memastikan bahwa ibu nifas mendapat cukup cairan dengan selalu menyediakan air putih di dekat tempat beraktivitas. Konsumsi cairan yang cukup tidak hanya membantu ibu tetap terhidrasi, tetapi juga mendukung kelancaran produksi ASI.

Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting dalam membantu ibu nifas menjalani pola makan sehat. Edukasi tentang pentingnya nutrisi dan dampaknya terhadap pemulihan tubuh serta kualitas ASI harus diberikan secara intensif oleh bidan maupun tenaga kesehatan lainnya. Keluarga juga harus turut mendukung dengan memastikan tersedianya makanan bergizi, serta membantu ibu dalam menyiapkan makanan sehat di rumah.

D. Dukungan Psikologis dan Emosional pada Masa Nifas

Dukungan psikologis dan emosional merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian serius selama masa nifas. Pasca-persalinan, seorang ibu tidak hanya mengalami berbagai perubahan fisik, tetapi juga menghadapi tantangan psikologis yang dapat memengaruhi kondisi emosional serta kesejahteraan mentalnya. Masa ini sering kali penuh tekanan, ditandai oleh berbagai perasaan campur aduk mulai dari kebahagiaan atas kelahiran bayi, hingga rasa cemas, khawatir, kelelahan, bahkan rasa tidak mampu yang bisa muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek psikologis ibu selama masa nifas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asuhan kebidanan holistik.

Salah satu gangguan psikologis yang umum ditemui pada masa nifas adalah baby blues syndrome, yang ditandai dengan gejala ringan seperti perubahan suasana hati yang tiba-tiba, mudah menangis, perasaan cemas, hingga sulit tidur. Kondisi ini biasanya mulai terjadi beberapa hari setelah persalinan dan umumnya akan mereda dalam waktu dua minggu tanpa memerlukan penanganan medis

khusus. Namun demikian, jika gejala-gejala ini tidak segera diidentifikasi dan dikelola dengan baik, maka ibu berisiko mengalami kondisi yang lebih serius seperti depresi postpartum atau depresi pasca-persalinan.

Depresi postpartum adalah gangguan psikologis yang lebih berat dibandingkan baby blues, yang dapat memengaruhi kondisi emosional ibu secara signifikan serta memerlukan intervensi khusus dari tenaga kesehatan. Gangguan ini dapat terjadi dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah melahirkan, dengan gejala seperti perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap bayi, perubahan pola tidur yang drastis, perasaan putus asa, sulit berkonsentrasi, bahkan hingga pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri dan bayi. Tanpa identifikasi dan penanganan yang tepat, depresi postpartum dapat berdampak serius pada hubungan ibu dan bayi, kualitas hidup keluarga, bahkan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental yang lebih serius di kemudian hari.

Oleh sebab itu, bidan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki interaksi langsung dengan ibu pada masa nifas, perlu memahami dengan baik tanda-tanda gangguan psikologis ini. Bidan harus mampu mengidentifikasi secara dini gejala baby blues maupun depresi postpartum melalui observasi, wawancara, serta interaksi intensif dengan ibu. Apabila terdeteksi tanda-tanda gangguan tersebut, maka bidan wajib melakukan tindakan pengelolaan yang cepat, tepat, dan efektif. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan dukungan emosional secara intensif, memberikan pemahaman tentang kondisi yang dialami, serta membantu ibu untuk menerima kondisinya secara positif.

Selain dukungan emosional dasar, berbagai teknik relaksasi juga dapat diterapkan untuk membantu mengurangi gejala-gejala yang dialami ibu nifas. Teknik relaksasi sederhana seperti latihan pernapasan dalam, meditasi ringan, mendengarkan musik yang menenangkan, ataupun pijatan ringan terbukti efektif dalam mengurangi stres dan kecemasan. Teknik-teknik ini membantu ibu merasa lebih tenang, rileks, dan mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi setelah melahirkan dengan lebih positif.

Selain relaksasi, konseling psikologis merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental ibu nifas. Konseling dapat dilakukan secara individual maupun dalam kelompok. Dalam sesi konseling, ibu nifas diberi ruang untuk mengungkapkan berbagai perasaan yang dialaminya, termasuk rasa cemas, ketakutan, atau rasa tidak percaya diri dalam menjalankan peran barunya sebagai seorang ibu. Dengan adanya ruang ekspresi yang aman dan nyaman ini, ibu akan merasa didengarkan, dimengerti, dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan emosionalnya. Bidan atau tenaga kesehatan lainnya

dapat memfasilitasi konseling ini atau merujuk ibu kepada profesional kesehatan mental jika diperlukan.

Di samping konseling, edukasi yang diberikan secara intensif mengenai perubahan psikologis selama masa nifas juga sangat penting. Edukasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada ibu bahwa apa yang mereka alami merupakan kondisi umum yang dialami banyak ibu pasca-persalinan. Dengan pemahaman ini, ibu akan lebih siap secara mental, mampu mengenali tanda-tanda awal jika kondisi psikologisnya memburuk, dan lebih mampu mencari bantuan profesional tepat waktu.

Peran keluarga dan lingkungan terdekat dalam memberikan dukungan psikologis juga tidak kalah pentingnya. Pada masa nifas, ibu membutuhkan dukungan emosional yang kuat dari pasangan, anggota keluarga lainnya, maupun lingkungan sosialnya. Keluarga yang suportif dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan percaya diri pada ibu. Misalnya, peran pasangan sangat penting dalam membantu ibu mengurangi stres dengan berbagi tanggung jawab merawat bayi dan tugas domestik sehari-hari, sehingga ibu memiliki waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan fisik dan emosional.

Selain itu, keluarga juga perlu menciptakan lingkungan positif yang memungkinkan ibu untuk mengungkapkan perasaan tanpa takut dihakimi. Dorongan positif dan penghargaan atas peran baru ibu sangat membantu dalam menjaga kestabilan emosional dan kesejahteraan mentalnya. Di tingkat lingkungan sosial, kehadiran kelompok-kelompok dukungan atau komunitas ibu pasca-persalinan dapat menjadi tempat bertukar pengalaman, saling mendukung, dan memberikan rasa solidaritas sesama ibu yang sedang menghadapi masa nifas.

Dengan kombinasi dukungan dari bidan, keluarga, lingkungan sosial, serta pemanfaatan teknik-teknik relaksasi dan konseling yang tepat, ibu nifas akan mampu menghadapi tantangan psikologis secara lebih efektif. Dukungan yang komprehensif ini tidak hanya membantu mencegah gangguan psikologis yang lebih berat, tetapi juga memastikan bahwa ibu mampu menjalani masa nifas dengan perasaan yang lebih positif, percaya diri, serta penuh kasih sayang, sehingga menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan emosional yang sehat antara ibu dan bayi serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

E. Promosi dan Dukungan Menyusui pada Masa Nifas

Promosi dan dukungan menyusui merupakan komponen utama dalam asuhan kebidanan pada masa nifas yang perlu diperhatikan secara khusus. Menyusui eksklusif, yakni pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara tunggal tanpa tambahan cairan atau makanan lain sejak lahir hingga bayi berusia enam bulan, telah terbukti

memberikan manfaat besar baik bagi ibu maupun bayi. Untuk mendukung keberhasilan menyusui eksklusif ini, edukasi dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh ibu, terutama bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan dan menyusui.

Edukasi menyusui eksklusif diberikan secara komprehensif kepada ibu sejak masa kehamilan hingga masa nifas. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang manfaat menyusui bagi kesehatan bayi, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan dan pencernaan, mengurangi risiko alergi, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Selain manfaat untuk bayi, edukasi juga menekankan pentingnya menyusui bagi kesehatan ibu, antara lain membantu mempercepat pemulihan rahim, mengurangi risiko perdarahan pasca-persalinan, membantu penurunan berat badan pasca-persalinan, serta menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium di kemudian hari.

Pendampingan menyusui dilakukan oleh bidan atau konselor menyusui yang terlatih dengan memberikan bimbingan secara langsung kepada ibu mengenai posisi menyusui yang nyaman dan efektif, teknik pelekatan (latching) bayi ke payudara dengan benar, hingga pengenalan tanda-tanda bahwa bayi mendapatkan ASI yang cukup. Dalam pendampingan ini, ibu diberi kesempatan untuk bertanya langsung, menyampaikan kekhawatiran atau keluhan yang dialami, dan mendapatkan solusi praktis untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses menyusui. Pendampingan ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan diri ibu sehingga ibu merasa nyaman dan tenang selama proses menyusui berlangsung.

Meskipun menyusui merupakan proses alami, dalam kenyataannya, tidak sedikit ibu yang mengalami berbagai hambatan dan permasalahan yang dapat mengganggu proses tersebut. Oleh karena itu, perlu diterapkan berbagai teknik efektif yang bertujuan untuk mengatasi hambatan yang sering dialami ibu selama menyusui. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah kesulitan dalam posisi menyusui dan pelekatan yang kurang tepat, yang dapat menyebabkan bayi sulit mendapatkan ASI secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, bidan akan mengajarkan berbagai posisi menyusui yang nyaman seperti posisi cradle (gendongan silang), football hold (posisi bola), ataupun side-lying (menyusui sambil berbaring), serta membantu ibu memastikan bahwa bayi telah melekat dengan benar, yaitu dengan mulut bayi yang terbuka lebar, bibir bayi yang mencakup sebagian besar areola, dan dagu bayi yang menempel pada payudara ibu. Teknik yang tepat ini akan memastikan bayi menyusu dengan baik sekaligus membantu mencegah komplikasi menyusui seperti puting lecet atau nyeri saat menyusui.

Selain kesulitan posisi dan pelekatan, beberapa ibu mungkin mengalami tantangan berupa produksi ASI yang dianggap kurang. Kondisi ini sering menimbulkan kecemasan yang menyebabkan ibu cenderung memilih susu formula sebagai alternatif. Bidan dalam hal ini berperan penting dalam memberikan pemahaman bahwa produksi ASI sangat bergantung pada mekanisme permintaan (supply-demand). Artinya, semakin sering bayi menyusui dan semakin baik pelekatan bayi, maka produksi ASI pun akan semakin meningkat. Selain teknik menyusui yang tepat, edukasi mengenai pentingnya istirahat cukup, nutrisi seimbang, serta hidrasi yang optimal juga diberikan kepada ibu untuk mendukung produksi ASI yang lancar. Bila diperlukan, teknik stimulasi tambahan seperti pijat laktasi atau pumping ASI dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi ASI.

Dalam proses menyusui, terkadang muncul komplikasi yang perlu diidentifikasi secara dini agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Salah satu komplikasi yang cukup sering ditemui adalah mastitis, yaitu peradangan pada payudara yang disebabkan oleh infeksi atau penyumbatan saluran ASI. Mastitis ditandai dengan gejala seperti payudara yang terasa nyeri, kemerahan, bengkak, hingga ibu mengalami demam. Bila kondisi ini terjadi, bidan bertanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai manajemen awal mastitis, seperti kompres hangat pada payudara, memijat ringan untuk memperlancar aliran ASI, serta tetap melanjutkan proses menyusui atau pemerahan ASI secara teratur agar tidak terjadi sumbatan lebih lanjut. Jika gejala tidak membaik, bidan dapat berkoordinasi dengan dokter untuk memberikan antibiotik yang tepat sesuai kebutuhan.

Komplikasi lainnya adalah kondisi puting lecet atau pecah-pecah, yang umumnya disebabkan oleh teknik pelekatan yang kurang tepat atau gesekan berlebihan akibat posisi menyusui yang salah. Untuk mencegah komplikasi ini, ibu diberi bimbingan mengenai teknik menyusui yang benar serta perawatan payudara yang tepat seperti menggunakan ASI sebagai pelembap alami setelah menyusui, serta menghindari penggunaan sabun atau bahan yang dapat mengiritasi puting. Apabila kondisi ini tetap terjadi, penggunaan krim lanolin khusus atau bantalan hidrogel bisa disarankan untuk membantu mempercepat penyembuhan luka pada puting.

Dalam setiap kasus komplikasi, pendekatan yang paling penting adalah pencegahan melalui edukasi dini dan pendampingan intensif dari bidan atau tenaga kesehatan terlatih. Keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan praktis juga tidak kalah penting. Keluarga dapat membantu memberikan waktu istirahat yang cukup bagi ibu, membantu tugas domestik sehari-hari, serta mendampingi ibu secara emosional agar ibu tetap semangat dalam menjalankan proses menyusui.

F. Aktivitas Fisik dan Istirahat dalam Masa Nifas

Aktivitas fisik dan istirahat yang cukup merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan erat dalam mendukung proses pemulihan ibu selama masa nifas. Setelah melewati proses persalinan yang membutuhkan banyak energi dan perubahan fisiologis yang signifikan, tubuh ibu memerlukan waktu untuk kembali pulih secara optimal. Dalam periode ini, penting sekali bagi ibu untuk memahami bagaimana mengelola keseimbangan antara istirahat dan aktivitas fisik ringan, agar pemulihan dapat berjalan maksimal sekaligus menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh.

Istirahat yang cukup pada masa nifas menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dianggap remeh, karena tubuh ibu telah mengalami berbagai perubahan drastis baik fisik maupun hormonal. Kurangnya istirahat dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan, menurunkan daya tahan tubuh, memperlambat penyembuhan luka-luka persalinan, bahkan meningkatkan risiko komplikasi seperti perdarahan pasca-persalinan, infeksi, atau gangguan psikologis seperti depresi postpartum. Istirahat yang cukup bukan hanya soal tidur, melainkan juga mencakup kesempatan ibu untuk relaksasi dan pemulihan secara fisik maupun mental. Dukungan dari keluarga atau pasangan sangat dibutuhkan di sini, misalnya dengan membantu mengurus bayi, melakukan pekerjaan rumah tangga, atau menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi ibu. Pola tidur ibu juga perlu diperhatikan, terutama dengan memanfaatkan waktu tidur bayi agar ibu dapat beristirahat secara optimal. Kualitas istirahat yang baik akan mendukung tubuh dalam melakukan regenerasi jaringan, mempercepat penyembuhan luka pasca-persalinan, menjaga kestabilan hormon, serta membantu meningkatkan produksi ASI secara signifikan.

Meski istirahat sangat penting, bukan berarti ibu harus menghindari aktivitas fisik sepenuhnya selama masa nifas. Aktivitas fisik ringan justru memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan serta menjaga kebugaran tubuh ibu. Aktivitas fisik ringan yang dianjurkan selama masa nifas biasanya meliputi gerakan-gerakan sederhana yang dapat dilakukan secara perlahan dan bertahap, seperti berjalan kaki di sekitar rumah, peregangan ringan, latihan pernapasan, hingga latihan khusus untuk memperkuat otot-otot panggul (latihan Kegel). Aktivitas ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, mencegah pembentukan bekuan darah atau trombosis, mempercepat proses involusi rahim, serta meningkatkan kekuatan otot-otot tubuh yang mengalami peregangan dan ketegangan selama masa kehamilan dan persalinan. Lebih dari itu, aktivitas fisik ringan dapat membantu memperbaiki

suasana hati ibu, mengurangi rasa lelah, meningkatkan energi, dan mengurangi risiko depresi postpartum.

Latihan fisik ringan selama masa nifas sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing ibu. Pada beberapa hari pertama pasca-persalinan, terutama jika ibu menjalani persalinan secara operasi caesar, aktivitas fisik mungkin hanya berupa gerakan ringan di tempat tidur. Setelah kondisi ibu dirasa cukup baik, aktivitas seperti berjalan kaki singkat bisa mulai dilakukan, kemudian secara perlahan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik ibu. Bidan atau tenaga kesehatan yang mendampingi ibu biasanya akan memberikan panduan secara spesifik tentang jenis latihan yang aman dan efektif, termasuk kapan sebaiknya latihan dimulai dan kapan intensitas latihan dapat ditingkatkan.

Di samping istirahat yang cukup dan aktivitas fisik ringan, teknik relaksasi juga merupakan bagian integral dalam menjaga kenyamanan ibu selama masa nifas. Teknik relaksasi yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan fisik maupun emosional, serta membantu ibu menghadapi ketidaknyamanan seperti nyeri luka jahitan, kontraksi rahim saat involusi, nyeri payudara akibat proses menyusui, ataupun kelelahan secara umum. Salah satu teknik relaksasi sederhana yang bisa diterapkan adalah teknik pernapasan dalam (deep breathing), di mana ibu secara perlahan mengambil napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan pula. Teknik ini efektif dalam mengurangi rasa cemas, meningkatkan oksigenasi tubuh, serta mengurangi rasa nyeri dan ketegangan.

Selain teknik pernapasan, posisi relaksasi tertentu juga dapat membantu ibu merasa lebih nyaman selama masa nifas. Misalnya, posisi berbaring menyamping dengan bantal yang ditempatkan di antara lutut, posisi duduk dengan sandaran nyaman saat menyusui, atau posisi duduk setengah berbaring dengan kaki yang disangga untuk mengurangi tekanan pada daerah panggul dan perut. Posisi-posisi ini membantu mengurangi tekanan berlebih pada tubuh, terutama pada area luka persalinan, memperlancar sirkulasi darah, serta membantu mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan fisik selama masa pemulihan.

G. Asuhan Kebidanan Berbasis Spiritual dan Budaya Lokal

Asuhan kebidanan pada masa nifas tidak dapat dipandang secara sempit hanya dari aspek fisik semata, melainkan perlu melibatkan dimensi spiritual dan nilai-nilai budaya lokal yang diyakini masyarakat setempat. Pendekatan ini sangat penting, sebab kesehatan dan kesejahteraan ibu nifas bukan hanya mencakup kondisi fisik saja, melainkan juga aspek psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Dimensi spiritual dalam asuhan kebidanan holistik sangat berperan besar dalam

membantu ibu menghadapi masa transisi yang penuh tantangan, setelah melahirkan bayi serta beradaptasi dengan peran baru sebagai seorang ibu. Kepercayaan spiritual mampu memberikan kekuatan, ketenangan jiwa, serta makna mendalam terhadap pengalaman persalinan dan masa nifas yang sedang dijalani oleh seorang perempuan. Hal ini terbukti mampu mempercepat proses pemulihan fisik, membantu mengurangi kecemasan serta stres, sekaligus mendukung ketahanan emosional ibu dalam menghadapi berbagai tantangan di masa nifas.

Pentingnya integrasi spiritual dalam asuhan kebidanan ini bukan berarti membatasi pelayanan kesehatan pada aspek agama tertentu saja, melainkan lebih kepada penghargaan dan penghormatan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai spiritual individu maupun komunitas tempat ibu berasal. Bidan sebagai tenaga profesional yang memberikan asuhan kebidanan perlu memiliki pemahaman mendalam serta keterampilan komunikasi yang baik dalam menghargai kepercayaan spiritual ibu dan keluarganya. Misalnya, memberikan kesempatan kepada ibu untuk melakukan doa atau ritual keagamaan tertentu yang dianggap penting dan mendukung proses pemulihan secara spiritual maupun psikologis. Praktik-praktik spiritual yang diyakini oleh ibu dan keluarga dapat memberikan dampak positif terhadap kestabilan emosional ibu, menumbuhkan rasa nyaman, serta meningkatkan motivasi dan semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan selama masa nifas.

Selain dimensi spiritual, integrasi nilai budaya lokal dalam pelayanan kebidanan juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu nifas. Setiap daerah memiliki keunikan tradisi, adat istiadat, serta praktik-praktik yang dipercaya memiliki manfaat khusus bagi kesehatan dan pemulihan ibu nifas. Dalam konteks kebidanan modern, integrasi budaya lokal bukan berarti mengadopsi semua tradisi secara bulat-bulat tanpa pertimbangan medis, melainkan lebih kepada cara bagaimana bidan dapat menghargai, memadukan, serta mengharmonisasikan nilai budaya dengan prinsip-prinsip kebidanan berbasis bukti (*evidence-based midwifery*). Dengan memahami nilai budaya lokal, bidan dapat lebih efektif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pelayanan kesehatan yang mudah diterima serta diterapkan oleh masyarakat.

Praktik-praktik tradisional lokal yang sering kali dilakukan di masyarakat selama masa nifas, seperti penggunaan ramuan herbal, pijat tradisional, penggunaan kain tradisional seperti bengkung, serta ritual mandi uap, merupakan bagian dari warisan budaya yang telah terbukti secara empiris mampu memberikan manfaat tertentu bagi pemulihan fisik maupun psikologis ibu. Sebagai contoh, penggunaan ramuan herbal tertentu yang diyakini mampu mempercepat

penyembuhan luka persalinan, meningkatkan produksi ASI, serta mengembalikan stamina tubuh ibu telah banyak diteliti dan diintegrasikan secara selektif dalam praktik kebidanan modern dengan pendekatan ilmiah. Demikian pula pijat tradisional pasca-persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi atau tukang pijat tradisional, secara modern diadopsi menjadi pijat laktasi dan pijat postpartum yang kini banyak direkomendasikan oleh tenaga kesehatan profesional karena manfaatnya dalam meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan produksi ASI, dan mempercepat pemulihan fisik ibu nifas.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua praktik budaya lokal sepenuhnya aman atau tepat dari sudut pandang medis modern. Di sinilah peran bidan sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih serta mengadaptasi praktik budaya lokal yang aman, efektif, dan bermanfaat bagi kesehatan ibu nifas berdasarkan bukti ilmiah. Bidan juga bertanggung jawab dalam memberikan panduan mengenai cara terbaik menerapkan praktik-praktik tradisional yang aman, serta memberi pemahaman tentang potensi risiko dari praktik-praktik yang tidak dianjurkan dari sudut pandang medis. Dengan demikian, terjadi dialog positif antara nilai budaya lokal dan kebidanan modern yang saling menghargai dan memperkaya satu sama lain.

Dalam pelayanan kebidanan berbasis spiritual dan budaya lokal, bidan perlu berperan sebagai mediator budaya dan spiritual yang mampu memahami keunikan kepercayaan dan praktik lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ilmiah. Pendekatan yang tepat dalam mengintegrasikan budaya lokal akan membantu masyarakat, khususnya ibu nifas, untuk lebih percaya diri dan nyaman dalam menerima pelayanan kesehatan. Mereka akan merasa bahwa tradisi dan kepercayaannya dihargai dan diakui, sehingga hal ini akan meningkatkan keterlibatan aktif ibu dan keluarga dalam proses asuhan kebidanan. Hasil akhirnya adalah tercapainya kesehatan fisik, emosional, spiritual, dan sosial ibu secara optimal, yang merupakan tujuan utama dari asuhan kebidanan holistik pada masa nifas.

H. Dukungan Sosial dan Peran Keluarga

Dukungan sosial merupakan salah satu komponen penting dalam asuhan kebidanan holistik, khususnya pada masa nifas. Masa nifas adalah periode transisi besar dalam kehidupan seorang perempuan, karena ia tidak hanya harus beradaptasi dengan perubahan fisik dan emosional pasca-persalinan, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Dalam periode ini, peran keluarga, terutama pasangan dan keluarga terdekat, menjadi sangat krusial. Dukungan yang diberikan keluarga mampu membantu ibu nifas dalam

menghadapi berbagai tantangan selama proses adaptasi tersebut, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.

Pentingnya dukungan keluarga pada masa nifas dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari sisi emosional dan psikologis, keberadaan dan perhatian keluarga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi ibu nifas. Seorang ibu yang mendapatkan perhatian penuh dari keluarga akan lebih percaya diri dan merasa dihargai, sehingga mampu mengelola tekanan dan stres yang muncul selama masa nifas dengan lebih baik. Kondisi psikologis yang stabil ini pada gilirannya akan mempercepat proses pemulihan fisik dan meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dengan bayi yang baru dilahirkan.

Selain aspek psikologis, dukungan keluarga juga penting dalam aspek praktis sehari-hari. Pasangan dan anggota keluarga dekat dapat mengambil peran aktif dalam membantu ibu dalam menjalankan tugas-tugas domestik seperti menyiapkan makanan sehat, membantu merawat bayi, mengelola pekerjaan rumah tangga, serta memberikan kesempatan bagi ibu untuk beristirahat dengan cukup. Dukungan ini sangat berarti bagi ibu yang baru saja melahirkan, terutama di minggu-minggu awal masa nifas, ketika tubuh masih dalam tahap pemulihan dan aktivitas fisik ibu sebaiknya dibatasi agar proses penyembuhan berjalan optimal.

Dalam mengoptimalkan peran pasangan dan keluarga dekat dalam perawatan bayi baru lahir, penting bagi bidan untuk memberikan edukasi yang tepat mengenai peran masing-masing anggota keluarga. Bidan dapat secara aktif memberikan informasi tentang cara-cara yang tepat dalam mendukung ibu nifas dan mengasuh bayi, misalnya cara menggendong bayi, membantu dalam proses menyusui, mengganti popok, hingga cara menenangkan bayi yang menangis. Edukasi yang disampaikan secara jelas, sederhana, dan penuh empati akan membuat keluarga merasa lebih percaya diri dalam mengambil peran aktif dalam merawat ibu nifas dan bayi.

Tidak hanya sebatas edukasi keluarga secara individu, bidan juga memiliki peran penting dalam melakukan kolaborasi yang erat dengan komunitas atau lingkungan sekitar untuk menciptakan sistem dukungan sosial yang lebih luas bagi ibu nifas. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan komunitas, sesi berbagi pengalaman antar ibu nifas, atau kegiatan edukasi kelompok yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga. Dengan pendekatan ini, komunitas akan lebih memahami pentingnya dukungan sosial bagi ibu nifas, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pemulihan fisik maupun mental ibu setelah melahirkan.

Melalui keterlibatan aktif keluarga dan kolaborasi dengan komunitas, ibu nifas akan mendapatkan jaringan dukungan yang kuat dan menyeluruh. Hal ini sangat

penting karena masa nifas yang dijalani dengan dukungan sosial yang optimal terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ibu, mengurangi risiko munculnya gangguan psikologis seperti baby blues dan depresi postpartum, serta membantu ibu nifas dalam menjalankan peran barunya secara lebih percaya diri, bahagia, dan sehat secara fisik maupun mental. Dengan demikian, pendekatan asuhan kebidanan holistik yang melibatkan dukungan keluarga dan komunitas tidak hanya mempercepat pemulihan fisik, tetapi juga menjadi investasi berharga untuk kesejahteraan jangka panjang ibu, bayi, dan keluarganya.

I. Pencegahan dan Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas

Masa nifas adalah masa yang sangat penting dan kritis dalam siklus reproduksi perempuan. Meskipun persalinan telah berhasil dilewati dengan baik, masa ini tidak sepenuhnya bebas dari risiko komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa seorang ibu. Oleh karena itu, upaya pencegahan serta deteksi dini terhadap komplikasi-komplikasi yang umum muncul selama masa nifas merupakan aspek penting dari asuhan kebidanan yang berkualitas.

Beberapa komplikasi yang sering terjadi pada masa nifas, antara lain perdarahan postpartum, infeksi, dan tromboemboli. Perdarahan postpartum adalah komplikasi paling sering yang terjadi selama masa nifas dan juga menjadi penyebab utama kematian ibu di banyak negara. Perdarahan ini biasanya disebabkan oleh atonia uteri, sisa plasenta, lacerasi jalan lahir, atau gangguan pembekuan darah. Jika tidak diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan tepat, perdarahan ini bisa mengakibatkan kehilangan darah yang signifikan hingga menyebabkan syok hipovolemik.

Komplikasi lainnya adalah infeksi nifas, yang umumnya melibatkan organ reproduksi seperti rahim, serviks, dan vagina. Infeksi ini sering kali disebabkan oleh bakteri yang masuk selama proses persalinan, terutama dalam persalinan yang dilakukan dalam kondisi yang tidak sepenuhnya steril atau pasca-tindakan invasif seperti operasi caesar atau episiotomi. Tanda infeksi biasanya meliputi demam tinggi, nyeri pada perut bagian bawah, keluarnya cairan vagina yang berbau tidak sedap, serta kondisi ibu yang tampak lemah secara umum. Apabila tidak segera diatasi, infeksi dapat berkembang menjadi sepsis, yang merupakan kondisi serius dengan risiko kematian tinggi.

Tromboemboli juga menjadi komplikasi yang penting untuk diperhatikan, walaupun kejadiannya lebih jarang dibanding perdarahan atau infeksi. Tromboemboli terjadi karena adanya pembekuan darah abnormal yang menyumbat pembuluh darah vena, biasanya pada tungkai bawah, yang disebut trombosis vena dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT). Jika bekuan darah tersebut terlepas, kemudian dibawa oleh aliran darah menuju paru-paru, maka akan menyebabkan emboli paru

yang dapat berakibat fatal. Faktor risiko tromboemboli selama masa nifas antara lain kurangnya mobilitas pasca-persalinan, obesitas, persalinan caesar, dan riwayat gangguan pembekuan darah.

Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, manajemen awal serta deteksi dini sangat menentukan hasil akhir kondisi ibu nifas. Seorang bidan harus memiliki kompetensi yang baik dalam mengidentifikasi secara cepat gejala-gejala awal komplikasi ini. Misalnya, pada kasus perdarahan postpartum, bidan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi uterus, kontraksi rahim, serta memeriksa kemungkinan adanya laserasi atau robekan pada jalan lahir. Tindakan cepat yang dapat dilakukan seperti memijat rahim (masase fundus), memastikan kontraksi uterus optimal, serta memberikan uterotonika sesuai standar.

Demikian pula pada kasus infeksi, deteksi dini melalui pemantauan suhu tubuh dan tanda infeksi lokal serta edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai kebersihan dan perawatan luka perineum menjadi sangat krusial. Penanganan awal berupa pemberian antibiotik spektrum luas dapat mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut dan perlu diikuti dengan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika kondisi ibu tidak membaik.

Sementara untuk pencegahan tromboemboli, bidan perlu memberikan edukasi pentingnya mobilisasi dini pasca-persalinan, melakukan latihan ringan secara rutin untuk memperlancar aliran darah, serta menghindari posisi statis yang lama. Dalam beberapa kasus yang memiliki faktor risiko tinggi, penggunaan stoking kompresi atau pemberian profilaksis antikoagulan mungkin diperlukan sesuai rekomendasi medis.

Selain tindakan langsung dari tenaga kesehatan, edukasi keluarga tentang tanda-tanda bahaya masa nifas yang harus diwaspadai merupakan langkah penting dalam pencegahan komplikasi yang lebih serius. Keluarga perlu mengetahui bahwa kondisi seperti perdarahan hebat, keluarnya cairan berbau, demam tinggi, nyeri perut yang terus-menerus, nyeri dada, sesak napas, atau pembengkakan kaki secara tiba-tiba adalah tanda-tanda yang mengindikasikan kebutuhan intervensi segera oleh tenaga medis. Edukasi ini sebaiknya diberikan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, agar keluarga dapat dengan cepat mengenali kondisi darurat dan membawa ibu segera ke fasilitas kesehatan yang memadai.

Dengan penerapan deteksi dini yang efektif, manajemen awal yang tepat, serta edukasi yang memadai kepada ibu nifas dan keluarganya, berbagai komplikasi masa nifas dapat dicegah atau ditangani secara optimal. Kolaborasi aktif antara bidan, keluarga, dan sistem kesehatan yang terintegrasi akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi ibu nifas, sehingga masa transisi pasca-persalinan dapat

dilewati dengan baik, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu maupun bayi baru lahir dapat terjaga secara maksimal.

J. Simpulan

Asuhan kebidanan holistik pada masa nifas merupakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik saja, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, emosional, sosial, spiritual, serta aspek budaya yang saling terintegrasi. Masa nifas adalah masa transisi kritis yang membutuhkan perhatian khusus karena terjadi berbagai perubahan signifikan pada tubuh ibu, baik secara fisiologis, hormonal, maupun emosional. Dengan pendekatan holistik, bidan dapat memberikan asuhan yang menyeluruh, sehingga mendukung proses pemulihan ibu secara optimal sekaligus memastikan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir.

Peran bidan sangat penting dalam mendukung adaptasi fisiologis tubuh ibu, memastikan proses involusi rahim, penyembuhan luka persalinan, serta mengontrol keseimbangan hormonal berlangsung dengan baik. Selain itu, bidan memiliki tanggung jawab dalam memantau tanda-tanda vital secara teratur untuk mendeteksi dini potensi komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi, atau tromboemboli yang dapat berakibat fatal apabila tidak segera ditangani.

Pemenuhan nutrisi yang tepat pada masa nifas juga sangat penting untuk mendukung pemulihan fisik ibu serta menjamin kualitas Air Susu Ibu (ASI). Bidan berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pola makan sehat yang memenuhi kebutuhan gizi ibu nifas, termasuk peningkatan asupan protein, zat besi, kalsium, vitamin, serta mineral penting lainnya yang diperlukan tubuh dalam proses penyembuhan.

Selain aspek fisik, pendekatan holistik juga sangat memperhatikan dukungan psikologis dan emosional ibu nifas. Mengidentifikasi secara dini gangguan psikologis seperti baby blues dan depresi postpartum serta memberikan intervensi berupa konseling, teknik relaksasi, dan edukasi psikologis sangat diperlukan guna mencegah gangguan yang lebih serius. Dalam hal ini, dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Keterlibatan keluarga yang suportif secara emosional maupun praktis membantu ibu nifas melewati periode ini dengan lebih tenang, nyaman, dan bahagia.

Dimensi spiritual serta budaya lokal turut menjadi aspek penting dalam pendekatan holistik ini. Mengintegrasikan keyakinan spiritual dan praktik budaya tradisional yang aman dalam pelayanan kebidanan mampu memberikan rasa nyaman dan percaya diri kepada ibu nifas. Bidan berperan dalam membangun pemahaman dan dialog positif antara praktik tradisional dengan kebidanan modern

berbasis bukti, sehingga tercipta pelayanan kebidanan yang lebih diterima masyarakat dan efektif dalam mendukung pemulihan ibu.

Promosi menyusui eksklusif menjadi bagian penting dari asuhan holistik ini, di mana bidan secara aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu nifas agar mampu mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses menyusui. Melalui pendekatan yang tepat, berbagai komplikasi menyusui seperti mastitis dan puting lecet dapat dicegah dan diatasi secara dini.

Aktivitas fisik ringan dan istirahat yang cukup juga menjadi bagian integral dari masa nifas. Dengan keseimbangan yang baik antara aktivitas fisik dan relaksasi, ibu nifas mampu mempercepat pemulihan, menjaga kebugaran tubuh, serta mengurangi ketidaknyamanan fisik selama masa transisi ini.

Terakhir, pencegahan dan deteksi dini komplikasi masa nifas merupakan aspek vital dalam asuhan kebidanan holistik. Edukasi intensif mengenai tanda bahaya masa nifas kepada keluarga dan komunitas, serta kompetensi bidan dalam manajemen komplikasi yang tepat dan cepat, sangat menentukan keberhasilan dalam menurunkan risiko komplikasi serius yang dapat mengancam nyawa ibu.

K. Referensi

- Armini, N. K. A., Putu, I. N., & Dewi, A. K. (2020). Pengaruh asuhan kebidanan holistik terhadap adaptasi psikologis ibu nifas. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(1), 45–52.
- Departemen Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Nifas Terpadu*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Fikawati, S., & Syafiq, A. (2021). *Gizi ibu hamil dan menyusui: Panduan praktis bagi tenaga kesehatan*. Rajawali Pers.
- Fraser, D. M., Cooper, M. A., & Nolte, A. G. W. (2019). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). Elsevier.
- Handayani, S., & Setyarini, E. A. (2019). Efektivitas konseling menyusui dalam meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 15(2), 198–205.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's nursing care of infants and children* (11th ed.). Elsevier Mosby.
- Johnson, R., & Taylor, W. (2020). Spirituality and culturally competent midwifery care. *Journal of Holistic Nursing and Midwifery*, 14(3), 65–74.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Buku Saku Pelayanan Kebidanan Komprehensif Masa Nifas*. Direktorat Kesehatan Keluarga.
- Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2021). *Foundations of maternal-newborn and women's health nursing* (8th ed.). Elsevier.

- Purwaningsih, W., & Hartini, S. (2020). Peran bidan dalam pemberdayaan keluarga untuk dukungan sosial ibu nifas. *Indonesian Journal of Midwifery*, 4(2), 120–127.
- Roesli, U. (2019). *Inisiasi menyusui dini plus ASI eksklusif*. Pustaka Bunda.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, E. (2020). *Asuhan kebidanan pada ibu nifas*. Salemba Medika.
- Saifuddin, A. B. (2020). *Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Wahyuni, E. S., & Widuri, R. (2020). Efektivitas terapi relaksasi untuk mencegah depresi postpartum. *Jurnal Kesehatan Jiwa dan Psikologi*, 3(2), 89–97.
- World Health Organization. (2020). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. World Health Organization Press.

L. Glosarium

- **Asuhan Kebidanan Holistik**

Pendekatan dalam pelayanan kebidanan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya secara menyeluruh guna memenuhi kebutuhan ibu selama masa nifas secara optimal.

- **Masa Nifas**

Periode setelah persalinan berlangsung sekitar 6 minggu (42 hari), ditandai dengan adaptasi tubuh secara fisiologis untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan.

- **Involusi Rahim**

Proses pengecilan rahim secara bertahap setelah persalinan hingga kembali ke ukuran semula sebelum kehamilan, biasanya berlangsung selama 6 minggu.

- **Lochia**

Darah nifas yang keluar dari rahim pasca persalinan, berupa darah dan jaringan sisa kehamilan, dengan perubahan warna dan konsistensi hingga berhenti secara bertahap dalam 4–6 minggu.

- **Baby Blues Syndrome**

Gangguan psikologis ringan yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perubahan suasana hati mendadak, cemas, mudah menangis, dan biasanya berlangsung singkat (kurang dari dua minggu).

- **Depresi Postpartum**

Gangguan psikologis yang serius pasca persalinan dengan gejala sedih berkepanjangan, kehilangan minat, perubahan pola tidur yang signifikan, hingga pikiran negatif yang memerlukan intervensi medis dan psikologis intensif.

- **Mastitis**

Peradangan payudara akibat infeksi atau sumbatan saluran ASI, gejalanya meliputi nyeri, bengkak, kemerahan, hingga demam yang mengganggu proses menyusui.

- **Teknik Pelekatan (Latching)**

Cara melekatkan mulut bayi ke payudara secara tepat agar bayi bisa menyusui efektif tanpa melukai puting, penting untuk mencegah komplikasi saat menyusui.

- **Tromboemboli**

Komplikasi akibat pembentukan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah vena, sering terjadi di tungkai (Deep Vein Thrombosis/DVT), yang dapat menyebabkan emboli paru jika tidak segera ditangani.

- **Integrasi Budaya Lokal**

Pendekatan yang menghargai dan mengharmonisasikan nilai-nilai budaya setempat dalam asuhan kebidanan, melibatkan praktik tradisional yang aman dan sesuai prinsip medis berbasis bukti.

CHAPTER 4

PENDAMPINGAN KEBIDANAN HOLISTIK PADA LANSIA

Dwi Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Latar belakang dan urgensi topik

Pendampingan kebidanan kerap dipersepsikan sebatas masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Padahal, praktik kebidanan berlandaskan pendekatan sepanjang daur kehidupan perempuan, mencakup remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pada tahap lanjut usia, perempuan memikul jejak panjang pengalaman biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual yang saling berkelindan: transisi pascamenopause, perubahan komposisi tubuh dan kesehatan tulang, kerentanan uroginekologis seperti gangguan dasar panggul dan inkontinensia, dinamika relasi dan seksualitas, perubahan peran sosial dalam keluarga, hingga tantangan kesehatan mental yang kerap tersembunyi di balik narasi “tahan dan ikhlas.” Semua ini memengaruhi mutu hidup lansia perempuan sekaligus memerlukan respons layanan kesehatan yang peka dan menyeluruh.

Di Indonesia, keluarga masih menjadi pusat perawatan lansia. Banyak perempuan lansia hidup dalam rumah tangga multigenerasi, berperan sebagai pengasuh cucu atau penjaga tradisi keluarga, tetapi pada saat yang sama menyimpan kebutuhan perawatan yang belum terucap. Norma budaya tentang rasa sungkan dan tabu membicarakan area intim, misalnya keluhan prolaps atau penurunan kenikmatan seksual, sering membuat masalah datang terlambat ke fasilitas layanan. Di sinilah bidan memiliki posisi strategis sebagai tenaga kesehatan yang dipercaya komunitas, dekat dengan keluarga, dan terbiasa membangun komunikasi berbelas rasa. Dengan kompetensi promotif, preventif, deteksi dini, serta rujukan terarah, bidan dapat menjembatani lansia perempuan untuk mendapatkan asuhan yang bermakna, aman, dan bermartabat.

Urgensi topik ini juga lahir dari kenyataan bahwa penuaan penduduk adalah tren yang tidak terelakkan. Semakin banyak perempuan akan memasuki lansia dengan beban penyakit tidak menular dan polifarmasi, sehingga kebutuhan integrasi layanan menjadi nyata: gizi yang sesuai, aktivitas fisik aman dan terukur, kesehatan mental dan sosial, keselamatan di rumah, serta dukungan spiritual dan budaya yang menghargai nilai-nilai lokal. Tanpa perspektif holistik, layanan mudah terpecah menjadi intervensi teknis yang tidak menyentuh akar kebutuhan.

Sebaliknya, pendekatan kebidanan holistik memastikan bahwa suara lansia didengar, preferensi dihormati, dan keputusan dibuat secara kolaboratif bersama keluarga serta jejaring komunitas.

Selain itu, transformasi digital menghadirkan peluang dan risiko. Aplikasi pengingat minum obat, telekonseling, dan kelompok dukungan sebaya berbasis gawai bisa mempermudah pendampingan, tetapi kesenjangan literasi digital dan akses perangkat dapat menimbulkan ketidaksetaraan baru. Bidan perlu peka pada konteks ini: memilih teknologi yang proporsional, menjaga privasi, dan memastikan solusi tetap berakar pada relasi manusiawi antara bidan, klien, dan keluarga.

2. Tujuan penulisan bab

Bab ini bertujuan menghadirkan cara pandang dan panduan praktik yang menyeluruh bagi bidan dalam mendampingi lansia perempuan. Pertama, bab ini meneguhkan landasan konseptual kebidanan holistik yang memadukan dimensi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural, sehingga pembaca memahami bahwa keluhan fisik jarang berdiri sendiri dan selalu terhubung dengan jaringan makna yang lebih luas dalam kehidupan klien. Kedua, bab ini menguatkan kompetensi praktis: bagaimana melakukan pengkajian komprehensif yang nyaman dan menghormati martabat, dari anamnesis riwayat reproduksi hingga penilaian fungsional, skrining nutrisi, kesehatan mental, risiko jatuh, kekerasan atau penelantaran, dan kebutuhan spiritual.

Ketiga, bab ini menyajikan kerangka penetapan prioritas yang realistis dan berbasis tujuan bersama, sehingga rencana asuhan tidak sekadar daftar anjuran, tetapi benar-benar relevan, dapat dilaksanakan, serta dipantau hasilnya. Keempat, bab ini menawarkan contoh intervensi non-farmakologis yang aman dan berbasis bukti: edukasi pascamenopause dan kesehatan seksual, latihan dasar panggul, aktivitas fisik yang disesuaikan, manajemen nyeri muskuloskeletal sederhana, higiene tidur, serta konseling gizi dan hidrasi; sekaligus menunjukkan kapan dan bagaimana berkolaborasi lintas profesi maupun merujuk dengan tepat.

Kelima, bab ini menempatkan komunitas sebagai mitra: peran kader, kelompok sebaya, dan program berbasis pos pelayanan terpadu lansia untuk memperkuat dukungan sosial, mencegah isolasi, serta mempromosikan lingkungan rumah yang aman dan ramah lansia. Keenam, bab ini mengulas secara ringkas isu etika, hukum, dan hak lansia, termasuk persetujuan tindakan yang bermakna, kapasitas pengambilan keputusan, perlindungan dari kekerasan, dan kerahasiaan data. Terakhir, bab ini mengajak pembaca mempertimbangkan pemanfaatan teknologi secara cerdas dan berkeadilan, serta menutup dengan

ringkasan praktik, daftar periksa, dan saran penguatan program agar pembaca dapat langsung menerapkan pelajaran di tempat kerja.

Dengan tujuan tersebut, bab ini diharapkan menjadi rujukan kerja yang membekali: tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara bidan mendengar, menilai, merencanakan, dan mendampingi, sehingga setiap pertemuan dengan lansia perempuan menjadi kesempatan untuk memulihkan makna sehat sebagai rasa utuh, aman, dan berdaya.

3. Ruang lingkup dan batasan

Ruang lingkup bab ini berfokus pada pendampingan kebidanan untuk lansia perempuan di tatanan komunitas dan pelayanan primer, termasuk rumah, praktik mandiri bidan, puskesmas, serta kegiatan berbasis kelompok seperti pos pelayanan terpadu lansia. Pembahasan mencakup pengkajian holistik, edukasi, intervensi non-farmakologis, dukungan keluarga, keselamatan di rumah, penguatan jejaring komunitas, dan kolaborasi interprofesional. Bab ini juga mengulas alur rujukan dan komunikasi efektif dengan layanan sekunder atau tersier bila muncul kondisi yang berada di luar kewenangan praktik kebidanan.

Batasan bab ini ditetapkan untuk menjaga fokus dan keselamatan praktik. Pertama, bab ini tidak membahas secara rinci tata laksana medis spesialis, tindakan invasif, atau penggunaan obat yang berada di luar kewenangan bidan; pada situasi demikian, penekanan diarahkan pada deteksi dini, stabilisasi awal sesuai prosedur, dan rujukan yang cepat serta terkoordinasi. Kedua, walaupun lansia adalah kategori yang mencakup beragam identitas, penjelasan diarahkan terutama pada kebutuhan lansia perempuan selaras dengan ruang lingkup kebidanan, seraya tetap mengakui keberagaman status perkawinan, orientasi, latar budaya, serta kondisi sosial ekonomi. Ketiga, contoh teknologi yang disertakan bersifat ilustratif dan harus dipilih dengan mempertimbangkan literasi digital klien, akses perangkat, keamanan data, dan kesesuaian konteks lokal.

B. Landasan Konseptual

1. Definisi kebidanan holistik lintas daur kehidupan

Kebidanan holistik lintas daur kehidupan memandang perempuan sebagai sosok utuh yang kebutuhan kesehatannya berubah secara dinamis sejak remaja, dewasa, pascapersalinan, hingga memasuki usia lanjut. Holistik berarti asuhan tidak berhenti pada keluhan fisik atau diagnosis tunggal, melainkan merangkul dimensi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural yang saling memengaruhi. Lintas daur kehidupan berarti bidan menempatkan kondisi lansia hari ini sebagai hasil akumulasi pengalaman reproduktif, riwayat penyakit dan gaya hidup, peran keluarga, pekerjaan, kepercayaan, serta akses layanan pada

masa sebelumnya. Dalam kerangka ini, bidan tidak sekadar menyelesaikan masalah sesaat. Bidan membantu klien membangun kesehatan yang berkelanjutan, menjaga fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup.

Pada praktiknya, kebidanan holistik untuk lansia meliputi pengkajian menyeluruh yang peka, komunikasi berbelas rasa, penetapan tujuan asuhan bersama klien dan keluarga, intervensi non farmakologis yang aman, serta kolaborasi dan rujukan terarah bila masalah melampaui kewenangan bidan. Contohnya, keluhan anyang anyangan dan inkontinensia tidak cukup ditangani dengan anjuran minum yang umum. Bidan menilai kemungkinan kelemahan dasar panggul, memeriksa asupan cairan dan obat yang berpotensi memperburuk gejala, mengeksplorasi rasa malu yang membuat klien membatasi aktivitas sosial, serta memfasilitasi latihan dasar panggul yang disesuaikan dengan kemampuan fisik. Hasil asuhan diukur bukan hanya dari berkurangnya gejala, tetapi juga dari kembalinya rasa percaya diri, berkurangnya pembatasan aktivitas, dan membaiknya tidur malam.

Kebidanan holistik juga menekankan kesinambungan. Pertemuan pertama bukan awal dan akhir, melainkan simpul dalam rangkaian pendampingan jangka panjang. Bidan menyepakati rencana tindak lanjut yang realistis, memantau kemajuan, dan menyesuaikan rencana sesuai perubahan situasi klien. Prinsip ini menghormati otonomi klien dan mengakui bahwa keputusan terbaik lahir dari negosiasi yang menghargai preferensi, nilai, dan konteks kehidupan klien.

2. Kerangka biopsikososial spiritual kultural

Kerangka ini menjelaskan bahwa kesehatan lansia perempuan ditentukan oleh interaksi lima ranah. Ranah biologis mencakup perubahan pascamenopause, kesehatan tulang, metabolisme, kardiovaskular, dan sistem urogenital, termasuk gangguan dasar panggul dan nyeri muskuloskeletal. Ranah psikologis menyentuh suasana hati, kecemasan, citra tubuh, memori, dan strategi koping. Ranah sosial berbicara tentang peran dalam keluarga multigenerasi, dukungan pengasuh, status ekonomi, relasi bertetangga, dan akses transportasi. Ranah spiritual merangkum cara klien memberi makna pada pengalaman hidup, praktik ibadah, sumber harapan, dan kebutuhan akan kepastian batin. Ranah kultural mencakup nilai, norma, dan kebiasaan lokal yang memengaruhi cara klien memandang kesehatan, mencari pertolongan, dan menerima intervensi.

Kelima ranah ini jarang bekerja terpisah. Seorang perempuan lansia dengan prolaps ringan mungkin menahan diri untuk berjalan jauh karena takut bocor. Pembatasan gerak memperburuk nyeri sendi, mengganggu tidur, dan memicu rasa tidak berdaya. Norma budaya tentang rasa malu membuat ia enggan memeriksakan diri sehingga masalah berlarut dan menurunkan partisipasi sosial.

Dalam kerangka biopsikososial spiritual kultural, bidan akan memetakan jejaring pengaruh ini melalui percakapan yang aman dan tidak menghakimi. Bidan mengukur fungsi harian, menilai risiko jatuh, meninjau obat yang dikonsumsi, memeriksa pola makan dan hidrasi, memerhatikan tanda gejala depresi, dan bertanya tentang kegiatan religius yang memberi ketenangan. Bidan juga menggali keyakinan atau pantangan tertentu yang dapat memengaruhi pilihan intervensi, misalnya preferensi pada ramuan tradisional tertentu atau keberatan terhadap latihan tubuh tertentu di ruang publik.

Rencana asuhan kemudian dirancang sebagai paket terintegrasi. Latihan dasar panggul dan edukasi kebiasaan berkemih dikombinasikan dengan strategi manajemen nyeri sederhana, penyesuaian pola minum dan makan, dukungan untuk kembali mengikuti kegiatan komunitas yang disukai, serta penguatan praktik spiritual yang memberi harapan. Bila diperlukan, bidan menghubungkan klien dengan kader posyandu lansia atau kelompok sebaya agar dukungan sosial bertambah. Apabila ditemukan tanda bahaya atau kondisi yang membutuhkan intervensi medis, rujukan dilakukan secara terencana dan dijelaskan dengan bahasa yang menghormati martabat klien. Dengan cara ini, kerangka lima ranah tidak menjadi teori yang abstrak, tetapi peta kerja yang memandu tindakan harian bidan.

3. Cultural humility, cultural safety, dan perspektif gender pada lansia

Cultural humility adalah sikap rendah hati budaya. Bidan menyadari bahwa pengetahuan tentang budaya klien tidak pernah selesai, sehingga bidan datang bukan sebagai orang yang serba tahu, tetapi sebagai mitra belajar. Praktiknya tampak dalam cara bidan bertanya dengan ingin tahu, menghindari asumsi, dan memvalidasi pengalaman klien. Ketika klien menyebut kebiasaan jamu atau pijat tradisional, bidan tidak langsung menolak. Bidan mengeksplorasi tujuan, bahan, dan cara penggunaan, lalu berdiskusi tentang keamanan serta cara memadukan praktik tersebut dengan intervensi berbasis bukti.

Cultural safety berfokus pada terciptanya rasa aman bagi klien dalam menerima layanan. Ukurannya bukan pada niat baik tenaga kesehatan, melainkan pada pengalaman klien yang merasa dihormati, tidak direndahkan, dan bebas dari prasangka. Untuk lansia perempuan, cultural safety berarti ruang konseling yang privat, kesempatan hadir bersama pendamping yang dipercaya, penjelasan tindakan dengan bahasa yang mudah, serta kebebasan menyatakan setuju atau menolak tanpa tekanan. Cultural safety juga menuntut bidan peka pada ketimpangan kekuasaan. Misalnya, keputusan kesehatan sering diambil oleh anggota keluarga yang lebih muda. Bidan memastikan suara klien tetap utama

dengan menilai kapasitas pengambilan keputusan, memfasilitasi dialog keluarga, dan mendokumentasikan persetujuan secara bermakna.

Perspektif gender pada lansia mengajak bidan melihat bahwa pengalaman menjadi perempuan sepanjang hidup membentuk risiko dan kesempatan kesehatan pada usia tua. Banyak perempuan memasuki lansia dengan jejak kerja domestik yang panjang, akses pendidikan dan ekonomi yang lebih sempit, serta norma yang membuat isu seksual dan urogenital menjadi tabu. Di saat yang sama, mereka sering menjadi penjaga tradisi keluarga dan sumber dukungan emosional bagi generasi di bawahnya. Pendekatan berperspektif gender menolak anggapan bahwa keluhan lansia adalah konsekuensi wajar yang harus diterima begitu saja. Pendekatan ini memeriksa bias yang menyepelekan nyeri dan kelelahan perempuan, membuka ruang bicara tentang seksualitas yang aman dan bermakna, serta menguatkan hak lansia perempuan untuk mendapatkan informasi dan layanan tanpa stigma.

Dalam praktik, ketiga konsep ini saling menguatkan. Bayangkan seorang janda berusia tujuh puluh tahun yang tinggal bersama anak dan cucu. Ia mengeluh nyeri lutut, sulit menahan berkemih, dan merasa malu beribadah di masjid karena takut bocor. Cultural humility mengarahkan bidan untuk bertanya tentang makna ibadah bagi klien dan kebiasaan perawatan yang ia percayai. Cultural safety memastikan sesi konseling berlangsung privat, melibatkan putri yang menjadi pendamping bila klien menghendaki, dan memberikan pilihan intervensi yang dijelaskan dengan jernih. Perspektif gender membantu bidan memahami beban kerja domestik yang tetap ia pikul serta rasa bersalah bila meminta bantuan. Dengan pemahaman ini, bidan merancang rencana yang menghormati tujuan spiritual klien, mengajarkan latihan dasar panggul yang bisa dilakukan di rumah, menata jadwal minum yang tidak mengganggu ibadah, meninjau alas kaki dan tata ruang rumah agar aman, serta menghubungkan klien dengan kelompok senam lansia di posyandu yang suasananya mendukung.

C. Profil Lansia Perempuan dan Determinan Kesehatan

1. Transisi pascamenopause dan perubahan biologis

Memasuki pascamenopause, tubuh perempuan bergerak ke fase baru yang ditandai oleh menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Perubahan ini bukan hanya soal siklus menstruasi yang berhenti, tetapi sebuah pergeseran sistemik yang menyentuh hampir setiap jaringan tubuh. Pada tingkat metabolik, distribusi lemak cenderung bergeser ke area perut sehingga lingkaran pinggang meningkat, sensitivitas insulin menurun, dan profil lipid darah berubah. Perubahan ini menjelaskan mengapa risiko penyakit kardiovaskular meningkat

pada usia lanjut. Pada tulang, kecepatan pergantian tulang condong ke arah resorpsi, yang berarti kepadatan mineral tulang menurun lebih cepat. Akibatnya, tulang lebih rapuh dan risiko patah tulang meningkat, terutama di pergelangan tangan, tulang panggul, dan tulang belakang. Otot pun tidak luput dari perubahan. Massa dan kekuatan otot berkurang perlahan, kondisi yang sering disebut sebagai penurunan massa dan fungsi otot, sehingga keseimbangan tubuh dan kecepatan berjalan ikut terpengaruh.

Perubahan pada jaringan urogenital sering menjadi keluhan utama, tetapi kerap dipendam karena tabu. Penipisan dinding vagina dapat menimbulkan rasa kering, gatal, perih, dan nyeri saat berhubungan seksual. Produksi pelumas alami berkurang, pH vagina berubah, dan ekosistem mikroba menjadi kurang stabil sehingga keluhan berulang di area tersebut lebih mudah muncul. Pada saat yang sama, jaringan penopang dasar panggul melemah. Kombinasinya melahirkan gejala seperti rasa berat di panggul, menonjolnya jaringan dari jalan lahir, serta bocor saat batuk, tertawa, atau beraktivitas. Bagi banyak perempuan, gejala ini disertai rasa malu, takut berbau, atau kekhawatiran mencemari tempat ibadah. Dampak psikologisnya tidak kecil karena rasa percaya diri menurun dan partisipasi sosial menyusut.

Gejala vasomotor seperti rasa panas tiba-tiba, berkeringat di malam hari, dan gangguan tidur bisa bertahan sampai usia lanjut, meski intensitasnya bervariasi. Kualitas tidur yang terganggu berimbas pada konsentrasi, suasana hati, dan toleransi terhadap rasa tidak nyaman. Pada kulit dan mukosa, hidrasi berkurang, kolagen menipis, dan penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Mulut dan mata lebih kering, yang mengganggu kenyamanan harian dan meningkatkan risiko masalah gigi serta infeksi. Di ranah kognitif, sebagian perempuan merasakan melambatnya pemrosesan informasi atau mudah lupa, sering kali diperparah oleh tidur yang buruk, kecemasan, atau beban sosial yang tinggi.

Bagi bidan, memahami lanskap biologis ini membantu memilih pendekatan yang tepat. Penguatan latihan dasar panggul, edukasi higiene tidur, penataan pola minum yang cermat, dukungan untuk kembali aktif secara fisik, serta komunikasi yang aman dan penuh hormat tentang kesehatan seksual adalah pintu masuk yang efektif. Pengkajian yang menyeluruh sebaiknya tidak hanya mencatat keluhan, tetapi juga memetakan aktivitas harian, faktor pencetus, strategi koping, dan tujuan penting yang ingin dicapai klien, misalnya kembali beribadah dengan nyaman atau berjalan ke pasar tanpa takut bocor. Ketika ditemukan tanda bahaya seperti perdarahan abnormal, nyeri panggul yang menetap, atau curiga patah tulang, rujukan yang jelas dan terstruktur perlu segera dilakukan.

2. Penyakit tidak menular, komorbid, dan polifarmasi

Banyak perempuan memasuki lansia dengan satu atau lebih penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan lemak darah, penyakit jantung, penyakit sendi degeneratif, dan gangguan tulang. Di samping itu ada kondisi yang sering luput dari pembicaraan, misalnya gangguan tiroid, gangguan saluran pernapasan kronik ringan, atau gangguan ginjal tahap awal. Tidak jarang pula ditemukan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, serta penurunan kognitif yang masih dini. Kehadiran beberapa penyakit pada saat bersamaan membuat rencana asuhan menjadi lebih rumit. Anjuran yang baik untuk satu penyakit bisa berbenturan dengan kebutuhan penyakit lain. Misalnya, pembatasan cairan untuk keluhan berkemih justru memperburuk pusing saat berdiri pada klien dengan tekanan darah rendah, atau latihan fisik yang terlalu berat memperparah nyeri sendi.

Kerumitan ini berlipat ketika menyangkut penggunaan obat. Polifarmasi merujuk pada penggunaan banyak obat secara bersamaan, termasuk obat yang dibeli sendiri dan suplemen atau jamu. Pada lansia, metabolisme hati dan fungsi ginjal menurun sehingga tubuh lebih sensitif terhadap efek obat. Beberapa golongan obat dapat menyebabkan kantuk, pusing, kebingungan, atau konstipasi berat. Obat penenang dan obat tidur meningkatkan risiko jatuh. Obat nyeri tertentu mengganggu lambung dan ginjal jika digunakan berkepanjangan. Obat penurun gula darah bisa menyebabkan gula darah turun tiba-tiba bila pola makan tidak teratur. Ramuan tradisional atau suplemen yang tampak aman pun kadang berinteraksi dengan obat resep, terutama bila mengandung komponen yang memengaruhi pembekuan darah atau tekanan darah.

Peran bidan dalam konteks ini adalah menjadi penjaga gerbang yang teliti. Setiap pertemuan dapat dimanfaatkan untuk melakukan rekonsiliasi obat, yaitu menuliskan ulang semua obat, suplemen, dan jamu yang benar-benar digunakan, beserta dosis dan jadwalnya. Bidan dapat menanyakan tujuan setiap obat, efek samping yang dirasakan, serta kesulitan mematuhi jadwal minum obat. Dari sini, bidan membantu mengidentifikasi obat yang mungkin tidak lagi diperlukan, yang berisiko tinggi, atau yang saling berinteraksi, lalu mengkomunikasikan temuannya kepada dokter keluarga atau dokter penanggung jawab untuk pertimbangan pengurangan obat secara bertahap. Di saat yang sama, edukasi sederhana sangat berdampak, seperti menggunakan kotak obat harian, memberi label besar dan jelas, menyelaraskan jadwal minum obat dengan rutinitas ibadah, dan melibatkan anggota keluarga yang menjadi pendamping utama. Pendekatan ini menurunkan risiko jatuh, kebingungan mendadak, dan rawat inap yang sebenarnya bisa dicegah.

3. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan dukungan keluarga

Kesehatan lansia perempuan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Banyak yang tinggal di rumah tangga multigenerasi, memegang peran domestik yang besar, atau justru hidup sendiri karena pasangan telah meninggal dan anak tinggal di kota lain. Dukungan keluarga menjadi pelindung penting, tetapi juga bisa menjadi sumber tekanan jika komunikasi tidak sejalan atau beban kerja rumah tangga tidak dibagi secara adil. Dalam budaya yang menekankan rasa sungkan, preferensi lansia perempuan sering tidak dinyatakan keras, sehingga keputusan kesehatan diambil oleh anggota keluarga yang lebih muda. Bidan dapat memfasilitasi dialog keluarga agar suara klien tetap menjadi pusat keputusan, sekaligus mengajarkan cara memberi dukungan yang menghormati kemandirian.

Status ekonomi memengaruhi pilihan makanan, akses transportasi ke fasilitas kesehatan, kemampuan memodifikasi rumah agar aman, hingga ketersediaan perangkat bantu seperti tongkat atau alas kaki yang memadai. Pendidikan dan literasi kesehatan menentukan cara klien memahami anjuran, membaca label obat, dan menilai informasi yang diterima dari media sosial atau lingkungan. Kesenjangan literasi digital dapat membuat telekonseling dan aplikasi pengingat obat terasa asing. Di sinilah komunitas menjadi jembatan. Posyandu lansia, kelompok senam pagi, pertemuan keagamaan, dan organisasi warga mampu mengurangi isolasi sosial serta menyebarkan informasi kesehatan yang praktis dan dapat dipercaya. Bagi perempuan yang masih aktif bekerja informal, jadwal intervensi perlu mengikuti ritme kehidupan sehari-hari agar anjuran tidak terasa sebagai beban tambahan.

Lingkungan fisik rumah dan sekitar rumah memiliki dampak langsung terhadap keselamatan. Lantai licin, penerangan redup, kabel yang melintang, kamar mandi tanpa pegangan, anak tangga tinggi, dan alas kaki yang tidak pas adalah faktor risiko jatuh yang nyata. Ventilasi yang buruk dan penggunaan bahan bakar memasak yang menghasilkan asap memperburuk kesehatan pernapasan. Suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin mengganggu tidur dan dapat memicu gangguan jantung pada kelompok rentan. Perubahan iklim menambah lapisan risiko, misalnya gelombang panas yang lebih sering atau banjir yang mengganggu akses layanan kesehatan. Penilaian lingkungan yang sederhana saat kunjungan rumah, disertai saran perbaikan kecil yang realistis, sering kali menghasilkan manfaat besar. Memasang lampu malam, menyediakan alas anti slip di kamar mandi, menata ulang perabot agar jalur berjalan lebih lebar, dan memastikan botol air minum mudah dijangkau dapat menurunkan risiko jatuh dan dehidrasi.

Dukungan keluarga dan komunitas juga berperan dalam kesehatan mental. Kesepian, duka berkepanjangan, atau perundungan berbasis usia dapat memperburuk keluhan fisik dan menurunkan motivasi menjaga diri. Keterlibatan dalam kegiatan yang bermakna, seperti mengasuh cucu dengan jadwal yang disepakati, berkebun, kerajinan tangan, atau pertemuan ibadah, memulihkan rasa bernilai dan terhubung. Bidan dapat memetakan jejaring dukungan ini bersama klien, merekomendasikan kegiatan yang sesuai minat, dan bila perlu menghubungkan dengan pekerja sosial atau kader kesehatan masyarakat.

Seluruh determinan ini saling mengikat. Perubahan biologis memengaruhi daya tahan fisik dan suasana hati. Penyakit tidak menular dan polifarmasi menambah beban harian. Sementara itu, kekuatan atau kelemahan dukungan sosial ekonomi dan lingkungan menentukan apakah anjuran kesehatan dapat dijalankan. Pendampingan kebidanan yang efektif menerima kenyataan ini dan merancang asuhan sebagai rangkaian langkah kecil yang konsisten, terukur, dan sesuai tujuan hidup klien. Dengan cara itu, kesehatan tidak lagi dipahami semata sebagai ketiadaan penyakit, melainkan sebagai kemampuan menjalani peran yang bermakna, merasa aman di rumah sendiri, dan tetap terhubung dengan keluarga serta komunitas.

D. Peran, Kewenangan, dan Kompetensi Bidan

1. Ranah praktik dan batas rujukan

Peran bidan dalam pendampingan lansia perempuan berakar pada pelayanan promotif, preventif, deteksi dini, pertolongan pertama, serta rujukan terkoordinasi. Ranah praktiknya berada terutama di tingkat keluarga, komunitas, praktik mandiri bidan, dan fasilitas layanan primer seperti puskesmas. Fokus utama adalah menjaga fungsi dan kualitas hidup klien melalui pengkajian komprehensif, edukasi yang dapat dipraktikkan, intervensi non farmakologis yang aman, serta pemantauan berkelanjutan. Dalam kunjungan rumah, misalnya, bidan menilai kondisi umum, tekanan darah, status hidrasi dan nutrisi, kebugaran fisik, kesehatan dasar panggul, pola tidur, suasana hati, serta faktor lingkungan seperti risiko jatuh di kamar mandi atau lorong rumah. Hasil pengkajian diterjemahkan menjadi rencana asuhan yang disepakati bersama klien dan keluarga, lengkap dengan tujuan yang terukur dan jadwal tindak lanjut.

Kewenangan bidan mencakup konseling kesehatan pascamenopause dan uroginekologi dasar, latihan otot dasar panggul, promosi aktivitas fisik yang sesuai, edukasi gizi dan hidrasi, manajemen gejala ringan dengan langkah non farmakologis, pencegahan jatuh melalui modifikasi rumah sederhana, serta deteksi dini masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada gejala

seperti inkontinensia ringan, bidan dapat memadukan latihan dasar panggul, pelatihan kebiasaan berkemih, penataan konsumsi cairan, dan dukungan psikososial agar klien kembali percaya diri beraktivitas. Bila klien mengonsumsi banyak obat, bidan melakukan rekonsiliasi obat secara hati-hati, mengidentifikasi kemungkinan tumpang tindih atau efek samping, lalu mengomunikasikan temuannya kepada dokter penanggung jawab agar evaluasi farmakoterapi dapat dilakukan. Semua tindakan dilakukan dengan merujuk pada prosedur operasional baku dan standar profesi yang berlaku.

Batas rujukan harus jelas sejak awal agar keselamatan klien terjaga. Bidan merujuk segera ketika menemukan tanda bahaya atau kondisi di luar kewenangan. Contohnya perdarahan pascamenopause, nyeri panggul yang menetap, kecurigaan fraktur, tekanan darah sangat tinggi disertai gejala bahaya, gula darah tidak terkontrol, kebingungan mendadak atau kecurigaan delirium, kecurigaan depresi berat atau ide bunuh diri, tanda kekerasan atau penelantaran lansia, retensi urin akut, prolaps berat, atau infeksi saluran kemih berulang disertai demam. Rujukan tidak sebatas mengirim klien ke fasilitas yang lebih tinggi. Bidan menyiapkan ringkasan klinis yang rapi, menghubungi jejaring kolaborator seperti dokter keluarga, dokter penyakit dalam, dokter kebidanan dan kandungan, urolog, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan pekerja sosial, lalu memastikan umpan balik pasca rujukan kembali diintegrasikan ke rencana asuhan di komunitas. Dengan cara ini, kesinambungan layanan tetap terjaga dan klien tidak merasa "dilepas" ketika berpindah antar fasilitas.

2. Komunikasi berbelas rasa dan konseling berpusat pada klien

Pendampingan yang efektif lahir dari komunikasi yang berbelas rasa, aman, dan menghormati martabat. Pada lansia perempuan, topik yang dibahas sering menyentuh area yang dianggap pribadi, seperti kebocoran urin, nyeri saat berhubungan seksual, rasa sepi setelah kehilangan pasangan, atau ketakutan jatuh ketika sendirian di rumah. Bidan memulai dengan menciptakan ruang yang privat dan tenang, memperkenalkan tujuan pertemuan, serta menegaskan bahwa klien berhak memilih apa yang ingin dibicarakan. Teknik mendengar aktif digunakan sepanjang percakapan, termasuk memberi jeda, menyimpulkan kembali inti ucapan klien untuk memastikan pemahaman, dan mengakui perasaan yang muncul. Bahasa yang digunakan sederhana dan tidak menghakimi, serta selaras dengan budaya dan keyakinan klien.

Konseling berpusat pada klien berarti keputusan dibuat melalui kolaborasi yang menghargai nilai, preferensi, dan tujuan hidup klien. Alih-alih sekadar memberi daftar larangan atau perintah, bidan membantu klien menimbang manfaat dan risiko dari setiap pilihan, lalu memfasilitasi rencana kecil yang

realistis. Pada klien yang enggan mengikuti senam kelompok karena takut bocor, misalnya, bidan dapat memulai dari latihan dasar panggul di rumah, menata jadwal minum agar tidak berdekatan dengan waktu ibadah atau bepergian, dan menyusun target bertahap seperti berjalan di halaman rumah sebelum bergabung dengan kelompok senam di pos layanan terpadu lansia. Pendekatan ini selaras dengan teknik wawancara memotivasi, yang menguatkan alasan perubahan yang berasal dari diri klien sendiri, bukan paksaan dari tenaga kesehatan atau keluarga.

Bidan juga peka terhadap dinamika kekuasaan dalam keluarga. Keputusan kesehatan lansia sering dipengaruhi oleh anak atau menantu yang berniat baik. Tugas bidan adalah menjaga agar suara klien tetap menjadi pusat tanpa menciptakan konflik. Caranya dengan memfasilitasi dialog keluarga, menjelaskan informasi medis dengan jernih, menilai kapasitas pengambilan keputusan klien, dan mendokumentasikan persetujuan tindakan secara bermakna. Saat budaya setempat mendorong penggunaan ramuan tradisional atau pijat, bidan tidak tergesa menolak. Yang dilakukan adalah mengeksplorasi tujuan penggunaan, menilai keamanan dan potensi interaksi dengan obat, dan bila aman, memadukannya dengan intervensi berbasis bukti. Dengan pendekatan seperti ini, hubungan saling percaya tumbuh dan kepatuhan terhadap rencana asuhan meningkat.

3. Tanggung jawab etik dan profesional

Asuhan kebidanan untuk lansia perempuan harus berdiri di atas fondasi etik dan profesional yang kokoh. Prinsip utama meliputi menghargai otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, dan adil. Menghargai otonomi berarti memastikan klien memahami informasi yang relevan dan memberikan persetujuan yang benar benar disadari sebelum intervensi dilakukan. Pada lansia, bidan menilai kemampuan klien memahami informasi dan membuat keputusan. Jika kapasitas menurun, keputusan dilakukan dengan melibatkan pendamping yang sah, tetap berupaya mempertahankan sebanyak mungkin suara klien dalam prosesnya. Berbuat baik dan tidak merugikan terwujud melalui pemilihan intervensi yang bermanfaat, aman, dan proporsional, serta kehati hatian terhadap risiko jatuh, interaksi obat, dan kelelahan akibat anjuran yang terlalu berat. Keadilan menuntut bidan memperjuangkan akses setara bagi klien yang rentan, termasuk mereka yang tinggal jauh dari fasilitas, memiliki keterbatasan ekonomi, atau menghadapi hambatan bahasa.

Kerahasiaan adalah pilar lain yang tidak boleh dinegosiasikan. Informasi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, aktivitas seksual, dan kondisi rumah tangga disimpan dengan aman dan hanya dibagi kepada pihak lain atas

persetujuan klien, kecuali bila ada risiko serius yang mengancam keselamatan. Di era pencatatan digital, bidan menjaga kata sandi, menggunakan perangkat yang aman, dan mematuhi kebijakan perlindungan data. Dokumentasi klinis dilakukan lengkap, jelas, dan tepat waktu. Catatan yang baik mencerminkan proses berpikir klinis, isi konseling, keputusan bersama, serta rencana tindak lanjut. Dokumentasi juga memudahkan kolaborasi dan audit mutu.

Profesionalisme menuntut bidan jujur tentang batas kompetensinya. Ketika menemui masalah di luar kewenangan, bidan tidak menunda rujukan. Untuk menjaga kompetensi, pembaruan pengetahuan dan keterampilan dilakukan secara berkala melalui pelatihan, diskusi kasus, pembacaan bukti ilmiah, dan refleksi praktik. Bidan berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu, seperti audit sederhana terhadap pencegahan jatuh, rekonsiliasi obat, atau kepuasan klien, lalu menggunakan temuan audit untuk perbaikan layanan. Bila terjadi insiden keselamatan, bidan bersikap terbuka, memberikan penjelasan jujur kepada klien dan keluarga, melakukan penanganan yang diperlukan, serta menyusun langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.

Tanggung jawab etik juga mencakup pengelolaan konflik kepentingan dan menjaga batas profesional. Ketika bekerja dekat dengan keluarga atau komunitas kecil, kedekatan personal mudah terjadi. Bidan tetap menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, menghindari penerimaan hadiah yang berlebihan, dan memastikan keputusan klinis tidak dipengaruhi hubungan non profesional. Dalam kolaborasi antar profesi, bidan berkomunikasi dengan hormat dan jelas, berbagi informasi yang relevan, serta menghargai keahlian masing-masing pihak. Semua ini dilakukan dengan tujuan akhir yaitu keselamatan, martabat, dan kualitas hidup lansia perempuan.

E. Pengkajian Holistik Terintegrasi

1. Anamnesis sepanjang daur reproduktif dan riwayat kesehatan

Pengkajian dimulai dengan percakapan yang hangat dan aman, karena kualitas informasi sangat bergantung pada kenyamanan klien. Bidan memperkenalkan tujuan pertemuan, menegaskan kerahasiaan, lalu membuka ruang bagi klien untuk bercerita dengan bahasanya sendiri. Riwayat reproduktif ditelusuri dari awal: usia saat menstruasi pertama, pola menstruasi sepanjang hidup, kehamilan dan persalinan yang pernah dialami, komplikasi obstetri, penggunaan kontrasepsi di masa lalu, serta kapan haid berhenti sepenuhnya. Pertanyaan dilanjutkan pada gejala pascamenopause yang masih dirasakan, seperti rasa panas mendadak, kering di vagina, nyeri saat berhubungan seksual, penurunan dorongan seksual, sering berkemih, sulit menahan berkemih, atau

rasa berat di panggul. Penting pula mengeksplorasi riwayat infeksi saluran kemih berulang, perdarahan dari jalan lahir setelah menopause, ataupun keluarnya jaringan dari vagina ketika mengejan, karena temuan ini menentukan arah pemeriksaan berikutnya dan kebutuhan rujukan.

Riwayat kesehatan umum mencakup penyakit yang saat ini diderita atau pernah dialami (tekanan darah tinggi, diabetes melitus, gangguan lemak darah, penyakit jantung, penyakit tulang dan sendi, gangguan tiroid, penyakit ginjal, gangguan pernapasan, dan lain-lain), riwayat rawat inap, pembedahan, alergi, imunisasi, serta riwayat jatuh dalam dua belas bulan terakhir. Bidan memetakan seluruh obat yang sedang digunakan, termasuk obat resep, obat bebas, suplemen, dan ramuan tradisional, beserta dosis dan jadwalnya. Di tahap ini, bidan tidak terburu menilai benar atau salah; tujuan utamanya adalah mendapatkan gambaran lengkap agar risiko interaksi dan efek samping dapat diantisipasi.

Kebiasaan hidup sehari-hari juga ditanyakan: pola makan dan minum, kebiasaan konsumsi garam dan gula, asupan protein, durasi tidur, kebiasaan aktivitas fisik, penggunaan tembakau atau alkohol jika ada, serta kebiasaan yang secara budaya bermakna seperti minum jamu atau pijat. Aspek psikososial meliputi kondisi pernikahan atau status janda, tinggal bersama siapa, peran dalam rumah tangga, sumber dukungan, beban merawat cucu atau anggota keluarga sakit, pengalaman duka yang belum selesai, dan aktivitas bermakna yang memberikan rasa tujuan. Terakhir, bidan menanyakan harapan pribadi klien: apa yang ingin diperbaiki terlebih dahulu, hambatan apa yang dirasakan, dan hasil seperti apa yang dianggap penting, misalnya bisa beribadah tanpa khawatir bocor atau mampu berjalan ke pasar tanpa nyeri. Anamnesis yang kaya seperti ini membantu menyusun rencana asuhan yang realistis, personal, dan bermartabat.

2. Pemeriksaan fisik umum dan uroginekologis

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan alur yang tenang dan penjelasan sederhana di setiap langkah. Dimulai dari pengamatan umum: kesadaran, kontak mata, gaya berjalan, kelincahan bergerak, dan kondisi kebersihan diri. Tanda vital diukur lengkap, termasuk evaluasi perubahan tekanan darah ketika berpindah dari berbaring ke berdiri untuk menilai penurunan tekanan darah saat berdiri yang sering menjadi penyebab pusing dan jatuh pada lansia. Berat badan, tinggi badan, serta perhitungan indeks massa tubuh dicatat, disertai pengamatan massa otot lengan dan tungkai sebagai petunjuk awal penurunan massa dan kekuatan otot.

Pemeriksaan kepala dan leher menilai penglihatan, pendengaran, kesehatan mulut dan gigi, serta kelenjar tiroid. Pemeriksaan dada dan jantung menilai bunyi napas, bunyi jantung, dan tanda-tanda sesak tersembunyi. Abdomen diperiksa untuk menilai nyeri tekan, pembesaran organ, serta rasa penuh kandung kemih. Pemeriksaan punggung dan anggota gerak mengevaluasi kelenturan, postur, nyeri sendi, kekuatan genggam, keseimbangan saat berdiri, serta kestabilan ketika berputar.

Pemeriksaan uroginekologis dilakukan dengan sangat menghormati privasi. Bidan menjelaskan tujuan dan pilihan, serta memastikan klien setuju sebelum melanjutkan. Pemeriksaan dapat diawali dengan inspeksi eksternal pada area genital untuk menilai kebersihan, kondisi kulit, tanda iritasi atau infeksi, serta kemungkinan penipisan jaringan yang khas pada pascamenopause. Penilaian dasar panggul dapat dilakukan secara non-invasif: meminta klien batuk atau mengejan untuk menilai ada tidaknya kebocoran atau penonjolan jaringan, dan menginstruksikan kontraksi otot dasar panggul sambil mengamati gerakan perineum. Bila ditemukan dugaan penurunan organ panggul yang bermakna, perdarahan setelah menopause, atau kelainan yang memerlukan pemeriksaan internal atau alat khusus, bidan menjelaskan perlunya rujukan ke fasilitas yang berwenang. Pendekatan yang hati-hati seperti ini menjaga keselamatan sekaligus rasa aman klien.

3. Penilaian fungsional, mencakup aktivitas harian dan aktivitas instrumental

Kesehatan lansia tidak hanya diukur dari penyakitnya, tetapi terutama dari kemampuan menjalankan aktivitas yang bermakna. Karena itu, penilaian fungsional menjadi jantung pengkajian. Bidan menanyakan secara rinci kemampuan mandi, berpakaian, makan, berpindah posisi dari duduk ke berdiri, menggunakan toilet, dan mengontrol berkemih serta buang air besar. Untuk aktivitas yang lebih kompleks, bidan mengeksplorasi kemampuan berbelanja, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menggunakan telepon, mengelola keuangan, meminum obat sesuai jadwal, serta menggunakan transportasi.

Setiap kemampuan tidak cukup dinilai sekadar bisa atau tidak. Bidan menggali apakah klien memerlukan bantuan sebagian, berapa lama waktu yang dibutuhkan, apakah ada rasa takut ketika melakukannya, dan alat bantu apa yang sudah tersedia. Misalnya, klien mungkin dapat mandi sendiri tetapi memilih tidak melakukannya setiap hari karena kamar mandi licin dan tidak ada pegangan. Informasi seperti ini membuka pintu solusi sederhana namun berdampak, seperti memasang alas anti selip atau pegangan dinding, menyiapkan kursi mandi, atau mengatur jadwal pendampingan keluarga. Penilaian fungsional juga menjadi

dasar penyusunan tujuan asuhan yang terukur, misalnya meningkatkan kemampuan berdiri dari kursi tanpa bantuan sebanyak lima kali berturut-turut dalam waktu tertentu, yang berhubungan dengan kekuatan otot tungkai dan risiko jatuh.

4. Skrining kesehatan mental dan kognitif

Kesehatan mental dan fungsi kognitif adalah bagian tak terpisahkan dari kualitas hidup. Bidan membangun percakapan yang menghormati, kemudian menanyakan suasana hati dalam beberapa minggu terakhir, hilangnya minat pada kegiatan yang biasanya menyenangkan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, rasa bersalah atau tidak berguna, serta munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Pertanyaan ini tidak dimaksudkan menghakimi, melainkan membuka ruang agar klien tidak menanggung beban sendirian. Jika ada gejala depresi berat, kecemasan yang melumpuhkan, atau pikiran untuk menyakiti diri, kebutuhan rujukan segera dijelaskan dengan empatik dan konkret.

Fungsi kognitif dinilai dengan cara yang ramah: menanyakan keluhan lupa yang mengganggu kegiatan harian, kesulitan mengelola uang atau obat, tersesat di tempat yang familiar, atau bingung terhadap waktu. Pemeriksaan sederhana dapat berupa mengingat tiga kata yang tidak berkaitan lalu diminta menyebutkan kembali beberapa menit kemudian, menyebutkan hari dan tanggal, serta menggambar jam untuk menilai perencanaan dan eksekusi tugas. Bidan juga waspada terhadap delirium, yaitu kebingungan mendadak yang sering dipicu infeksi, dehidrasi, atau obat tertentu; gejalanya bisa fluktuatif dalam sehari, disertai gangguan perhatian. Delirium memerlukan penanganan medis segera. Hasil skrining didokumentasikan rapi, dan tindak lanjut dirancang sesuai kebutuhan, termasuk kolaborasi dengan psikolog, dokter, atau pekerja sosial.

5. Skrining nutrisi dan risiko jatuh

Masalah gizi pada lansia sering tersembunyi. Bidan menilai perubahan berat badan yang tidak direncanakan dalam tiga sampai enam bulan terakhir, nafsu makan, kebiasaan makan sendiri atau bersama, kesulitan mengunyah atau menelan, kesehatan gigi dan mulut, serta kemampuan menyiapkan makanan. Asupan protein, sayur, buah, dan cairan dikaji, sambil memperhatikan pantangan budaya dan kebiasaan setempat. Pemeriksaan lingkaran lengan atas dan pengamatan massa otot memberi petunjuk awal tentang penurunan massa dan kekuatan otot. Edukasi yang diberikan bersifat praktis: cara meningkatkan asupan protein dengan bahan lokal yang terjangkau, membagi porsi kecil tapi sering pada klien yang mudah kenyang, serta menempatkan air minum di lokasi yang mudah dijangkau untuk mencegah dehidrasi.

Risiko jatuh dinilai melalui kombinasi riwayat dan pengamatan. Riwayat jatuh sebelumnya, rasa tidak stabil ketika berdiri, penglihatan yang menurun, penggunaan obat penenang atau obat tidur, alas kaki yang tidak pas, dan hambatan di rumah adalah faktor penting. Pengamatan dapat meliputi kemampuan bangkit dari kursi tanpa menggunakan tangan, kecepatan berjalan normal, dan stabilitas saat berputar. Penilaian lingkungan rumah, terutama kamar mandi, tangga, dan jalur menuju tempat tidur, membantu mengidentifikasi bahaya. Intervensi sederhana seperti memasang pegangan, memperbaiki pencahayaan, menyingkirkan kabel yang melintang, memilih alas kaki yang menutup tumit, dan melatih penguatan otot tungkai sering kali menurunkan risiko jatuh secara bermakna. Semua rekomendasi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan dukungan keluarga.

6. Skrining kekerasan dan penelantaran lansia

Bidan harus peka terhadap kemungkinan kekerasan fisik, psikologis, seksual, finansial, maupun penelantaran. Skrining dilakukan secara privat, tanpa kehadiran orang yang mungkin menjadi pelaku, dengan pertanyaan yang sederhana dan tidak menghakimi, misalnya apakah ada seseorang di rumah yang membuat klien takut, membentak, membatasi pertemuan dengan orang lain, mengambil uang tanpa izin, atau menolak memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar seperti makan dan mandi. Tanda fisik seperti memar pada lokasi yang tidak lazim, luka yang tidak sesuai penjelasan, kebersihan diri yang buruk, pakaian yang tidak layak, tanda dehidrasi, atau obat yang tidak diminum sebagaimana mestinya perlu dicermati.

Jika kecurigaan muncul, keselamatan klien menjadi prioritas. Bidan menjelaskan pilihan yang tersedia sesuai aturan setempat: merujuk ke layanan medis lanjutan, menghubungkan dengan pekerja sosial, melibatkan aparat berwenang jika ada ancaman langsung, serta menyusun rencana keselamatan sederhana seperti memiliki nomor telepon darurat dan tempat aman untuk meminta pertolongan. Dokumentasi dibuat netral, faktual, mencatat ucapan klien apa adanya, temuan fisik, dan langkah yang disepakati. Sepanjang proses, bidan menjaga kerahasiaan dan menghormati keputusan klien sejauh tidak membahayakan keselamatan.

7. Penilaian spiritual, nilai, dan preferensi budaya

Dimensi spiritual sering menjadi sumber kekuatan utama pada usia lanjut. Bidan mengundang percakapan tentang apa yang memberi makna dan harapan bagi klien: praktik ibadah, kegiatan komunitas, nilai-nilai keluarga, dan hal-hal yang ingin terus dilakukan meskipun terbatas. Pertanyaan sederhana seperti "Apa yang penting bagi Ibu saat ini?" atau "Apa yang membantu Ibu merasa tenang?"

membuka peluang menautkan rencana asuhan dengan tujuan hidup yang lebih dalam. Preferensi budaya misalnya kebutuhan menjaga aurat, preferensi pendamping perempuan selama pemeriksaan, pantangan makanan, tata cara berpakaian, atau pilihan pengobatan tradisional dieksplorasi dengan rendah hati, tanpa prasangka.

Penilaian ini bukan formalitas; ia menentukan keberterimaan intervensi. Jika klien menghindari kegiatan kelompok karena khawatir ritual ibadah terganggu oleh kebocoran urin, jadwal minum dan latihan dasar panggul dapat diatur agar tidak berbenturan dengan waktu ibadah. Jika klien mengonsumsi ramuan tertentu, bidan menilai keamanan dan berdiskusi tentang cara menggunakannya agar tidak bertabrakan dengan obat dokter. Bila klien ingin mendiskusikan harapan jangka panjang, termasuk preferensi perawatan ketika sakit berat, bidan merespons dengan empati, mengajak keluarga terlibat sesuai keinginan klien, dan mencatat kesepakatan yang lahir dari proses tersebut. Dengan begitu, asuhan terasa relevan, manusiawi, dan setia pada nilai yang dihayati klien.

Pengkajian holistik terintegrasi tidak berjalan linier, melainkan sebuah percakapan berkelanjutan yang setiap bagiannya saling meneguhkan. Informasi dari anamnesis memperkaya fokus pemeriksaan fisik; temuan fungsional menuntun skrining nutrisi dan jatuh; hasil skrining mental dan kognitif memengaruhi cara menyampaikan edukasi; penilaian spiritual dan budaya memastikan setiap saran memiliki “bahasa” yang dimengerti dan diterima. Ketika semua potongan ini dirangkai, bidan memiliki peta yang jelas untuk menyusun rencana asuhan yang aman, efektif, dan bermartabat—serta cukup lentur untuk disesuaikan dengan perubahan kehidupan klien dari waktu ke waktu.

F. Penetapan Permasalahan dan Prioritas Asuhan

1. Daftar masalah, faktor penyebab, dan sumber daya

Penetapan masalah dimulai dari keberanian untuk merangkum seluruh hasil pengkajian menjadi beberapa pernyataan yang jelas, ringkas, dan dapat ditindaklanjuti. Bidan memisahkan antara keluhan yang dirasakan klien, temuan objektif saat pemeriksaan, dan risiko yang mungkin terjadi bila tidak ada intervensi. Dari sana, bidan merumuskan setiap masalah dengan menyebutkan apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi menurut dugaan klinis yang paling kuat, serta bukti yang mendukung. Perumusan yang rapi membantu keluarga dan jejaring kolaborasi memahami inti persoalan, sekaligus mencegah rencana asuhan melebar tanpa arah.

Bayangkan seorang perempuan berusia tujuh puluh dua tahun yang datang dengan keluhan sering berkemih, kadang tidak tertahan saat batuk, nyeri lutut

saat menaiki tangga, dan tidur yang terputus di malam hari. Ia memakai tiga macam obat harian dan dua suplemen, tinggal bersama anak, dan aktif mengikuti kegiatan ibadah namun akhir-akhir ini enggan hadir karena takut "bocor." Dari pemeriksaan, tekanan darahnya baik, indeks massa tubuh sedikit di atas normal, kekuatan otot tungkai menurun, kamar mandi tanpa pegangan, dan lampu lorong redup. Bila temuan ini ditulis ulang secara sistematis, muncul beberapa masalah utama: kebocoran urin yang mengganggu partisipasi sosial, kualitas tidur buruk yang menurunkan energi harian, nyeri lutut yang membatasi mobilitas, serta lingkungan rumah yang meningkatkan risiko jatuh.

Setiap masalah jarang berdiri sendiri. Kebocoran urin, misalnya, sering terkait kelemahan otot dasar panggul, kebiasaan minum yang tidak teratur, konsumsi kafein sore hari, penggunaan obat tertentu yang meningkatkan produksi urin, atau jadwal minum obat di malam hari. Nyeri lutut mungkin berasal dari penyakit sendi degeneratif yang diperburuk oleh kurangnya penguatan otot, alas kaki yang tidak menopang telapak dengan baik, dan lantai rumah yang licin. Sementara kualitas tidur yang buruk dapat dipicu frekuensi berkemih malam hari, kecemasan, atau paparan cahaya yang tidak memadai menjelang tidur. Menyebutkan faktor penyebab tidak berarti menyalahkan klien; tujuannya adalah mengidentifikasi tuas perubahan yang paling realistis.

Pada saat yang sama, bidan memetakan sumber daya kekuatan internal dan dukungan eksternal yang dapat dipakai untuk menggerakkan perubahan. Kekuatan internal bisa berupa motivasi klien untuk kembali aktif di kegiatan ibadah, kemampuan belajar gerakan sederhana, dan keyakinan spiritual yang menjadi sumber harapan. Dukungan eksternal mencakup anak yang bersedia membantu modifikasi rumah, kader pos pelayanan terpadu lansia yang menjalankan senam mingguan, kelompok sebaya yang hangat, serta akses ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi interprofesional. Sumber daya finansial dan waktu juga dinilai jujur agar anjuran tidak menambah beban. Ketika masalah, penyebab, dan sumber daya dipetakan bersamaan, bidan memiliki "peta jalan" yang konkrit: apa yang paling mendesak, tuas mana yang paling bisa digerakkan, dan penopang apa yang sudah tersedia.

Penetapan prioritas kemudian muncul dari dialog. Ukuran yang dipakai tidak hanya keparahan klinis, tetapi juga dampaknya pada keselamatan, peluang perbaikan cepat, dan yang terpenting: apa yang paling bermakna bagi klien. Bila klien sangat takut jatuh di kamar mandi dan itu membuatnya menahan minum, maka pencegahan jatuh di kamar mandi serta penataan pola minum bisa menjadi prioritas awal. Bila rasa malu akibat kebocoran membuat klien menarik diri dari komunitas, maka penguatan otot dasar panggul dan pelatihan kebiasaan

berkemih mendapat tempat teratas. Pendekatan ini menghormati tujuan hidup klien dan sering kali meningkatkan kepatuhan, karena perubahan dirasakan relevan sejak hari pertama.

2. Tujuan asuhan jangka pendek dan panjang (SMART)

Setelah prioritas disepakati, bidan menerjemahkannya menjadi tujuan yang konkret dengan kaidah “spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.” Tujuan jangka pendek berfungsi sebagai langkah awal yang memberikan rasa berhasil, sementara tujuan jangka panjang menjaga arah perjalanan agar tetap konsisten dengan nilai dan aspirasi klien.

Tujuan yang spesifik menyebutkan dengan jelas perilaku atau hasil yang ingin diubah. “Mengurangi kebocoran” terlalu kabur; yang dibutuhkan adalah rumusan seperti “mengurangi kejadian kebocoran urin pada siang hari dari lima kali menjadi dua kali.” Tujuan yang terukur mencantumkan angka atau indikator yang dapat dihitung, sehingga kemajuan tidak bergantung pada rasa “kayaknya lebih baik.” Pengukuran bisa sesederhana catatan harian jumlah kebocoran, jumlah kunjungan ke kamar mandi pada malam hari, atau kemampuan berdiri dari kursi tanpa bantuan dalam sekali percobaan.

Tujuan yang dapat dicapai memperhitungkan kondisi fisik, dukungan keluarga, dan lingkungan. Meminta klien melakukan latihan dasar panggul tiga kali sehari selama lima menit mungkin realistis; memaksa hadir di kelas senam setiap pagi pukul enam mungkin tidak, bila transportasi sulit atau jam itu bertabrakan dengan tugas rumah tangga. Tujuan yang relevan memastikan setiap langkah benar-benar terkait dengan masalah utama dan nilai yang penting bagi klien. Bila yang dirindukan klien adalah kembali mengikuti ibadah berjamaah, maka rencana latihan harus disusun agar tidak mengganggu waktu ibadah dan justru mendukung keberanian untuk hadir kembali. Terakhir, batas waktu membuat semua pihak tahu kapan menilai hasil dan menyesuaikan rencana. Tanpa tenggat, evaluasi mudah tertunda dan kemajuan sulit dilacak.

Sebagai contoh, untuk masalah kebocoran urin, tujuan jangka pendek dapat dirumuskan seperti ini: dalam empat minggu, klien melakukan latihan otot dasar panggul di rumah tiga kali sehari selama lima menit, membatasi minuman berkafein setelah pukul tiga sore, dan menata jadwal berkemih setiap dua jam pada siang hari. Indikator keberhasilan adalah penurunan kejadian kebocoran dari lima menjadi tiga kali per hari, meningkatnya rasa percaya diri berjalan ke warung terdekat, dan tidur malam yang hanya terbangun maksimal dua kali untuk berkemih. Untuk tujuan jangka panjang, dalam tiga bulan klien menstabilkan latihan otot dasar panggul, mengikuti senam lansia seminggu sekali sesuai kenyamanan, dan mampu menghadiri ibadah berjamaah dua kali seminggu tanpa

rasa takut bocor. Indikatornya adalah kejadian kebocoran maksimal satu kali per hari, tidak ada jatuh di kamar mandi, dan laporan kualitas hidup yang membaik menurut penilaian klien sendiri.

Pada masalah nyeri lutut yang membatasi mobilitas, tujuan jangka pendek dapat berupa pelatihan penguatan otot tungkai dua hari sekali dengan gerakan sederhana yang diajarkan bidan, penggunaan alas kaki yang lebih menopang, serta pemasangan alas anti-selip di kamar mandi dalam dua minggu pertama. Indikatornya adalah mampu berdiri dari kursi tanpa bantuan sebanyak lima kali berturut-turut dan berjalan di halaman selama lima menit tanpa nyeri yang mengganggu. Tujuan jangka panjang mungkin berupa kemampuan berjalan keluar rumah selama lima belas menit dua kali seminggu dan naik turun dua anak tangga dengan pegangan tanpa nyeri yang bermakna dalam tiga bulan. Keduanya relevan karena mobilitas yang lebih baik menurunkan risiko jatuh, mendukung partisipasi sosial, dan memperkuat kepercayaan diri.

Semua tujuan disusun bersama klien dan, bila diinginkan, bersama anggota keluarga yang menjadi pendamping utama. Partisipasi keluarga penting untuk menyesuaikan jadwal latihan dengan ritme rumah tangga, membagi tugas domestik agar klien punya waktu istirahat, dan mengingatkan minum obat atau latihan tanpa nuansa memerintah. Bila tujuan melibatkan perubahan pada obat—misalnya memindahkan jadwal obat yang meningkatkan produksi urin dari malam ke sore hari—bidan mengomunikasikan rencana kepada dokter penanggung jawab dan mendokumentasikan persetujuan yang diperoleh. Koordinasi ini mencegah tumpang tindih anjuran dan mengurangi risiko efek samping.

Evaluasi terjadwal adalah bagian dari tujuan berbatas waktu. Pada akhir periode yang disepakati, bidan dan klien meninjau indikator: apakah jumlah kebocoran berkurang, apakah kemampuan berdiri membaik, apakah kualitas tidur meningkat, dan apakah rasa percaya diri kembali. Bila hasil belum sesuai harapan, pendekatan tidak dinilai gagal, melainkan perlu penyesuaian. Mungkin kontraksi otot dasar panggul belum dilakukan dengan benar dan perlu demonstrasi ulang. Mungkin kamar mandi masih licin dan perlu tambahan pegangan. Mungkin beban emosional belum tertangani dan konseling singkat atau rujukan psikolog akan membantu. Sikap luwes ini menjaga rencana tetap hidup dan relevan, bukan sekadar daftar tugas yang menambah lelah.

G. Perencanaan Asuhan Individual dan Berbasis Keluarga

Perencanaan asuhan dimulai ketika gambaran kebutuhan klien sudah jelas dan prioritas bersama telah disepakati. Tujuannya adalah menerjemahkan data

pengkajian menjadi rangkaian tindakan yang saling terhubung, logis, dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana yang baik selalu bersifat individual, berakar pada nilai dan tujuan klien, serta realistis terhadap sumber daya keluarga dan komunitas. Pada lansia perempuan, rencana asuhan yang kuat biasanya menggabungkan intervensi klinis non farmakologis, modifikasi lingkungan rumah, dukungan psikososial, penguatan spiritual, dan kolaborasi antarpihak, kemudian diikat oleh jadwal tindak lanjut yang jelas.

1. Rencana intervensi terintegrasi

Intervensi disebut terintegrasi ketika setiap komponen saling menguatkan alih-alih berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, pada klien dengan kebocoran urin, nyeri lutut, dan tidur terputus, rencana tidak hanya berisi latihan otot dasar panggul. Latihan tersebut digandengkan dengan penataan jadwal minum, pelatihan kebiasaan berkemih, edukasi memilih alas kaki yang menutup tumit dan menopang lengkung telapak, serta penguatan otot tungkai yang melindungi lutut. Di sisi lain, kebiasaan tidur dibenahi melalui rutinitas malam yang konsisten, pembatasan kafein sore hari, dan pencahayaan kamar yang lebih tenang. Semua langkah itu diatur agar tidak bertabrakan dengan waktu ibadah dan aktivitas rumah tangga, sehingga perubahan terasa wajar dan tidak memberatkan.

Kebutuhan keamanan di rumah dipadukan sejak awal. Pegangan dinding dipasang di kamar mandi, alas anti selip ditambahkan, jalur berjalan dirapikan, dan lampu malam diletakkan di koridor. Edukasi obat dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi obat yang rapi, termasuk suplemen dan ramuan tradisional yang digunakan. Tujuannya adalah menurunkan risiko pusing, kantuk, atau interaksi yang memperburuk keluhan. Bila terdapat obat yang diduga memicu berkemih malam atau melemahkan keseimbangan, bidan menyiapkan catatan temuan yang sopan dan jelas untuk dibahas bersama dokter penanggung jawab. Intervensi psikososial berjalan beriringan, misalnya menghubungkan klien dengan kelompok senam lansia di pos pelayanan terpadu atau kelompok pengajian yang hangat, sehingga motivasi meningkat dan rasa terhubung kembali tumbuh.

Rencana terintegrasi selalu memuat cara memantau kemajuan. Indikator sederhana disepakati bersama, seperti jumlah kejadian kebocoran per hari, berapa kali terbangun untuk berkemih pada malam hari, kemampuan berdiri dari kursi tanpa bantuan, atau keberanian kembali hadir di kegiatan komunitas. Catatan harian yang ringkas sering sangat membantu. Bila klien nyaman menggunakan telepon pintar, pengingat latihan dan minum obat dapat dipasang. Bila tidak, kartu kecil di tempat yang sering terlihat sudah cukup efektif. Dengan pendekatan seperti ini, perubahan kecil menjadi nyata dan dapat dirayakan, sementara hambatan segera terlihat untuk disesuaikan.

2. Pelibatan keluarga dan pengasuh

Asuhan pada lansia jarang berhasil bila dikerjakan sendirian. Keluarga dan pengasuh adalah mitra utama, namun pelibatan mereka perlu diatur agar tetap menghormati otonomi klien. Langkah awal adalah memetakan siapa saja yang tinggal serumah, siapa yang paling sering mendampingi, dan bagaimana dinamika pengambilan keputusan berlangsung sehari-hari. Dari sini, ditetapkan satu orang kontak utama keluarga yang akan menerima ringkasan rencana, jadwal, dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Penetapan ini mencegah kebingungan pesan dan mengurangi rasa lelah karena instruksi yang berubah-ubah.

Keluarga dibekali pelatihan singkat yang sangat praktis. Jika fokus utamanya latihan dasar panggul, pengasuh belajar cara memberi isyarat yang sopan, mengenali kontraksi yang benar, serta membantu klien mengingat latihan tanpa memberi tekanan. Bila targetnya pencegahan jatuh, keluarga diajak mencoba simulasi bangkit aman dari kursi, teknik berjalan di kamar mandi, serta cara menata ulang perabot agar jalur bergerak lebih lebar. Pengelolaan obat dijelaskan dengan bahasa yang tidak teknis. Kotak obat mingguan disusun bersama, label diperbesar, dan jadwal minum obat diselaraskan dengan ritme keluarga, misalnya setelah sarapan atau menjelang ibadah, sehingga pengingat terjadi secara alami.

Pelibatan keluarga juga berarti menjaga keluarga dari kejenuhan dan rasa kewalahan. Bidan mendengarkan beban yang dirasakan pengasuh, mengakui kerja emosional yang mereka lakukan, dan menawarkan strategi sederhana untuk berbagi tugas. Bila memungkinkan, disusun giliran di antara anggota keluarga atau tetangga dekat untuk keperluan tertentu seperti mengantar ke pos pelayanan terpadu atau menemani kontrol. Komunikasi keluarga difasilitasi dengan cara yang menjaga martabat klien. Ketika ada perbedaan pendapat, bidan membantu memusatkan diskusi pada tujuan klien sendiri. Bila muncul sinyal kekerasan verbal, kontrol finansial yang tidak wajar, atau penelantaran, bidan mengalihkan fokus ke keselamatan klien, menjelaskan pilihan bantuan yang tersedia, dan melibatkan jejaring berwenang sesuai kebutuhan dan aturan setempat.

3. Rencana tindak lanjut dan rujukan

Setiap rencana membutuhkan irama tindak lanjut yang konsisten. Jadwal kunjungan atau panggilan ulang disepakati sejak awal, lengkap dengan apa yang akan dicek pada setiap pertemuan. Minggu pertama biasanya berfokus pada keterampilan inti yang baru diajarkan, misalnya teknik kontraksi otot dasar panggul atau kebiasaan tidur yang lebih teratur. Minggu kedua dan ketiga

menilai penyesuaian lingkungan rumah, kemandirian dalam menggunakan kotak obat, dan apakah keluarga sudah nyaman dengan peran barunya. Pada akhir bulan pertama, indikator yang disepakati dievaluasi bersama. Jika hasil belum sesuai harapan, rencana tidak dinilai gagal. Rencana dianggap perlu disederhanakan, digeser urutannya, atau ditambah dukungan yang sebelumnya belum tersedia.

Rujukan dipersiapkan sejak rencana awal sebagai jaring pengaman, bukan sebagai pertanda kegagalan. Bidan menjelaskan dengan jernih kondisi yang memerlukan evaluasi dokter, seperti perdarahan setelah menopause, kecurigaan infeksi saluran kemih dengan demam, kebingungan mendadak, nyeri panggul atau nyeri tulang yang persisten, kecurigaan penurunan organ panggul berat, atau gula darah yang sukar terkendali. Ketika rujukan diperlukan, bidan menyiapkan ringkasan yang ringkas namun lengkap yang berisi keluhan utama, riwayat singkat, temuan penting pemeriksaan, obat yang digunakan, intervensi yang sudah dilakukan, dan pertanyaan rujukan yang spesifik. Ringkasan ini mempersingkat waktu dan meningkatkan mutu kolaborasi di layanan lanjutan.

Setelah rujukan, kesinambungan asuhan dijaga. Hasil kunjungan spesialis atau dokter keluarga diintegrasikan kembali ke rencana komunitas. Jika fisioterapis menambahkan program penguatan lutut tertentu, jadwal rumah disesuaikan. Jika dokter mengubah obat yang memicu berkemih malam, pengingat keluarga diperbarui. Bila psikolog merekomendasikan sesi konseling singkat, bidan membantu menyiapkan ruang aman di rumah dan memantau perubahan suasana hati. Pada setiap pertemuan, bidan kembali ke kompas utama yaitu tujuan klien. Apakah klien merasa lebih berdaya, lebih aman di rumah, dan lebih leluasa menjalankan peran yang bermakna. Jika jawabannya iya, rencana dapat dinaikkan tingkat tantangannya secara bertahap. Jika belum, rencana dipangkas menjadi langkah yang lebih kecil dan mudah dicapai.

Untuk memudahkan semua pihak, dokumentasi dibuat sederhana dan konsisten. Satu halaman ringkas berisi tujuan, langkah harian, siapa melakukan apa, kapan dievaluasi, serta tanda bahaya yang harus segera ditindaklanjuti sering kali cukup. Dokumen yang sama menjadi alat komunikasi antaranggota keluarga, pengingat bagi klien, serta panduan bagi kader komunitas. Dengan cara ini, perencanaan asuhan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi peta bersama yang memandu tindakan sehari-hari, menenangkan karena jelas, dan luwes karena selalu bisa disesuaikan.

4. Skenario singkat yang memadukan ketiganya

Seorang perempuan berusia tujuh puluh satu tahun ingin kembali rutin menghadiri ibadah berjamaah, namun cemas karena kebocoran urin dan lutut

yang nyeri. Ia tinggal bersama anak dan menantu yang suportif, serta memiliki akses ke pos pelayanan terpadu lansia sepekan sekali. Rencana intervensi terintegrasi menyatukan latihan otot dasar panggul tiga kali sehari, latihan penguatan otot tungkai dua hari sekali, penataan jadwal minum agar tidak berdekatan dengan waktu ibadah, dan pemasangan pegangan di kamar mandi. Keluarga dilatih memberi pengingat dengan bahasa yang tidak memerintah dan menyusun kotak obat mingguan. Tindak lanjut dijadwalkan satu minggu, tiga minggu, dan empat minggu. Indikator yang disepakati adalah kejadian kebocoran siang berkurang setengahnya, bangun malam maksimal dua kali, dan mampu berdiri dari kursi tanpa bantuan lima kali berturut-turut. Bila pada evaluasi empat minggu hasil mendekati target, rencana ditingkatkan dengan bergabung ke senam lansia. Bila jauh dari target, bidan menilai kembali teknik latihan, menanyakan hambatan di rumah, dan mempertimbangkan rujukan ke fisioterapis atau dokter bila diperlukan.

H. Intervensi Klinis Non-Farmakologis Utama

1. Edukasi pascamenopause, kesehatan seksual, dan uroginekologi

Edukasi yang baik dimulai dari ruang yang aman, bahasa yang sederhana, dan pengakuan bahwa perubahan setelah menopause bersifat wajar sekaligus sangat personal. Bidan menjelaskan bahwa penurunan hormon berdampak pada banyak sistem tubuh, termasuk jaringan vagina, kandung kemih, dasar panggul, tidur, suasana hati, dan kulit. Pengetahuan ini membantu klien memahami mengapa keluhan seperti kering di vagina, nyeri saat berhubungan, sering berkemih, atau kebocoran saat batuk dapat muncul. Percakapan dilanjutkan dengan strategi praktis yang bisa dilakukan di rumah. Untuk kenyamanan seksual, pelumas berbasis air dipakai saat berhubungan dan pelembap vagina digunakan secara teratur untuk menjaga kelembapan jaringan. Kebersihan area genital dijaga tanpa praktik yang mengiritasi seperti pembersih internal atau pewangi. Bila ada perdarahan setelah menopause, rasa nyeri panggul yang menetap, atau keluhan yang tidak membaik dengan langkah sederhana, bidan menjelaskan perlunya evaluasi dokter agar penyebab serius tidak terlewat.

Kesehatan uroginekologi dibahas dengan cara yang membebaskan rasa malu. Klien diajak mengenali pola minum dan berkemihnya sendiri, misalnya menata jarak minum pada siang hari dan mengurangi minuman berkafein menjelang sore agar tidak sering terbangun malam. Kebiasaan "menahan" terlalu lama dihindari karena dapat mengiritasi kandung kemih. Teknik relaksasi napas dipraktikkan untuk membantu menenangkan sensasi ingin berkemih yang datang tiba-tiba. Semua langkah itu disesuaikan dengan nilai dan aktivitas harian klien,

termasuk waktu ibadah, sehingga perubahan terasa masuk akal dan tidak mengganggu peran di rumah ataupun komunitas.

2. Latihan dasar panggul, aktivitas fisik aman, dan pencegahan jatuh

Latihan dasar panggul adalah pilar utama pada keluhan kebocoran urin, rasa berat di panggul, atau pencegahan penurunan organ. Bidan membantu klien menemukan otot yang tepat dengan isyarat sederhana, yaitu bayangkan menahan keluarnya gas dan menahan aliran urin, kemudian melepaskannya kembali. Tekanannya lembut, tidak sampai menahan napas atau mendorong ke bawah. Kontraksi dilakukan pelan, ditahan beberapa detik, lalu dilepas selama durasi yang sama. Setelah nyaman, klien menambahkan beberapa kontraksi cepat untuk melatih refleks saat batuk atau tertawa. Latihan tidak memerlukan alat dan dapat disisipkan pada rutinitas harian seperti setelah salat, usai menyikat gigi, atau ketika menunggu air mendidih. Pada pertemuan berikutnya, bidan mengecek teknik kembali karena kualitas kontraksi lebih penting daripada jumlahnya.

Aktivitas fisik ditata dengan prinsip mulai rendah, naik bertahap, dan selalu aman. Tujuannya menjaga kekuatan otot, kelenturan, keseimbangan, dan daya tahan yang menopang kemandirian. Jalan santai, senam lansia, bersepeda statis, latihan penguatan otot menggunakan berat tubuh sendiri, serta latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan adalah pilihan yang umum. Pemanasan singkat dan pendinginan dilakukan agar sendi dan otot siap bekerja. Jika ada penyakit jantung, gangguan pernapasan, atau nyeri sendi berat, rencana latihan disesuaikan dan tanda bahaya dijelaskan dengan jelas, misalnya nyeri dada, sesak yang tidak biasa, atau pusing hebat. Alas kaki yang menutup tumit, pas di kaki, dan memiliki tapak anti-selip sangat membantu stabilitas.

Pencegahan jatuh menggabungkan latihan tubuh dengan modifikasi lingkungan. Bidan meninjau kamar mandi, koridor, dan kamar tidur untuk memastikan pencahayaan memadai, lantai tidak licin, kabel tidak melintang, serta tersedia pegangan di titik rawan seperti dekat kloset dan area mandi. Klien diajarkan cara bangkit dari kursi dengan aman, yaitu menempatkan kaki kokoh di lantai, condong sedikit ke depan, lalu berdiri perlahan sambil berpegangan bila perlu. Untuk mengurangi pusing saat berdiri, klien disarankan bangun bertahap dari posisi berbaring ke duduk lalu berdiri, dan menggerakkan pergelangan kaki beberapa kali sebelum melangkah. Penglihatan dan pendengaran yang menurun juga ditangani melalui rujukan yang sesuai karena alat bantu yang tepat sering menurunkan risiko jatuh secara signifikan.

3. Manajemen nyeri muskuloskeletal dan tidur sehat

Nyeri sendi lutut, punggung bawah, atau bahu kerap membuat aktivitas berkurang, padahal tubuh yang kurang bergerak justru lebih mudah kaku dan nyeri. Pendekatan non-farmakologis berfokus pada edukasi, penguatan bertahap, peregangan ringan, dan ergonomi. Bidan mengajarkan gerak harian yang aman seperti cara mengangkat benda dekat ke tubuh, menekuk lutut saat mengambil barang rendah, serta mengatur tinggi meja kerja atau dapur agar bahu tidak cepat lelah. Kompres hangat yang aman membantu melonggarkan kekakuan sebelum aktivitas, sedangkan kompres dingin singkat dapat dipakai setelah aktivitas bila ada nyeri tumpul. Program penguatan sederhana untuk otot paha dan pinggul menurunkan beban pada lutut, sementara peregangan lembut pada punggung dan betis memperbaiki pola gerak. Semua disusun dalam “dosis” kecil yang konsisten agar klien tidak kewalahan.

Tidur sehat tidak hanya menambah energi, tetapi juga menurunkan persepsi nyeri. Rutinitas tidur yang tetap, paparan cahaya pagi, dan menghindari tidur siang yang terlalu panjang membantu ritme tidur bangun menjadi stabil. Menjelang malam, minuman berkafein dan layar gawai dibatasi, aktivitas yang menegangkan ditunda, dan tubuh dibantu rileks dengan mandi hangat singkat atau pernapasan pelan. Bagi klien yang sering terbangun untuk berkemih, jadwal minum diatur agar porsi besar tidak berada di malam hari, kamar mandi diberi lampu malam, dan jalur berjalan dirapikan agar aman. Bila mendengkur keras, napas tersendat saat tidur, atau rasa mengantuk berat di siang hari, bidan menjelaskan perlunya pemeriksaan lanjutan karena gangguan tidur yang tidak tertangani akan mengganggu kesehatan jantung dan fungsi kognitif.

4. Konseling gizi dan hidrasi pada lansia

Tujuan konseling gizi adalah memastikan energi cukup, protein memadai untuk menjaga massa otot, asupan serat yang baik untuk pencernaan, serta kecukupan vitamin dan mineral dari bahan makanan yang akrab dan terjangkau. Piring makan harian mudah dibayangkan sebagai setengah bagian berisi sayur dan buah beragam warna, seperempat sumber karbohidrat yang tidak berlebihan, dan seperempat sumber protein yang berganti-ganti seperti tempe, tahu, telur, ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, atau daging tanpa lemak. Bagi klien yang cepat kenyang, porsi kecil tetapi lebih sering lebih berhasil daripada memaksa porsi besar. Tekstur makanan disesuaikan dengan kondisi gigi dan mulut, misalnya sayur yang dimasak cukup lunak dan lauk yang dipotong kecil. Bila ada penyakit tertentu seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit ginjal, atau penyakit hati, bidan menyesuaikan pesan umum dengan batasan yang dianjurkan dokter atau ahli gizi agar aman.

Hidrasi yang baik menjaga kewaspadaan, tekanan darah, serta kesehatan kulit dan mukosa. Banyak lansia sengaja mengurangi minum karena takut sering ke kamar mandi, padahal dehidrasi justru memicu pusing saat berdiri, konstipasi, dan infeksi saluran kemih berulang. Bidan membantu membuat jadwal minum yang tersebar rapi sepanjang hari, menempatkan botol air di lokasi yang mudah dijangkau, dan memilih minuman yang tidak mengiritasi kandung kemih pada sore hari. Pada kondisi tertentu seperti gagal jantung atau penyakit ginjal, jumlah cairan disesuaikan dengan anjuran dokter. Tanda dehidrasi ringan seperti bibir kering, mulut lengket, urin berwarna pekat, atau pusing saat berdiri dipaparkan agar keluarga dapat segera membantu sebelum kondisi memburuk. Edukasi label makanan juga bermanfaat, terutama untuk membatasi gula tambahan dan garam yang tersembunyi dalam makanan kemasan.

5. Dukungan kesehatan mental dan pencegahan isolasi sosial

Kesehatan mental tidak terpisah dari kesehatan fisik, dan pada usia lanjut pengalaman duka, perubahan peran, serta berkurangnya lingkaran sosial dapat menekan semangat. Bidan membuka percakapan yang hangat tentang suasana hati, rasa cemas, atau rasa kehilangan yang mungkin masih membekas. Validasi sederhana bahwa perasaan sedih atau cemas adalah wajar sering sudah melegakan. Dari sana, bidan membantu menyusun kegiatan harian yang memberi rasa makna, misalnya merawat tanaman, membaca bersama cucu, membuat kerajinan, atau menghadiri pertemuan keagamaan yang disukai. Teknik napas pelan, relaksasi otot bertahap, dan perhatian pada momen kini membantu menurunkan ketegangan.

Pencegahan isolasi sosial dilakukan dengan memulihkan koneksi yang aman dan menyenangkan. Kelompok senam lansia di posyandu, kelompok pengajian, arisan lingkungan, atau klub hobi menjadi tempat yang meningkatkan rasa terhubung. Bagi klien yang tidak nyaman hadir karena kebocoran urin atau nyeri sendi, rencana non-farmakologis di atas disesuaikan agar kendala utama teratasi terlebih dahulu, lalu partisipasi sosial meningkat bertahap. Keluarga diajak membuat "jaringan pengingat" sederhana, misalnya panggilan telepon singkat oleh anggota keluarga pada jam yang disepakati atau menemani aktivitas luar rumah seminggu sekali sampai klien kembali percaya diri. Bila muncul tanda depresi sedang hingga berat, kecemasan yang melumpuhkan, atau pikiran untuk mengakhiri hidup, bidan menjelaskan dengan empati bahwa bantuan profesional sangat penting dan menyiapkan rujukan yang cepat serta aman. Kolaborasi dengan psikolog atau konselor memperkaya pendampingan, sementara komunitas tetap menjadi rumah yang menjaga keberlanjutan dukungan.

Keseluruhan intervensi non-farmakologis ini bekerja paling efektif ketika disatukan dalam rencana yang sederhana, konsisten, dan sesuai tujuan hidup klien. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari, seperti tiga set kontraksi dasar panggul, lima menit peregangan, satu gelas air tambahan di pagi hari, dan satu kegiatan sosial bermakna setiap pekan, dapat menghasilkan perbaikan besar dari waktu ke waktu. Peran bidan adalah menjaga agar langkah-langkah kecil itu terus bergerak, menyesuaikan rencana ketika ada hambatan, serta memastikan klien dan keluarga merasa didengar, dihargai, dan mampu mengelola kesehatannya dengan bermartabat.

I. Intervensi Berbasis Komunitas

1. Posyandu lansia atau kelompok sebaya dan peran kader

Posyandu lansia dan kelompok sebaya adalah jantung dari pendampingan berbasis komunitas karena menyatukan layanan kesehatan, dukungan sosial, dan edukasi dalam ruang yang akrab bagi warga. Hari layanan yang baik dimulai dari suasana yang ramah. Kader menyambut, membantu pendaftaran, dan memastikan setiap lansia merasa dihargai, bukan dinilai. Alur sederhana memudahkan semua pihak: pengukuran dasar seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan lingkaran lengan atas; skrining cepat fungsi harian, risiko jatuh, suasana hati, dan keluhan uroginekologis; lalu sesi konseling singkat yang diarahkan oleh bidan dengan dukungan kader. Setelah itu, kegiatan penutup berupa senam ringan, peregangan, atau latihan keseimbangan dilakukan bersama untuk menegaskan bahwa promosi kesehatan adalah aktivitas yang menyenangkan, bukan beban.

Peran kader menjadi pembeda antara posyandu yang sekadar mengukur dan posyandu yang benar-benar mengubah perilaku. Kader adalah jembatan bahasa, budaya, dan kepercayaan. Mereka membantu menjelaskan materi dengan contoh yang membumi, ikut memantau tindak lanjut di rumah, dan menjadi pengingat yang manusiawi. Agar peran ini kuat, kader memerlukan pelatihan yang terstruktur tetapi praktis: cara mengukur tanda vital dengan benar, mengenali tanda bahaya, memfasilitasi percakapan tanpa menggurui, memberikan contoh latihan dasar panggul, mengajarkan teknik bangkit aman dari kursi, dan mendampingi penggunaan kotak obat mingguan. Kader juga dibekali keterampilan pencatatan sederhana agar data kehadiran, hasil skrining, dan tindak lanjut tercatat rapi. Data ini bukan sekadar angka, melainkan alat untuk melihat pola, misalnya siapa yang berulang kali jatuh, siapa yang mengalami penurunan berat badan, atau siapa yang tidak pernah kembali untuk kontrol.

Bidan memposisikan diri sebagai pelatih dan pengarah klinis. Setiap bulan, bidan dapat menentukan tema yang menanggapi kebutuhan lokal. Jika banyak laporan kebocoran urin, sesi praktik latihan otot dasar panggul diprioritaskan dan kader dilatih untuk memantau teknik di rumah. Bila yang menonjol adalah keluhan nyeri lutut, fokus diarahkan ke penguatan otot tungkai, pemilihan alas kaki, dan penataan kamar mandi agar lebih aman. Posyandu juga menjadi tempat membangun keberanian membahas isu yang kerap tabu, seperti nyeri saat berhubungan seksual atau rasa malu karena kebocoran. Dengan ruang yang aman dan pendampingan kader, topik sensitif dapat diurai menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan bersama.

2. Program promosi kesehatan dan lingkungan ramah lansia

Promosi kesehatan di komunitas menjadi efektif ketika tidak berhenti pada ceramah, melainkan menyentuh cara lingkungan mendukung keputusan sehat. Kampung ramah lansia, sekolah ramah lansia, rumah ibadah ramah lansia, dan fasilitas umum ramah lansia adalah bentuk konkret dari pendekatan ini. Prosesnya dimulai dari pemetaan partisipatif: bidan, kader, pengurus lingkungan, dan perwakilan lansia berjalan bersama menyusuri jalur yang lazim dilalui lansia, mencatat titik gelap, lantai licin, anak tangga curam, jalur yang tersumbat barang, dan lokasi kamar mandi yang sulit dijangkau. Hasil pemetaan dibawa ke pertemuan warga untuk disepakati langkah perbaikan yang realistis, misalnya memasang pegangan di kamar mandi umum, menambah lampu koridor, menandai anak tangga dengan pita kontras, merapikan kabel, menambah bangku untuk beristirahat di jalur yang panjang, serta menyiapkan jalur evakuasi sederhana jika wilayah rawan banjir.

Promosi kesehatan yang berhasil menempel pada rutinitas sosial warga. Materi tentang hidrasi aman, pencegahan jatuh, atau tidur berkualitas disisipkan dalam arisan, pertemuan pengajian, pertemuan karang taruna, dan kegiatan kerja bakti. Demonstrasi langsung selalu lebih bermanfaat daripada sekadar penjelasan. Mengajak warga mencoba berdiri satu kaki sambil berpegangan, memperagakan cara bangkit dari kursi, atau menunjukkan contoh pegangan murah yang aman akan memicu ide-ide lokal yang kreatif. Kolaborasi lintas sektor memperkuat dampak: pengurus lingkungan membantu regulasi kecil seperti jam musik malam agar tidur warga tidak terganggu, pengelola tempat ibadah menyediakan ruang duduk yang lebih empuk dan toilet yang mudah diakses, pedagang setempat diajak menata ulang etalase agar ada ruang berjalan yang cukup, dan fasilitas kesehatan primer mendukung dengan bahan edukasi yang konsisten.

Perubahan iklim menambah dimensi baru yang perlu diantisipasi. Gelombang panas, kualitas udara yang buruk, atau banjir yang mengganggu akses layanan dapat memperburuk kondisi lansia. Program komunitas memasukkan pesan sederhana tentang manajemen suhu ruangan, pengingat minum pada hari yang sangat panas, rencana cadangan obat, dan daftar kontak darurat. Dengan cara ini, promosi kesehatan tidak hanya mengajarkan perilaku individu, tetapi juga menata lingkungan agar pilihan sehat menjadi pilihan yang paling mudah.

3. Pemberdayaan dan jejaring dukungan sosial

Pemberdayaan berarti memindahkan pusat kendali dari tenaga kesehatan ke warga, terutama lansia itu sendiri. Bidan memfasilitasi pembentukan kelompok sebaya yang memiliki tujuan jelas, misalnya kelompok jalan pagi, kelompok latihan dasar panggul, atau kelompok memasak sehat dengan bahan lokal. Kelompok ini berjalan dengan prinsip saling dukung, bukan kompetisi. Setiap pertemuan diawali saling kabar, dilanjutkan kegiatan inti, lalu ditutup dengan komitmen kecil yang dapat dilakukan pekan berikutnya. Kader memegang peran sebagai penjaga ritme agar kelompok tetap hidup ketika semangat sempat turun, sementara bidan datang berkala untuk memberi umpan balik teknis dan memastikan aspek keselamatan diperhatikan.

Jejaring dukungan sosial harus mencakup keluarga, tetangga, pemimpin lokal, organisasi keagamaan, dan pelaku usaha setempat. Keluarga dilibatkan tidak hanya sebagai pengingat, tetapi juga sebagai penerima dukungan agar tidak kewalahan. Jadwal pendampingan dibagi, kesempatan istirahat pengasuh disepakati, dan sinyal kelelahan pengasuh dikenali. Tetangga yang peduli dapat menjadi mata tambahan untuk memantau lingkungan, misalnya membantu menyalakan lampu lorong di malam hari atau menyingkirkan barang yang menghalangi jalur. Pemimpin lokal berperan memberi legitimasi pada perubahan, misalnya mengumumkan komitmen kampung ramah lansia dan menetapkan hari tertentu untuk senam bersama. Pelaku usaha menyediakan dukungan kecil yang berdampak besar, seperti kursi tambahan di warung untuk tempat istirahat, air minum gratis untuk lansia yang lewat, atau potongan harga alas kaki yang aman melalui kerja sama komunitas.

Teknologi digunakan secara secukupnya untuk memperkuat, bukan menggantikan, pertemuan tatap muka. Grup pesan singkat keluarga atau kelompok sebaya dapat dipakai untuk pengingat latihan, jadwal posyandu, atau berbagi foto kemajuan yang memotivasi. Namun, tidak semua lansia nyaman dengan gawai sehingga selalu disediakan alternatif non digital seperti kartu pengingat yang ditempel di lemari es, kalender dinding dengan stiker, atau

panggilan telepon berkala oleh kader. Di sisi lain, privasi dijaga. Informasi kesehatan tidak dibagikan di grup umum tanpa persetujuan yang jelas, dan percakapan sensitif tetap dilakukan secara pribadi.

Jalur rujukan sosial menjadi bagian dari jejaring. Bila terdeteksi tanda kekerasan, penelantaran, kesulitan ekonomi yang berat, atau duka yang berkepanjangan, kader tidak dibiarkan menanggung sendiri. Bidan menyediakan daftar layanan rujukan yang mudah diakses, menjelaskan pilihan kepada klien dan keluarga, serta memastikan tindak lanjut tidak terputus. Pendekatan ini menghindarkan komunitas dari rasa “mengurusi” tanpa kapasitas, sekaligus memastikan bantuan yang tepat tiba pada waktu yang tepat.

Kekuatan intervensi berbasis komunitas terletak pada konsistensi kecil yang berulang. Posyandu yang hangat, lingkungan yang sedikit demi sedikit menjadi lebih aman, dan kelompok dukungan yang terus bertemu akan menumbuhkan kebiasaan sehat yang bertahan lama. Dalam ekosistem seperti ini, bidan bukan satu-satunya motor, melainkan bagian dari orkestra yang rapi: kader menjaga ritme harian, keluarga memberi harmoni di rumah, pemimpin lokal menjaga nada kebijakan, dan lansia sendiri memegang kendali atas lagu hidupnya. Ketika semua unsur saling menguatkan, perubahan yang semula tampak kecil akan bertumpuk menjadi penurunan kejadian jatuh, berkurangnya isolasi sosial, perbaikan kualitas tidur, dan meningkatnya

J. Kolaborasi Interprofesional dan Alur Rujukan

Kolaborasi interprofesional tidak sekadar bekerja bersama dalam satu gedung, melainkan menyusun satu rencana asuhan yang menyatu, transparan, dan mengalir mulus dari rumah, komunitas, layanan primer, hingga layanan rujukan. Pada pendampingan lansia perempuan, bidan memegang peran sebagai pengarah lalu lintas informasi, penjaga keselamatan, sekaligus advokat yang memastikan tujuan dan nilai klien tetap menjadi pusat keputusan. Kolaborasi yang sehat dimulai dari kesepahaman tentang peran tiap profesi, dilanjutkan dengan komunikasi yang terstruktur, dan ditutup dengan umpan balik yang kembali ke komunitas agar kontinuitas perawatan terjaga.

1. Kolaborasi dengan perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan pekerja sosial

Hubungan kerja yang efektif dibangun dengan cara yang sangat konkret. Perawat di layanan primer atau perawat komunitas adalah mitra dekat dalam pemantauan harian. Mereka membantu memperkuat edukasi, menilai kepatuhan terhadap latihan dan obat, memonitor tanda bahaya, serta menjadi penghubung cepat ketika ada perubahan kondisi. Dokter keluarga atau dokter layanan primer

memimpin penegakan diagnosis medis, menata terapi obat, dan menentukan kebutuhan pemeriksaan penunjang. Pada kasus tertentu, dokter penyakit dalam, dokter kebidanan dan kandungan, atau dokter urologi terlibat ketika ada kecurigaan penurunan organ panggul yang bermakna, perdarahan setelah menopause, gangguan berkemih yang menetap, nyeri panggul kronik, penyakit metabolik yang sukar dikendalikan, atau komorbid yang kompleks. Ahli gizi menyusun pola makan yang realistis sesuai budaya dan ekonomi keluarga, memastikan kecukupan protein untuk menjaga massa otot, dan menyesuaikan pembatasan bila ada penyakit seperti diabetes melitus, penyakit ginjal, atau hipertensi. Fisioterapis merancang program penguatan, peregangan, dan latihan keseimbangan yang aman, termasuk strategi berjalan dan teknik bangkit dari kursi yang menurunkan risiko jatuh. Psikolog membantu mengurai kecemasan, duka, atau penurunan minat yang sering tersembunyi di balik keluhan fisik, serta melatih keterampilan coping sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Pekerja sosial memetakan sumber bantuan, menilai potensi penelantaran atau kekerasan, memperkuat jejaring komunitas, dan membuka akses dukungan formal bila keluarga kewalahan.

Kunci kolaborasi adalah pertukaran informasi yang terarah dan hemat waktu. Saat merujuk, bidan menulis ringkasan klinis yang rapi, bukan sekadar tumpukan hasil. Ringkasan berisi alasan rujuk, keluhan utama, lamanya keluhan, temuan penting pemeriksaan, obat, suplemen, dan ramuan yang benar-benar digunakan, alergi yang diketahui, intervensi non-farmakologis yang sudah dicoba, serta pertanyaan rujukan yang spesifik. Jika fokus rujukan adalah kebocoran urin yang menurunkan partisipasi sosial, pertanyaan dapat dirumuskan seperti, "Apakah perlu evaluasi lebih lanjut terhadap penurunan organ panggul dan bagaimana penyesuaian obat agar tidak memperburuk berkemih malam." Ringkasan juga memuat preferensi budaya, misalnya kebutuhan pendamping perempuan saat pemeriksaan, tujuan personal seperti ingin kembali beribadah berjamaah dengan nyaman, serta siapa pendamping utama di rumah. Dokumen yang jelas seperti ini menghormati waktu klinisi rujukan dan meningkatkan peluang jawaban yang tepat sasaran.

Setelah rujukan berlangsung, kolaborasi kembali pada prinsip lingkaran tertutup. Dokter atau tenaga profesional lain mengirim umpan balik yang menjelaskan diagnosis kerja, perubahan terapi, saran latihan, dan rencana kontrol. Bidan membaca, menyaring, lalu menerjemahkan informasi tersebut menjadi langkah harian yang dipahami klien dan keluarga. Jika fisioterapis menambahkan latihan penguatan lutut dengan jumlah pengulangan tertentu, bidan membantu menyisipkannya ke rutinitas yang sudah ada. Jika ahli gizi menyarankan

peningkatan protein, bidan membumikan saran itu menjadi pilihan menu lokal yang terjangkau, misalnya tempe, telur, atau ikan kecil yang mudah didapat. Apabila psikolog menemukan gejala depresi sedang, bidan menyesuaikan tempo intervensi fisik agar tidak terasa memberatkan, sekaligus memastikan jadwal konseling berikutnya tercatat dan keluarga memahami cara memberi dukungan tanpa menggurui.

Dalam kerja tim, cara bicara sering menentukan hasil. Komunikasi yang terstruktur, misalnya dengan pola Situation, Background, Assessment, Recommendation, meminimalkan salah paham. Bidan menyebut inti masalah dalam satu kalimat, memberikan latar belakang yang paling relevan, menyampaikan penilaian klinis singkat, lalu mengajukan rekomendasi atau pertanyaan rujukan yang jelas. Nada komunikasi tetap saling menghormati, mengakui keahlian masing-masing profesi, dan mengembalikan pusat keputusan kepada klien. Di sisi lain, koordinasi tidak selalu mulus. Jadwal yang bentrok, sumber daya terbatas, atau perbedaan pandangan bisa muncul. Di sinilah peran bidan sebagai penenun jejaring diuji, yaitu menjaga fokus pada tujuan klien, memfasilitasi kompromi yang aman, dan mendokumentasikan keputusan agar semua pihak memiliki peta yang sama.

2. Navigasi pelayanan dan kontinuitas perawatan

Navigasi pelayanan adalah seni mengantarkan klien melalui sistem yang rumit sehingga perjalanan terasa singkat, jelas, dan manusiawi. Proses dimulai di titik paling dekat dengan rumah klien, misalnya praktik mandiri bidan, posyandu lansia, atau puskesmas. Begitu prioritas ditetapkan, bidan membantu memilih jalur layanan yang paling logis, memperhitungkan kedekatan fasilitas, kenyamanan transportasi, dan kemampuan biaya. Jadwal rujukan disepakati pada saat yang realistis bagi keluarga, bukan semata ketersediaan fasilitas. Bila klien memiliki keterbatasan mobilitas, bidan dan keluarga merencanakan pendampingan, memastikan kursi roda atau alat bantu tersedia, dan mengemas dokumen penting dalam satu map yang mudah dijangkau.

Sebelum hari rujukan, klien dan keluarga diberi informasi yang mencukupi. Mereka tahu siapa yang akan ditemui, pemeriksaan apa yang mungkin dilakukan, berapa lama perkiraan kunjungan, dan apa yang perlu dibawa, termasuk daftar obat dan suplemen. Bagi klien yang cemas, penjelasan kecil seperti “pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit” atau “Anda boleh meminta pendamping perempuan berada di ruangan” berpengaruh besar pada kenyamanan. Pada hari H, bila memungkinkan dilakukan penyerahan hangat, yaitu kontak singkat dari bidan ke petugas penerima rujukan agar konteks kasus dipahami sejak awal. Cara

ini sering memotong waktu tunggu dan mengurangi pengulangan pertanyaan yang melelahkan.

Kontinuitas perawatan bergantung pada dua hal, yaitu umpan balik yang kembali ke komunitas dan tindak lanjut yang konsisten. Setelah rujukan, bidan tidak menunggu pasif. Bidan menagih umpan balik melalui saluran yang disepakati, lalu menjadwalkan kunjungan atau panggilan tindak lanjut untuk menerjemahkan rekomendasi ke dalam kegiatan rumah. Kontrol berikutnya ke fasilitas yang sama atau berbeda dicantumkan dalam satu kalender keluarga. Indikator harian yang sederhana, misalnya jumlah kejadian kebocoran, jumlah langkah yang dicapai, jam tidur efektif, atau jumlah gelas air yang diminum, dipakai untuk memantau kemajuan. Jika data menunjukkan kemajuan seret, bidan menilai ulang hambatan: apakah teknik latihan kurang tepat, apakah obat baru menimbulkan kantuk, atau apakah ada stres keluarga yang belum terurai. Rencana disesuaikan tanpa menyalahkan, karena tujuan utama adalah menjaga langkah kecil tetap bergerak.

Navigasi juga berarti menyiapkan skenario cadangan. Bila cuaca ekstrem, banjir, atau gangguan transportasi menghalangi kunjungan, bidan dan keluarga memiliki rencana alternatif seperti konsultasi jarak jauh singkat untuk mengecek keselamatan, memperpanjang persediaan obat esensial, atau memindahkan jadwal dengan tertib. Daftar nomor penting disimpan di lokasi yang mudah terlihat, termasuk nomor bidan, kontak fasilitas rujukan, dan kontak darurat keluarga. Untuk klien yang hidup sendiri, tetangga tepercaya dapat ditunjuk sebagai pengingat harian yang ringan, misalnya mengetuk pintu di pagi hari atau mengirim pesan singkat sesuai kesepakatan. Semua langkah ini sederhana, tetapi justru di situlah kekuatan kontinuitas, yaitu menyatukan perhatian kecil yang berulang menjadi jaring pengaman yang kuat.

K. Keselamatan Pasien di Rumah dan Komunitas

1. Modifikasi rumah, pencegahan cedera dan jatuh

Keselamatan di rumah berawal dari cara menata ruang agar tubuh lansia “ditolong” oleh lingkungan, bukan sebaliknya. Prinsipnya sederhana: pencahayaan cukup, jalur berjalan lega, permukaan lantai bersahabat, dan pegangan tersedia di titik rawan. Di siang hari, sinar alami melalui jendela membantu penglihatan dan suasana hati, sementara pada malam hari lampu malam di kamar tidur, koridor, dan kamar mandi mengurangi risiko tersandung ketika bangun untuk berkemih. Jalur dari tempat tidur ke kamar mandi sebaiknya bebas dari kabel, karpet kecil yang mudah tergulung, dan tumpukan barang. Di kamar mandi, alas anti-selip ditempatkan di area basah, pegangan kokoh

dipasang di dekat kloset dan area mandi, serta kursi mandi dipertimbangkan bagi yang sulit berdiri lama. Ketinggian tempat duduk dan ranjang diatur agar lutut dan pinggul tidak harus menekuk berlebihan ketika berdiri. Alas kaki yang menutup tumit, pas di kaki, dan bertapak tidak licin menjadi “perangkat keselamatan” harian. Untuk rumah bertingkat, anak tangga diberi tanda kontras pada tepi dan, bila memungkinkan, rel pegangan dipasang di kedua sisi. Jika penglihatan menurun, label besar pada sakelar lampu, botol, dan laci membantu orientasi. Jika pendengaran berkurang, bel pintu dan alarm asap dengan indikator visual menambah lapisan keamanan. Di komunitas, jalur yang rata, bangku istirahat di titik tertentu, dan penerangan jalan yang memadai menjadikan perjalanan pendek ke warung atau tempat ibadah terasa aman kembali. Pencegahan jatuh juga menyangkut cara bergerak: bangun dari posisi berbaring dilakukan bertahap menjadi duduk lalu berdiri. Sebelum melangkah, gerakkan pergelangan kaki beberapa kali untuk membantu aliran darah agar tidak pusing mendadak. Ketika kekuatan otot menurun, latihan penguatan sederhana dan latihan keseimbangan yang diajarkan bidan atau fisioterapis dipadukan dengan modifikasi rumah akan menurunkan risiko jatuh secara bermakna.

2. Manajemen obat dan pencegahan interaksi

Obat dapat menjadi penopang kesehatan, tetapi pada lansia dengan beberapa penyakit kronis, obat juga bisa menjadi sumber masalah bila tidak dikelola hati-hati. Langkah pertama adalah menyusun daftar obat yang benar-benar digunakan, mencakup resep, obat bebas, suplemen, dan ramuan tradisional, beserta dosis, frekuensi, dan alasan pemakaian. Daftar ini sebaiknya selalu dibawa saat kontrol dan diperbarui setiap ada perubahan. Kotak obat mingguan memudahkan keteraturan, sementara label besar dan jelas mencegah kekeliruan. Jadwal minum obat diselaraskan dengan rutinitas harian agar mudah diingat, misalnya setelah sarapan, setelah makan siang, dan sebelum tidur, sambil meninjau ulang waktu yang dapat memperburuk keluhan tertentu. Contohnya, obat atau minuman yang meningkatkan produksi urin sebaiknya dihindari pada malam hari untuk mengurangi terbangun berulang. Edukasi keluarga atau pengasuh penting agar pengingat terasa sebagai dukungan, bukan perintah.

Pencegahan interaksi berangkat dari kewaspadaan terhadap obat berisiko tinggi pada lansia. Obat penenang dan obat tidur dapat menyebabkan mengantuk, kebingungan, dan meningkatkan risiko jatuh. Obat nyeri tertentu dapat mengiritasi lambung atau membebani ginjal jika digunakan lama. Obat antikolinergik yang sering ada pada obat alergi atau sebagian obat saluran kemih dapat memicu mulut kering, konstipasi, dan kebingungan. Obat penurun gula darah berisiko menyebabkan gula darah turun tiba-tiba bila pola makan tidak

teratur. Ramuan dan suplemen yang tampak “alami” juga tidak bebas risiko. Ginkgo dan bawang putih dosis tinggi dapat meningkatkan risiko perdarahan jika dipadukan dengan obat pengencer darah. Ginseng dapat memengaruhi gula darah. Minuman tinggi kafein memperberat keluhan berkemih. Karena itu, rekonsiliasi obat secara berkala menjadi kebiasaan penting. Bidan atau tenaga kesehatan lain meninjau ulang satu per satu, menilai masih perlu atau tidak, memeriksa duplikasi, dan berkoordinasi dengan dokter untuk menyederhanakan rejimen bila memungkinkan. Tanda peringatan interaksi seperti pusing baru, kebingungan, kantuk berlebihan, bengkak tungkai, gangguan pencernaan berat, atau perdarahan yang tidak biasa harus dikenali dan segera dikomunikasikan. Dengan pengelolaan yang cermat, obat kembali menjadi alat, bukan beban.

3. Kesiapsiagaan darurat untuk lansia

Kedaruratan bisa bersifat medis, seperti jatuh, sesak napas, atau kebingungan mendadak. Bisa juga berasal dari lingkungan, seperti kebakaran, banjir, gelombang panas, atau pemadaman listrik. Kesiapsiagaan yang baik memadukan rencana yang sederhana, latihan kecil yang berulang, dan jejaring dukungan. Di rumah, nomor penting ditempel di tempat yang mudah terlihat, mencakup kontak bidan, fasilitas kesehatan terdekat, keluarga inti, tetangga terpercaya, dan layanan darurat. Ponsel atau telepon nirkabel diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau dari tempat tidur dan area duduk utama. Bagi yang berisiko tinggi jatuh atau hidup sendiri, perangkat tombol darurat atau jam tangan panggil dapat dipertimbangkan. Tas siaga kecil disiapkan berisi salinan daftar obat dan alergi, resep terbaru, fotokopi identitas, alat bantu sederhana seperti kacamata cadangan dan baterai alat bantu dengar, makanan ringan, air minum, serta uang tunai secukupnya. Persediaan obat esensial untuk beberapa hari ke depan disimpan terpisah agar mudah dibawa saat evakuasi mendadak. Jika ada alat medis yang membutuhkan listrik, seperti alat bantu pernapasan atau penghangat tertentu, rencana cadangan dibuat untuk menghadapi pemadaman listrik, misalnya baterai tambahan, power bank berkapasitas besar, atau koordinasi dengan tetangga yang memiliki genset.

Latihan kecil membuat rencana menjadi refleks. Keluarga dan lansia berlatih cara menghubungi bantuan, membuka kunci pintu dengan cepat, dan rute aman menuju titik kumpul bila harus keluar rumah. Di wilayah yang rawan banjir atau gempa, rak barang berat dipasang dengan pengikat, barang berharga dan dokumen penting ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, dan jalur evakuasi ditandai. Pada hari-hari panas, pengingat minum air dipertegas, tirai ditutup pada siang bolong, sirkulasi udara dijaga, dan aktivitas berat dipindah ke pagi atau sore. Bila kualitas udara buruk, jendela ditutup dan masker yang sesuai disiapkan

untuk keperluan keluar rumah. Di tingkat komunitas, posyandu lansia dan pengurus lingkungan menyusun daftar lansia yang tinggal sendiri untuk pengecekan berkala saat bencana, serta menyepakati sistem “ketuk pintu” harian yang ringan agar tidak ada yang luput dari pantauan.

Kesiapsiagaan bukan menakut-nakuti, melainkan cara mengembalikan rasa kendali. Ketika rumah ditata aman, obat dikelola rapi, dan rencana darurat dipahami oleh semua orang, lansia perempuan dapat bergerak lebih bebas tanpa rasa waswas yang berlebihan. Bidan berperan menjaga irama, memeriksa ulang titik rawan saat kunjungan, menyegarkan edukasi obat, dan melatih ulang langkah-langkah kecil kesiapsiagaan di momen yang tepat. Hasil akhirnya bukan sekadar berkurangnya kejadian jatuh atau kunjungan darurat, melainkan kembalinya rasa aman untuk hidup sehari-hari di rumah dan komunitas, rasa aman yang menjadi fondasi bagi kesehatan, kemandirian, dan martabat.

L. Etika, Hukum, dan Perlindungan Hak Lansia

Perspektif etik dan hukum bukan pelengkap administratif, melainkan fondasi cara kita mendampingi lansia perempuan dari rumah hingga fasilitas kesehatan. Ia memandu bagaimana kita menjelaskan pilihan perawatan, menilai kemampuan mengambil keputusan, menjaga kerahasiaan informasi, merespons kekerasan, serta memastikan akses layanan tetap adil tanpa prasangka berbasis usia. Tiga bidang kunci saling terkait: persetujuan tindakan yang benar-benar dipahami, perlindungan privasi dan keselamatan dari kekerasan, serta keadilan akses yang bebas stigma.

1. Persetujuan tindakan yang bermakna dan kapasitas pengambilan keputusan

Persetujuan tindakan yang bermakna terjadi ketika klien memahami informasi relevan, menimbanginya sesuai nilai pribadi, mampu mempertimbangkan pilihan, dan menyampaikan keputusan dengan bebas. Dalam konteks Indonesia, praktik ini selaras dengan kaidah etika dan kerangka hukum yang menekankan hak pasien atas informasi, penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif, serta konsekuensi bila tindakan tidak dilakukan. Pada keadaan gawat darurat, tenaga kesehatan boleh memulai tindakan penyelamatan jiwa dengan kewajiban pencatatan yang memadai pada rekam medis, kemudian melengkapi proses persetujuan ketika kondisi sudah memungkinkan.

Penilaian kapasitas pengambilan keputusan bersifat spesifik terhadap satu keputusan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Seorang lansia mungkin cukup mampu memutuskan latihan dasar panggul dan penataan pola minum, tetapi memerlukan dukungan keluarga ketika mempertimbangkan tindakan yang lebih kompleks. Agar persetujuan betul-betul bermakna, penjelasan diberikan

dengan bahasa sederhana, contoh konkret, materi tertulis singkat berhuruf jelas, dan teknik ajak-ulang (teach-back) untuk memastikan pemahaman. Waktu diskusi dipilih saat klien paling bugar, dengan suasana privat dan tenang. Jika kapasitas sebagian menurun, keputusan melibatkan pendamping sah atau keluarga terdekat sesuai ketentuan setempat, sembari tetap memprioritaskan preferensi dan nilai klien sejauh dapat dikenali.

2. Privasi, kerahasiaan, dan perlindungan dari kekerasan

Privasi adalah hak dasar. Segala informasi kesehatan, termasuk catatan klinis, hasil pemeriksaan, foto, video, dan isi konseling, harus disimpan aman, diakses hanya oleh pihak yang berwenang, dan dibagikan kepada pihak lain atas persetujuan sah dari klien kecuali pada kondisi yang jelas diatur oleh hukum. Dalam praktik komunitas, penerjemahannya konkret: berkas fisik disimpan terkunci, perangkat digital dilindungi sandi, percakapan sensitif tidak dilakukan di ruang terbuka, dan informasi kesehatan tidak dibagikan ke grup pesan umum tanpa izin tertulis. Saat rujukan diperlukan, ringkasan klinis dikirimkan kepada tenaga kesehatan yang relevan saja, berisi data secukupnya untuk membantu pelayanan tanpa mengumbar hal yang tidak perlu.

Di saat yang sama, pendampingan lansia harus peka terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, finansial, maupun penelantaran. Lansia perempuan sering menanggungnya dalam diam karena sungkan atau takut mengganggu harmoni keluarga. Karena itu, skrining dilakukan secara privat dan tidak menghakimi. Pertanyaan sederhana, apakah ada orang di rumah yang membuat Ibu takut, mengambil uang tanpa izin, membatasi Ibu bertemu orang lain, atau menolak membantu kebutuhan dasar, membuka ruang pengungkapan. Tanda fisik seperti memar di lokasi tidak lazim, penurunan kebersihan diri, dehidrasi, atau ketidakselarasan antara keluhan dan penjelasan patut diwaspadai. Bila kecurigaan muncul, keselamatan klien menjadi prioritas. Jelaskan pilihan yang tersedia, dokumentasikan secara faktual, rujuk ke layanan medis atau sosial yang relevan, dan libatkan aparat berwenang bila ada ancaman langsung. Kerahasiaan tetap dijaga, namun tidak menghalangi tindakan yang diperlukan untuk melindungi korban.

3. Isu keadilan akses dan stigma usia

Keadilan akses berarti layanan tersedia dan terjangkau tanpa terhambat lokasi, biaya, literasi kesehatan, atau hambatan fisik dan digital. Pada tingkat operasional, hal ini berarti jam layanan yang ramah mobilitas, ruang tunggu dan toilet yang mudah diakses, materi edukasi berhuruf besar dengan bahasa jelas, serta opsi komunikasi non digital untuk mereka yang tidak nyaman menggunakan gawai. Kader dan jejaring komunitas menjadi jembatan bagi yang

kesulitan transportasi atau membaca label obat, sementara penjadwalan rujukan memperhitungkan ritme keluarga dan kemampuan biaya.

Hambatan struktural sering diperberat oleh stigma usia atau ageisme, yaitu prasangka dan diskriminasi karena usia, yang dapat membuat keluhan perempuan lansia diremehkan sebagai “wajar karena tua.” Mengatasi ageisme dimulai dari cara kita bertanya dan mencatat. Pertanyaan berfokus pada tujuan hidup klien, bukan usia kronologis semata. Nyeri yang “biasa” tetap ditangani, keluhan kebocoran tidak ditertawakan, kebutuhan kesehatan seksual dibahas dengan hormat. Pelatihan untuk kader dan tenaga kesehatan memasukkan komponen anti bias dan komunikasi lintas generasi. Di fasilitas, kebijakan kecil seperti prioritas antrian bagi lansia dengan keterbatasan gerak, kursi berpenopang lengan untuk memudahkan berdiri, serta penandaan jalur yang kontras adalah contoh keadilan akses yang nyata dan terasa.

Ketiga pilar ini, yaitu persetujuan bermakna, kerahasiaan yang kokoh beserta respons anti kekerasan, dan keadilan akses bebas stigma, bersatu dalam praktik harian. Hasil akhirnya tampak bukan hanya pada indikator klinis, tetapi juga pada hal-hal yang dinilai penting oleh klien, seperti merasa didengar, aman, dan berdaya mengambil keputusan. Ketika etika, hukum, dan hak asasi dijalankan setia seperti ini, pendampingan lansia perempuan tidak sekadar mematuhi aturan, melainkan memulihkan martabat dan rasa kendali dalam kehidupan sehari-hari.

M. Teknologi dan Transformasi Digital

1. Telekesehatan dan pemantauan jarak jauh

Telekesehatan menjadi perpanjangan tangan layanan yang sudah ada, bukan pengganti pertemuan tatap muka. Nilai utamanya adalah menjaga kesinambungan asuhan ketika jarak, mobilitas, biaya, atau cuaca menjadi hambatan, sekaligus memberi ruang bagi keluarga untuk terlibat tanpa harus selalu datang ke fasilitas. Sesi telekesehatan yang baik dimulai dari persiapan yang sederhana. Identitas klien diverifikasi, persetujuan untuk konsultasi jarak jauh diminta secara jelas, dan batasan layanan dijelaskan agar ekspektasi realistis. Lingkungan dibuat tenang, privat, dan cukup terang. Bagi lansia yang kurang akrab dengan gawai, keluarga atau kader dapat membantu menyalakan aplikasi, mengatur sudut kamera, dan memastikan suara terdengar. Bidan memulai percakapan seperti di ruang praktik: menyapa, menjelaskan tujuan pertemuan, merangkum keluhan utama, lalu menelusuri pengkajian dengan bahasa yang mudah. Ada beberapa teknik yang efektif melalui layar, misalnya meminta klien menunjukkan cara bangkit dari kursi untuk menilai stabilitas, memperagakan latihan dasar panggul menggunakan model anatomi

sederhana, atau memperlihatkan tata letak kamar mandi agar titik bahaya dapat diidentifikasi bersama. Di akhir sesi, rencana disepakati, tanda bahaya diingatkan, resep non obat seperti latihan dan modifikasi rumah dituliskan dalam bentuk ringkasan yang dikirim ke keluarga, dan jadwal tindak lanjut ditetapkan.

Pemantauan jarak jauh melengkapi konsultasi. Perangkat yang umum digunakan meliputi alat ukur tekanan darah digital, timbangan, alat ukur gula darah bagi yang memerlukannya, dan buku kecil atau aplikasi catatan gejala. Prinsip pemilihan perangkat adalah kesederhanaan, daya tahan, dan kemudahan dibaca. Alat dengan layar besar, tombol yang tidak licin, dan indikator yang jelas biasanya lebih disukai lansia. Pemantauan tidak perlu rumit. Untuk pencegahan jatuh, misalnya, indikator sederhana seperti jumlah kejadian pusing saat berdiri, jumlah langkah harian, atau keberhasilan berdiri dari kursi sebanyak beberapa kali berturut-turut sudah sangat informatif. Data tidak dikumpulkan tanpa tujuan. Sejak awal disepakati ambang yang memicu tindakan, contohnya bila tekanan darah atau gula darah berada pada rentang tertentu, bila kebingungan muncul, atau bila kejadian jatuh nyaris terjadi berulang. Keluarga diajarkan cara mencatat dan mengirimkan data pada waktu yang disepakati agar bidan dapat menilai tren, bukan hanya angka harian yang fluktuatif. Di wilayah dengan internet terbatas, pelaporan dapat dilakukan melalui pesan teks singkat atau panggilan telepon berkala. Yang paling penting, setiap data yang diminta sanggup ditindaklanjuti, sehingga pemantauan terasa bermakna dan tidak menjadi beban administratif.

Telekesehatan juga memiliki batas. Ada situasi yang harus beralih ke pemeriksaan langsung atau rujukan, seperti perdarahan setelah menopause, kecurigaan fraktur, demam tinggi dengan nyeri pinggang, kebingungan mendadak, atau nyeri panggul yang menetap. Penjelasan mengenai tanda bahaya dan jalur rujukan diberikan di awal agar keluarga tahu kapan harus bergerak cepat. Aspek kerahasiaan dijaga dengan memilih ruang konsultasi yang privat, menggunakan perangkat yang terlindungi sandi, dan mengingatkan keluarga agar tidak merekam percakapan tanpa persetujuan. Pendekatan ini membuat telekesehatan aman, berdaya guna, dan dirasakan manusiawi.

2. Aplikasi edukasi dan pengingat kepatuhan

Aplikasi edukasi dan pengingat kepatuhan berfungsi sebagai teman perjalanan di luar jam kunjungan. Konten yang efektif bersandar pada tiga hal: bahasa yang akrab, tampilan yang ramah lansia, dan tugas-tugas kecil yang terasa mungkin. Materi edukasi dibuat singkat, menggunakan huruf besar dan

kontras warna yang baik, dilengkapi gambar sederhana yang menunjukkan langkah demi langkah, misalnya urutan latihan dasar panggul atau contoh modifikasi kamar mandi. Bila memungkinkan, audio narasi ditambahkan agar lansia yang penglihatannya menurun tetap dapat mengikuti. Pengingat kepatuhan disusun mengikuti ritme hidup, bukan memaksa ritme baru. Jadwal minum obat, latihan, dan minum air dapat dipasangkan dengan momen yang sudah ada, misalnya setelah ibadah, setelah sarapan, atau sebelum tidur. Fitur catatan harian gejala dibuat sesederhana mungkin, contohnya pilihan jawaban ya atau tidak untuk kebocoran urin, jumlah terbangun malam, atau rasa nyeri lutut saat menaiki tangga. Data yang direkam akan menjadi bahan evaluasi pada kunjungan berikutnya, sehingga klien melihat hubungan nyata antara catatan dan keputusan klinis.

Pendekatan teknologi selalu mempertimbangkan kesenjangan literasi digital. Tidak semua lansia nyaman mengunduh aplikasi atau mengingat banyak kata sandi. Karena itu, opsi tanpa aplikasi tetap disiapkan. Kartu kertas berisi jadwal obat, latihan, dan target mingguan dapat ditempel di lemari es; stiker warna ditempel pada botol obat sesuai waktu minum; panggilan telepon singkat mingguan dari kader menggantikan notifikasi digital. Bila keluarga memiliki gawai, aplikasi dapat dipasang pada ponsel pendamping sehingga tugas mengingat dibagi secara adil. Pencegahan kelelahan notifikasi juga penting. Terlalu banyak pengingat membuat pengguna menonaktifkan semuanya. Lebih baik sedikit tetapi konsisten, lalu dievaluasi apakah frekuensinya perlu dinaikkan atau diturunkan. Keamanan informasi dijelaskan sejak awal. Data yang dicatat adalah milik klien, hanya dibagikan kepada tenaga kesehatan terkait dengan persetujuan, dan tidak digunakan di luar tujuan perawatan. Penjelasan yang transparan menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran tentang penyalahgunaan data.

Aplikasi yang baik mendorong motivasi intrinsik. Alih-alih sekadar memberi perintah, ia merayakan kemajuan kecil. Ketika jumlah latihan tercapai selama beberapa hari berturut-turut, layar menampilkan ucapan selamat. Ketika kebocoran berkurang, grafik sederhana menunjukkan penurunan tren. Hal-hal kecil seperti ini menumbuhkan rasa mampu, yang pada lansia sering lebih menentukan keberlanjutan perubahan dibandingkan nasihat panjang. Bila muncul kendala, misalnya kebingungan menavigasi menu, bidan mengecek langsung saat kunjungan dan menyederhanakan pengaturan. Dengan cara ini, aplikasi benar-benar menjadi alat bantu, bukan sumber stres baru.

3. Catatan medis elektronik dan keamanan data

Catatan medis elektronik menjadi tulang punggung koordinasi layanan. Kualitasnya ditentukan oleh isi yang ringkas tetapi bermakna, kemudahan dibaca oleh tim interprofesional, serta keamanan data yang dapat dipercaya. Untuk pendampingan lansia perempuan, struktur catatan yang paling membantu adalah yang menonjolkan tujuan klien, daftar masalah aktif, rencana intervensi yang disepakati, dan indikator sederhana untuk evaluasi. Alih-alih narasi panjang yang sulit ditelusuri, ringkasan di bagian atas memuat kalimat singkat, misalnya “tujuan utama kembali ibadah berjamaah tanpa takut bocor,” disusul masalah aktif seperti kebocoran urin siang hari, nyeri lutut saat naik tangga, dan tidur terputus. Rencana konkret dicantumkan beserta penanggung jawab di rumah, misalnya keluarga menata ulang kamar mandi, kader memantau teknik latihan, dan bidan menilai ulang dalam dua minggu. Ketika rujukan terjadi, catatan ini menjadi paket informasi yang memudahkan dokter, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, atau pekerja sosial memahami konteks dalam hitungan menit.

Keamanan data bukan pilihan, melainkan syarat kepercayaan. Prinsip dasarnya adalah akses dibatasi sesuai peran, data dienkripsi saat disimpan dan saat dikirim, dan setiap akses tercatat untuk audit. Kata sandi kuat, otentikasi ganda bila tersedia, dan kebiasaan mengunci layar bila meninggalkan perangkat adalah langkah kecil yang mencegah insiden besar. Berkas fisik masih mungkin digunakan pada praktik komunitas; maka laci atau lemari arsip harus terkunci, dan dokumen yang tidak lagi diperlukan dimusnahkan dengan cara yang aman. Pembagian data mengikuti persetujuan klien. Ketika ringkasan klinis dikirim untuk rujukan, hanya informasi yang relevan yang disertakan. Identitas sensitif tidak dicantumkan di saluran komunikasi umum, dan percakapan klinis tidak dilakukan di grup media sosial keluarga yang luas. Kebijakan cadangan data disiapkan agar catatan tidak hilang saat terjadi gangguan listrik atau kerusakan perangkat. Salinan cadangan yang terenkripsi disimpan terpisah, dengan prosedur pemulihan yang telah diuji agar layanan tidak lumpuh bila terjadi bencana.

Interoperabilitas atau kemampuan sistem berbeda untuk bertukar data secara aman ikut menentukan kelancaran layanan. Ketika catatan medis elektronik di puskesmas dapat membaca ringkasan dari praktik mandiri bidan, dan sebaliknya, rangkaian perawatan menjadi mulus. Bila sistem belum saling terhubung, standar kerja sementara disepakati, misalnya format ringkasan rujukan yang konsisten dan mudah dibaca di berbagai perangkat. Semua ini dilengkapi dengan pelatihan singkat bagi tenaga kesehatan dan kader mengenai prinsip perlindungan data pribadi, cara menggunakan perangkat

lunak secara aman, serta cara merespons jika terjadi dugaan kebocoran. Tindakan respons cepat meliputi menghentikan akses, memberi tahu pihak terkait, dan mendokumentasikan kejadian secara transparan agar perbaikan sistem dapat segera dilakukan.

N. Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi Mutu

Dokumentasi dan mutu layanan adalah dua sisi dari satu mata uang. Tanpa catatan yang rapi, keputusan klinis mudah bergantung pada ingatan, koordinasi menjadi lemah, dan pembelajaran kolektif tidak pernah terkumpul. Sebaliknya, ketika setiap pertemuan tercatat jelas dan data kecil sehari-hari dikumpulkan secara konsisten, tim memiliki cermin yang jujur untuk melihat apa yang sudah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Pada pendampingan lansia perempuan di komunitas, tiga pilar saling mengikat. Pertama, standar prosedur operasional beserta format catatan asuhan yang sederhana namun bermakna. Kedua, indikator proses dan hasil yang tidak hanya klinis, tetapi juga fungsional dan berangkat dari pengalaman klien. Ketiga, audit sederhana yang menyalakan budaya perbaikan berkelanjutan sehingga layanan makin aman, efektif, dan manusiawi.

1. Standar Prosedur Operasional dan format catatan asuhan

Standar prosedur operasional berfungsi sebagai rel yang menjaga layanan konsisten, meskipun orang dan situasi berubah. Penyusunannya dimulai dari pemetaan jalur kerja yang paling sering ditemui di lapangan, misalnya alur kunjungan rumah, alur hari layanan posyandu lansia, alur rujukan klinis, hingga alur respons jika ditemukan tanda kekerasan atau penelantaran. Setiap alur dirinci secukupnya, bukan untuk membebani tenaga kesehatan, melainkan untuk menghapus ambiguitas di titik kritis. Di dalamnya selalu ada penjelasan tujuan, siapa melakukan apa, alat atau formulir yang dipakai, cara mendokumentasikan, dan tanda bahaya yang memicu rujukan. SOP yang hidup selalu disertai lembar ringkas satu halaman yang mudah dibawa, sementara dokumen lengkap tersimpan rapi untuk pelatihan dan audit.

Format catatan asuhan sebaiknya seragam lintas tempat agar informasi mudah dibaca siapa pun yang terlibat. Struktur yang efektif diawali ringkasan singkat di bagian paling atas sehingga siapa pun yang membuka berkas langsung memahami konteks. Ringkasan itu menyebut tujuan klien dengan kalimat sederhana, misalnya ingin kembali menghadiri ibadah berjamaah tanpa cemas kebocoran. Setelah itu dituliskan masalah aktif yang relevan, rencana yang disepakati bersama, dan tanggal tindak lanjut berikutnya. Bagian inti catatan mengikuti logika klinis. Keluhan dan cerita klien dituangkan dengan kata-kata klien sendiri agar makna personal tidak hilang. Temuan pemeriksaan penting

disajikan ringkas. Penilaian klinis menyatukan data ke dalam kesimpulan yang wajar. Rencana menuliskan intervensi non farmakologis yang konkret, siapa yang bertanggung jawab di rumah, apa yang akan dipantau, serta tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. Untuk kunjungan rumah, ada kolom kecil yang menandai kondisi lingkungan seperti pencahayaan lorong, alas anti selip di kamar mandi, atau pegangan dekat kloset. Untuk pengelolaan obat, ada tabel sederhana yang mencatat nama, dosis, jam minum, dan tujuan obat, berikut kotak cek kecil agar keluarga dapat menandai bila ada perubahan dari dokter. Catatan dibuat sejelas mungkin tanpa jargon yang tidak perlu, menjaga kerahasiaan, dan hanya memuat informasi yang relevan. Dengan format seperti ini, setiap pertemuan menjadi satu keping yang menyatu dengan pertemuan sebelumnya dan berikutnya.

2. Indikator proses dan hasil yang mencakup klinis, fungsional, dan pengalaman klien

Monitoring yang berguna selalu dimulai dari pertanyaan yang ingin dijawab. Bila tujuan pendampingan adalah membuat lansia lebih aman, lebih mandiri, dan lebih tenang menjalani hari, maka indikator harus mampu menangkap ketiganya. Indikator proses membantu melihat apakah cara kerja yang disepakati benar benar dijalankan. Contohnya seberapa sering skrining risiko jatuh dilakukan pada kunjungan pertama, seberapa banyak rekonsiliasi obat dirampungkan lengkap, seberapa konsisten edukasi latihan dasar panggul diajarkan dengan demonstrasi, atau seberapa rutin tindak lanjut dilakukan sesuai jadwal. Angka angka proses bukan sekadar kewajiban administratif. Ketika trennya menurun, tim tahu ada hambatan di hulu, entah karena beban kerja naik atau formulir terlalu rumit.

Indikator hasil klinis menangkap perubahan gejala dan kejadian yang bermakna. Untuk keluhan berkemih, misalnya, jumlah kebocoran siang hari, jumlah terbangun malam, dan kejadian infeksi saluran kemih yang membutuhkan terapi adalah ukuran yang mudah dipahami oleh klien dan tenaga kesehatan. Untuk pencegahan jatuh, jumlah jatuh dan jumlah nyaris jatuh menjadi peringatan dini yang sangat berguna. Indikator fungsional berfokus pada kemampuan melakukan aktivitas harian. Kemampuan bangkit dari kursi tanpa bantuan, kecepatan berjalan aman di rumah, atau keberanian menaiki dua anak tangga dengan pegangan memberi gambaran langsung tentang kemandirian. Indikator pengalaman klien menempatkan suara klien sebagai pusat evaluasi. Dua atau tiga pertanyaan pendek yang ditanyakan secara konsisten sudah cukup kuat, misalnya apakah klien merasa didengar, apakah rencana yang diberikan mudah dijalankan di rumahnya sendiri, dan apakah perasaannya tentang keselamatan di

rumah membaik. Pertanyaan sederhana ini mengubah monitoring dari sekadar angka menjadi cermin kemanusiaan.

Data yang dikumpulkan tidak perlu banyak tetapi harus rapi dan dapat ditindaklanjuti. Tim menyepakati frekuensi pengumpulan, misalnya rekap mingguan di posyandu dan rekap bulanan untuk wilayah kerja. Data dibedakan menurut kelompok yang relevan, seperti lansia yang tinggal sendiri dibanding yang tinggal dengan keluarga, atau menurut hambatan mobilitas, sehingga ketidakadilan akses dapat terlihat. Setiap angka selalu dipasangkan dengan ambang tindakan. Bila jumlah jatuh meningkat pada satu lingkungan, segera dilakukan peninjauan rumah bersama kader untuk mencari titik licin atau penerangan yang buruk. Bila pengalaman klien tentang rasa didengar menurun, tim meninjau ulang cara bertanya dan memberi penjelasan. Dengan pendekatan ini, indikator menjadi kompas yang memandu perbaikan, bukan papan skor yang menegangkan.

3. Audit sederhana dan perbaikan berkelanjutan

Audit yang efektif tidak harus rumit. Prinsipnya memeriksa kesenjangan antara yang direncanakan dan yang dilakukan, lalu menutup kesenjangan itu dengan langkah kecil yang realistis. Tim memilih satu topik yang penting dan dapat diubah, misalnya kepatuhan rekonsiliasi obat pada kunjungan pertama, ketepatan dokumentasi tanda bahaya, atau pemasangan pegangan di kamar mandi pada klien berisiko jatuh. Dari setiap topik, diambil sampel catatan secara acak dalam jumlah kecil yang mudah dikelola. Pemeriksaan dilakukan dengan lembar audit satu halaman yang menandai ada atau tidaknya unsur kunci. Hasilnya dibahas dalam pertemuan singkat yang teratur waktunya, bukan rapat panjang yang melelahkan.

Kunci audit adalah menautkannya dengan siklus perbaikan yang terus berulang. Setelah masalah prioritas dipilih, tim menyusun rencana perbaikan yang sangat spesifik, melaksanakan dalam skala kecil, lalu mempelajari hasilnya sebelum memperluas ke seluruh layanan. Bila rekonsiliasi obat sering terlewat karena formulir terlalu panjang, solusinya bisa sesederhana membuat kartu obat saku yang hanya berisi nama, dosis, jam minum, dan tujuan, lalu menempelkan kartu itu di lemari es rumah klien. Bila pemasangan pegangan di kamar mandi rendah, tim bekerja sama dengan pengurus lingkungan untuk menyediakan bahan pegangan berbiaya murah dan menetapkan hari kerja bakti khusus keselamatan kamar mandi. Bila pertanyaan pengalaman klien menunjukkan mereka tidak merasa cukup didengar, tim berlatih kembali teknik mendengar aktif dan penggunaan kalimat ajak ulang. Setiap intervensi diuji singkat, dievaluasi, lalu distandarkan jika terbukti membantu. Hasil perbaikan tidak hanya dicatat dalam

laporan, tetapi dibagikan dalam bentuk cerita singkat yang mengakui kerja kader, keluarga, dan klien. Cerita keberhasilan nyata, misalnya seorang nenek yang kembali berani berjalan ke warung setelah pegangan dipasang dan latihan dilanjutkan rutin, sering menjadi pemantik motivasi yang lebih kuat daripada angka semata.

Perbaikan berkelanjutan juga mensyaratkan tata kelola data yang bertanggung jawab. Data disimpan aman, akses dibatasi sesuai peran, dan setiap pembagian informasi mendapatkan persetujuan klien. Ketika terjadi kesalahan, misalnya kolom tanda bahaya terlewat di beberapa catatan, tim menanganinya sebagai kesempatan belajar. Penyebabnya ditelusuri tanpa menyalahkan orang, melainkan memperbaiki proses, apakah kolom tersebut tersembunyi di halaman belakang, apakah pelatihan belum merata, atau apakah beban kerja pada hari itu tidak realistis. Sikap ini menumbuhkan budaya saling percaya yang menjadi syarat mutlak untuk mutu layanan yang terus membaik.

O. Kearifan Lokal dan Sensitivitas Budaya

Pendampingan kebidanan yang benar-benar holistik hanya mungkin terjadi bila pengetahuan ilmiah berjalan beriringan dengan kebijaksanaan setempat. Pada lansia perempuan, kearifan lokal bukan sekadar ornamen budaya, melainkan bagian dari cara mereka memaknai sehat, menata hari, dan menjaga martabat. Tugas bidan adalah mengidentifikasi praktik yang memberi manfaat, menapis yang berisiko, lalu meracik keduanya menjadi rencana asuhan yang aman, efektif, dan tetap terasa akrab bagi klien serta keluarganya.

1. Praktik tradisional yang aman dan berbasis bukti

Banyak keluarga memelihara kebiasaan turun-temurun untuk mengatasi pegal, masuk angin, sulit tidur, atau keluhan urogenital ringan. Sebagian memiliki manfaat yang selaras dengan ilmu pengetahuan modern, misalnya kompres hangat untuk kaku sendi, pijat ringan untuk relaksasi, minuman jahe hangat untuk kenyamanan tenggorokan dan rasa dingin, atau mandi air hangat menjelang tidur untuk membantu tubuh lebih rileks. Pada lansia, bidan memastikan cara dan intensitasnya aman. Pijat yang berlebihan, penekanan kuat di punggung atau leher, atau manipulasi sendi yang ekstrem berisiko pada tulang yang rapuh dan sendi yang sensitif; maka pijat dipandu agar lembut, durasi singkat, dan dihindarkan pada area yang nyeri tekan atau pernah mengalami patah. Kebiasaan kerokan kerap memberi sensasi lega, tetapi pada kulit lansia yang tipis mudah menimbulkan lecet dan memicu infeksi; bidan mengalihkan ke alternatif yang lebih aman seperti kompres hangat, peregangan perlahan, atau minuman hangat.

Herbal dan jamu memegang tempat istimewa di banyak rumah. Pendekatan yang bijak bukan menolak mentah-mentah, melainkan menilai keamanan dan kecocokan dengan obat medis yang sedang diminum. Beberapa bahan dapat memengaruhi pembekuan darah, gula darah, atau tekanan darah. Karena itu, daftar lengkap ramuan, suplemen, dan obat resep perlu dikaji bersama agar tidak terjadi tumpang tindih atau interaksi yang tidak diinginkan. Dosis yang wajar, sumber bahan yang bersih, dan cara penyajian yang higienis selalu ditekankan. Bidan juga mengingatkan bahwa minuman atau ramuan tertentu pada sore dan malam hari dapat merangsang berkemih sehingga tidur terganggu. Prinsipnya sederhana tetapi tegas. Jika aman, bermanfaat, tidak menghalangi terapi utama, dan memberi rasa tenang, praktik tradisional dapat dipertahankan sambil dipadukan dengan intervensi non-farmakologis seperti latihan dasar panggul, penguatan otot, dan modifikasi lingkungan rumah. Jika praktik menimbulkan risiko, menggantinya dengan alternatif yang serupa maknanya tetapi lebih aman adalah bentuk penghormatan pada budaya sekaligus menjaga keselamatan.

Dalam dimensi uroginekologi, sebagian keluarga masih mempraktikkan pembersihan internal dengan cairan tradisional untuk mengatasi rasa tidak nyaman. Pada lansia, tindakan ini berisiko mengiritasi mukosa dan mengganggu flora alami. Edukasi diberikan dengan empati, menekankan perawatan area genital yang lembut, penggunaan pelembap vagina yang aman bila diperlukan, pakaian dalam yang menyerap keringat, dan kebiasaan harian yang sederhana seperti mengganti kain atau pembalut khusus inkontinensia secara teratur. Bila muncul perdarahan setelah menopause, nyeri panggul menetap, atau keluhan tidak membaik, rujukan dijelaskan sebagai bentuk kehati-hatian, bukan meniadakan tradisi.

2. Peran tokoh keluarga dan komunitas dalam pendampingan

Di banyak wilayah, keputusan sehari-hari tentang kesehatan lansia perempuan lahir dari percakapan keluarga yang dipengaruhi tokoh kunci. Ada anak yang menjadi pengingat obat, menantu yang mengatur belanja dan memasak, cucu yang membantu gawai untuk konsultasi jarak jauh, hingga tetangga yang mendampingi berjalan ke posyandu lansia. Di luar lingkaran rumah, tokoh agama, ketua lingkungan, dan kader menjadi penentu suasana. Persetujuan dan teladan mereka sering lebih meyakinkan daripada selebaran berisi anjuran. Karena itu, bidan memulai dari pemetaan peran. Siapa yang berpengaruh di rumah ini, siapa yang didengar di kampung ini, kegiatan apa yang menjadi titik kumpul warga, dan nilai apa yang paling dihargai. Dengan peta sosial seperti ini, pesan kesehatan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menumpang pada saluran yang sudah dipercaya.

Keterlibatan tokoh tidak berarti menyerahkan keputusan klinis, melainkan mengubah mereka menjadi sekutu yang menjaga kesinambungan. Tokoh agama, misalnya, dapat menenangkan kegundahan tentang penggunaan alat bantu inkontinensia saat ibadah, serta membantu menata jadwal minum agar tidak mengganggu waktu beribadah. Ketua lingkungan dapat menggerakkan kerja bakti kecil untuk memasang pegangan di kamar mandi umum atau memperbaiki pencahayaan lorong. Kader mempraktikkan latihan dasar panggul atau teknik bangkit aman dari kursi dalam kelompok kecil, lalu memantau di rumah dengan cara yang sopan dan tidak menggurui. Ketika keputusan perlu diambil, suara lansia tetap ditempatkan di pusat percakapan. Tugas bidan adalah memfasilitasi dialog yang hangat agar dukungan keluarga tidak berubah menjadi kontrol yang menyingkirkan keinginan klien sendiri.

Ada saatnya bidan perlu merangkul penyembuh tradisional setempat. Pendekatannya berbasis rasa saling menghormati. Tujuannya menggambar batas aman bersama, misalnya menegaskan area yang tidak boleh dipijat kuat, menganjurkan teknik yang lebih lembut, atau menyepakati tanda bahaya yang harus segera dirujuk. Kolaborasi seperti ini sering meredakan resistensi, karena semua pihak merasa diakui, dan pada akhirnya keselamatan klien menjadi kepentingan bersama.

3. Adaptasi materi edukasi sesuai konteks lokal

Materi edukasi yang baik bukan yang paling canggih, melainkan yang paling dikenali oleh klien dan keluarganya. Bahasa menjadi kunci pertama. Kata-kata teknis diterjemahkan ke istilah yang akrab, perumpamaan diambil dari keseharian setempat, dan jika perlu digunakan dialek lokal agar pesan menyentuh rasa. Ukuran dan bentuk huruf diperbesar, kontras warna dijaga, dan gambar memperlihatkan orang dengan pakaian dan latar yang mirip dengan audiens. Cerita pendek tentang seorang nenek yang ingin kembali beribadah atau kembali ke warung tanpa takut bocor sering lebih menggerakkan daripada daftar larangan. Di wilayah dengan keterbatasan internet, materi dicetak satu halaman dengan gambar langkah demi langkah. Di wilayah yang akrab dengan gawai, video singkat dengan durasi satu sampai dua menit lebih mudah diulang oleh keluarga.

Konten disesuaikan dengan kebiasaan dan alat yang tersedia. Pesan hidrasi menggunakan patokan gelas yang umum di rumah tangga setempat, bukan ukuran abstrak. Modifikasi kamar mandi diawali dengan solusi murah yang bisa dikerjakan keluarga, seperti alas anti-selip sederhana, pegangan dari pipa yang kuat, atau lampu malam hemat energi. Latihan fisik dipaketkan ke dalam kegiatan yang sudah dikenal, misalnya jalan pagi mengelilingi halaman rumah sambil

berteman, atau latihan keseimbangan yang disisipkan setelah ibadah pagi. Jadwal pengingat minum obat dipasangkan dengan ritme ibadah atau jam makan, sehingga keluarga tidak perlu menghafal jam baru. Untuk topik yang sensitif seperti kesehatan seksual atau kebocoran urin, ruang edukasi dibuat privat, pendamping perempuan disediakan bila diinginkan, dan visual yang digunakan sopan tetapi jelas.

Adaptasi juga menyentuh cara mengukur keberhasilan. Alih-alih grafik rumit, kartu kecil berstiker dapat dipakai untuk menandai hari ketika latihan dilakukan, air minum tercapai, atau kebocoran berkurang. Anak atau cucu diajak menjadi penjaga semangat dengan cara yang menyenangkan, bukan menekan. Bila literasi digital rendah, kader menelpon singkat seminggu sekali untuk menanyakan kemajuan dan hambatan. Semua alat bantu ini tidak memerlukan biaya besar, tetapi sangat meningkatkan peluang bahwa rencana asuhan benar-benar dijalankan di rumah.

Sebuah skenario dapat menggambarkan bagaimana ketiga unsur ini berpaut. Seorang nenek yang tinggal di rumah multigenerasi ingin kembali rutin menghadiri pengajian, tetapi cemas karena kebocoran urin dan lutut yang kaku. Keluarga terbiasa menyiapkan minuman jahe hangat pada malam hari, dan nenek senang dipijat cucunya. Bidan tidak mematikan kebiasaan ini, melainkan menatanya. Jahe tetap boleh tetapi dipindah ke waktu lebih awal agar tidak memicu berkemih malam, pijat dilanjutkan dengan tekanan ringan dan durasi pendek, serta ditambahkan latihan dasar panggul dan penguatan otot tungkai yang sederhana. Kader mengunjungi rumah untuk menunjukkan teknik bangkit aman dari kursi dan membantu memasang pegangan di kamar mandi. Tokoh agama menenangkan kekhawatiran tentang penggunaan pembalut inkontinensia saat ibadah. Materi edukasi satu halaman ditempel di lemari es dengan huruf besar dan gambar langkah latihan. Setelah empat minggu, nenek melaporkan kebocoran berkurang, tidur lebih tenang, dan berani hadir kembali di pengajian. Perubahan kecil ini terasa alami karena tidak mencabut akar budaya, melainkan menyiraminya dengan pengetahuan yang membuatnya tumbuh lebih aman.

Kearifan lokal dan sensitivitas budaya pada akhirnya bukan pilihan tambahan, melainkan jalan utama agar asuhan terasa masuk akal, dihormati, dan dijalankan. Ketika praktik tradisional yang aman dipertahankan, tokoh keluarga dan komunitas dirangkul, dan materi edukasi disesuaikan dengan dunia sehari-hari klien, maka intervensi ilmiah memperoleh rumahnya. Di rumah itu, ilmu dan budaya saling menyapa, dan lansia perempuan mendapatkan ruang yang aman untuk pulih fungsi, menenangkan hati, dan kembali hadir dalam kehidupan keluarga serta komunitasnya.

P. Studi Kasus dan Refleksi Praktik

1. Skenario kasus komprehensif

Seorang perempuan berusia tujuh puluh satu tahun, janda, tinggal di rumah multigenerasi bersama putri, menantu, dan dua cucu. Ia berhenti hadir dalam pengajian malam sejak beberapa bulan terakhir karena cemas mengalami kebocoran urin saat batuk dan takut tergelincir di kamar mandi rumahnya. Ia mengeluh lutut kanan sering nyeri ketika menaiki tangga, tidur terputus dua sampai tiga kali setiap malam untuk berkemih, serta mudah lelah keesokan harinya. Tekanan darah sebelumnya terkontrol dengan pengobatan dari dokter keluarga. Ia mengonsumsi obat penurun tekanan darah, obat pereda nyeri yang dibeli bebas ketika lutut memberat, suplemen kalsium, dan sesekali minum jamu yang dibuat menantunya pada malam hari. Selera makan menurun dalam dua bulan terakhir dan berat badan turun dua kilogram tanpa rencana. Di rumah, lorong menuju kamar mandi kurang terang, lantainya licin ketika basah, tidak ada pegangan di dekat kloset, dan ia terbiasa menggunakan sandal selop yang longgar. Putrinya yang paling sering mengingatkan minum obat, tetapi jadwalnya belum tertulis jelas sehingga kadang terlupa. Ia menyampaikan harapan yang sederhana tetapi kuat, yaitu kembali hadir di pengajian dua kali seminggu tanpa rasa malu atau takut jatuh, serta kembali berbelanja sayur ke warung kecil di ujung jalan setidaknya sekali seminggu.

Bidan melakukan pengkajian menyeluruh yang meliputi riwayat reproduktif, gejala pascamenopause yang masih terasa, kebiasaan minum dan berkemih, pola tidur, kekuatan otot, keseimbangan, dan kondisi lingkungan rumah. Kontraksi otot dasar panggul belum pernah diajarkan kepadanya. Ia mengakui menahan berkemih saat sedang menerima tamu, lalu pada malam hari minum jamu yang relatif hangat sehingga lebih sering terbangun. Pada pemeriksaan fungsional, ia dapat berdiri dari kursi tanpa bantuan tetapi lambat dan membutuhkan dorongan dari lengan kursi; saat berputar untuk kembali duduk tampak kurang stabil. Ia menyatakan merasa malu membicarakan kesehatan seksual, tetapi setelah suasana aman dan privat tercipta, ia mengaku sering merasakan kering pada vagina dan nyeri setelah berhubungan intim beberapa tahun terakhir sehingga memilih menghindarinya. Hasil pemeriksaan fisik umum berada dalam batas aman untuk intervensi non farmakologis, tetapi catatan tentang polifarmasi dan penggunaan obat pereda nyeri perlu ditinjau ulang bersama dokter keluarga. Dari percakapan yang hangat, tampak dukungan keluarga cukup baik, hanya saja setiap orang memberikan nasihat yang berbeda sehingga pesan menjadi membingungkan.

2. Pertanyaan reflektif dan panduan diskusi

Skenario ini mengundang tim untuk memeriksa cara berpikir klinis dan kepekaan budaya secara bersamaan. Pertanyaan pertama yang layak diajukan kepada diri sendiri adalah apakah tujuan hidup klien sudah benar-benar menjadi pusat rencana. Keinginannya untuk kembali ke pengajian dan berbelanja ke warung adalah kompas yang konkret. Setiap saran seharusnya bergerak menuju dua kegiatan itu, bukan menambah daftar larangan. Pertanyaan berikutnya menyentuh prioritas keselamatan. Apakah faktor lingkungan rumah yang meningkatkan risiko jatuh sudah dipetakan dan diatasi dengan langkah-langkah sederhana yang dapat dieksekusi keluarga, seperti menambah lampu malam, memasang alas anti selip, dan menyediakan pegangan di kamar mandi. Diskusi kemudian beralih ke komunikasi berbelas rasa. Apakah percakapan mengenai kebocoran urin, kering pada vagina, dan rasa malu saat ibadah dilakukan dengan bahasa yang tidak menghakimi dan tetap menjaga privasi. Untuk memeriksa bias, tim dapat bertanya apakah ada kecenderungan menyepelekan keluhan karena usia, misalnya menganggap kebocoran sebagai hal yang wajar sehingga dibiarkan tanpa rencana latihan yang runtut. Dari sisi klinis, tim menelaah apakah interaksi obat dan suplemen sudah dikaji, termasuk waktu minum jamu malam yang mungkin memperberat berkemih malam hari.

Panduan diskusi juga mengajak tim melihat kapasitas pengambilan keputusan dan dinamika keluarga. Apakah klien sudah diberi ruang untuk menyampaikan preferensi sendiri di hadapan putri dan menantu. Apakah rencana asuhan dituliskan dalam bahasa yang bisa dipahami semua pihak, beserta tanda bahaya yang perlu segera dilaporkan. Tim juga merefleksikan kolaborasi interprofesional. Kapan dokter keluarga perlu dihubungi untuk meninjau ulang obat pereda nyeri dan menilai risiko lambung serta ginjal. Kapan fisioterapis dapat menambahkan program penguatan lutut dan latihan keseimbangan yang aman. Kapan psikolog atau konselor dibutuhkan jika terlihat gejala kecemasan atau duka yang berkepanjangan. Di sisi budaya, tim merenungkan cara merangkul praktik tradisional yang memberi rasa tenang, seperti jamu, dengan menyiasati waktu konsumsi agar tidak mengganggu tidur, serta memastikan bahan dan takaran aman. Pertanyaan terakhir menyinggung dokumentasi. Apakah ringkasan tujuan, rencana, dan indikator sederhana sudah ditulis singkat di bagian paling atas catatan sehingga apa pun tindak lanjutnya akan kembali kepada hal yang dianggap penting oleh klien.

3. Rencana asuhan contoh dan lembar tindak lanjut

Rencana asuhan yang disusun bersama klien dan keluarga berangkat dari dua tujuan utama yang ia sampaikan. Untuk kendala kebocoran urin, bidan mengajarkan kontraksi otot dasar panggul dengan isyarat yang mudah,

memperagakan gerakan hingga klien dapat menirukan tanpa menahan napas, lalu menyepakati latihan singkat tiga kali sehari setelah momen yang sudah ada di rumah, misalnya setelah beribadah pagi, setelah makan siang, dan sebelum tidur. Kebiasaan berkemih ditata ulang dengan jarak waktu yang tetap pada siang hari, sementara asupan cairan besar pada sore dan malam dihindari, termasuk memindahkan jamu ke waktu lebih awal agar tidur tidak terganggu. Sensasi ingin berkemih yang mendesak dilatih dengan teknik napas pelan dan perhatian pada lantai panggul sebelum berjalan ke kamar mandi. Untuk kenyamanan seksual yang sempat menurun, edukasi diberikan secara privat mengenai perawatan area genital yang lembut, penggunaan pelembap vagina yang aman, dan kesempatan berdiskusi lanjutan bila diperlukan tanpa paksaan.

Untuk risiko jatuh dan nyeri lutut, program penguatan otot tungkai yang sederhana disusun, misalnya duduk berdiri dari kursi beberapa kali berturut-turut sesuai kemampuan dan latihan keseimbangan sambil berpegangan pada sandaran kursi. Pemanasan pendek dan pendinginan ringan dijelaskan agar sendi siap bekerja. Keluarga membantu menata kamar mandi dengan alas anti selip dan pegangan dekat kloset. Lorong diberi lampu malam hemat energi dan jalur dari tempat tidur ke kamar mandi dibersihkan dari barang yang menghalangi. Penggunaan sandal selop diganti dengan alas kaki yang menutup tumit dan bertapak tidak licin. Putri menjadi kontak keluarga utama yang memegang ringkasan rencana dan tanda bahaya, termasuk kriteria rujukan apabila terjadi perdarahan setelah menopause, demam dengan nyeri pinggang, nyeri panggul yang menetap, pusing hebat saat berdiri, atau jatuh. Bersamaan dengan itu, bidan menuliskan catatan singkat kepada dokter keluarga untuk meninjau penggunaan obat pereda nyeri yang kerap diminum, mempertimbangkan pilihan yang lebih aman bagi lambung dan ginjal, serta menilai apakah ada obat yang memicu berkemih malam atau mengganggu keseimbangan.

Lembar tindak lanjut dibuat sederhana namun padat guna. Pada bagian paling atas tertulis tujuan klien dengan kalimat yang dapat ia baca ulang kapan pun, yaitu kembali hadir di pengajian dua kali seminggu tanpa cemas dan kembali berbelanja ke warung sekali seminggu. Di bawahnya tercantum langkah harian yang disepakati, seperti tiga set latihan otot dasar panggul, jadwal berkemih siang yang konsisten, minum jamu dipindah ke sore hari, latihan duduk berdiri sesuai target, serta pengecekan lampu malam dan alas anti selip setiap malam oleh anggota keluarga. Indikator pemantauan ditulis ringkas, antara lain jumlah kejadian kebocoran di siang hari, jumlah terbangun untuk berkemih pada malam hari, kemampuan berdiri dari kursi lima kali berturut-turut tanpa bantuan, dan keberanian berjalan sampai ujung gang pada akhir pekan. Di samping indikator,

ada kotak kecil untuk menandai pencapaian agar keluarga dan klien dapat melihat kemajuan dari hari ke hari. Jadwal evaluasi disepakati, misalnya panggilan singkat setelah satu minggu untuk mengecek kenyamanan latihan, kunjungan dua minggu untuk menilai teknik dan meninjau modifikasi rumah, serta pertemuan empat minggu untuk menilai hasil awal terhadap tujuan besar.

Pada pertemuan tindak lanjut, rencana tidak dinilai berhasil atau gagal secara kaku. Jika kebocoran berkurang tetapi masih mengganggu aktivitas, teknik kontraksi diperiksa ulang dan latihan cepat ditambahkan untuk menghadapi batuk atau tertawa. Jika tidur masih terputus, jadwal minum malam ditinjau kembali dan kamar mandi diberi pegangan tambahan agar perjalanan malam lebih aman dan cepat. Jika lutut masih nyeri saat menaiki tangga, fisioterapis dihubungi untuk menambah variasi penguatan dan memastikan pola gerak aman. Bila muncul gejala baru seperti kantuk berlebihan atau pusing setelah penyesuaian obat, dokter keluarga dihubungi untuk evaluasi. Semua perubahan rencana ditulis dengan bahasa yang sama singkatnya, sehingga dokumen tetap menjadi peta bersama.

Ketika tujuan pertama tercapai, yaitu hadir kembali di pengajian dua kali seminggu tanpa cemas, tim dan keluarga merayakannya sebagai peneguh motivasi. Perayaan tidak harus besar, cukup pengakuan jujur bahwa kerja kecil yang konsisten telah membuat perbedaan. Setelah itu, rencana dapat dinaikkan satu tingkat, misalnya memperpanjang durasi jalan santai, menambah variasi latihan keseimbangan, atau menargetkan kegiatan sosial lain yang bermakna. Apabila tujuan belum tercapai, rencana diperkecil menjadi langkah yang lebih mudah dicapai tanpa menyalahkan siapa pun. Pendekatan ini menjaga inti pendampingan, yaitu mengembalikan rasa kendali dan martabat melalui rangkaian perubahan kecil yang relevan dengan kehidupan sehari-hari klien.

Q. Simpulan

Pendampingan kebidanan holistik pada lansia perempuan menuntut cara pandang lintas daur kehidupan yang memusatkan suara klien, menghormati martabat, dan menjahit bukti ilmiah dengan realitas keluarga serta budaya setempat. Kesehatan pada usia lanjut dibentuk oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural, sehingga asuhan yang efektif harus menyentuh seluruh lapisan ini secara serempak, bukan parsial.

Kerangka biopsikososial spiritual kultural memberi arah yang jelas, sementara sikap cultural humility dan cultural safety memastikan setiap pertemuan berlangsung aman, setara, dan bebas prasangka. Perspektif gender membantu membongkar bias yang kerap membuat keluhan perempuan lansia dianggap

lumrah lalu diabaikan. Melalui pengkajian terintegrasi yang meliputi riwayat reproduktif, kondisi uroginekologis, fungsi harian, nutrisi, kesehatan mental, risiko jatuh, serta nilai spiritual dan preferensi budaya, bidan menerjemahkan temuan menjadi pernyataan masalah yang jelas, prioritas yang disepakati, dan tujuan jangka pendek maupun panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Rencana asuhan yang kuat menyatukan intervensi non farmakologis dengan modifikasi lingkungan rumah, manajemen obat yang cermat, dukungan psikososial, dan penguatan spiritual. Pelibatan keluarga dan pengasuh dilakukan dengan cara yang menjaga otonomi klien, sedangkan posyandu lansia, kelompok sebaya, dan kader menjadi pengikat perilaku baru di komunitas. Kolaborasi interprofesional memastikan rujukan menambah daya, bukan memutus alur, dan transformasi digital dimanfaatkan seperlunya untuk menjaga kontinuitas, tanpa menggantikan sentuhan manusiawi dalam pendampingan.

Etika, hukum, dan perlindungan hak menjadi pagar keselamatan. Persetujuan tindakan yang benar-benar dipahami, kerahasiaan informasi, kewaspadaan terhadap kekerasan, serta upaya aktif menurunkan stigma usia harus hadir konsisten di setiap langkah. Mutu layanan dipertahankan melalui dokumentasi yang ringkas namun bermakna, indikator proses dan hasil yang mencakup klinis, fungsional, dan pengalaman klien, serta audit sederhana yang memicu perbaikan berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan akhirnya kembali pada hal yang dinilai penting oleh klien: fungsi yang pulih, rasa aman di rumah, partisipasi sosial yang hidup, dan martabat yang terjaga. Jalan ke sana adalah rangkaian langkah kecil yang konsisten, disusun bersama klien dan keluarga, dirajut oleh jejaring komunitas, dan diperkuat oleh kolaborasi lintas profesi. Ketika ilmu, empati, dan kearifan lokal berjalan seiring, lansia perempuan tidak hanya menerima layanan, melainkan memperoleh kembali kendali atas tubuh dan kehidupannya.

R. Referensi

-
- American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. (2023). American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 71(7), 2052–2081.
- Dumoulin, C., Cacciari, L. P., & Hay-Smith, E. J. C. (2018). Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(10), Article CD005654.
- Guirguis-Blake, J. M., Perdue, L. A., Coppola, E. L., & Bean, S. I. (2024). Interventions

to prevent falls in older adults: Updated evidence report and systematic review for the USPSTF. *JAMA*, 332(1), 58–69.

North American Menopause Society. (2020). The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 27(9), 976–992.

North American Menopause Society. (2023). The 2023 nonhormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 30(6), 573–590.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Buku saku). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Sum, G., Yap, M., et al. (2022). The WHO Integrated Care for Older People (ICOPE) framework: Adoption worldwide and lessons learnt. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), 810.

U.S. Preventive Services Task Force. (2024). Interventions to prevent falls in community-dwelling older adults: Recommendation statement. *JAMA*, 332(1), 51–57.

Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Hooper, L., Kiesswetter, E., ... Bischoff, S. C. (2022). ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 41(4), 958–989.

World Health Organization. (2017). Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2021). Global report on ageism. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2021). Step safely: Strategies for preventing and managing falls across the life-course. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020–2025.

Geneva: WHO.

World Health Organization. (2024). Abuse of older people: Fact sheet. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2024). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care (2nd ed.). Geneva: WHO.

S. Glosarium

Aktivitas dasar kehidupan sehari-hari (ADL): Kumpulan aktivitas pribadi paling mendasar—mandi, berpakaian, makan, berpindah posisi, menggunakan toilet—yang mencerminkan kemandirian fungsional lansia.

Aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari (IADL): Aktivitas lebih kompleks untuk hidup mandiri seperti berbelanja, menyiapkan makanan, mengelola uang dan obat, menggunakan telepon, serta bepergian.

Ageisme (stigma usia): Stereotip, prasangka, dan diskriminasi berbasis usia yang membuat keluhan lansia disepelekan dan menghambat akses layanan.

Ajak-ulang (teach-back): Teknik komunikasi untuk mengecek pemahaman dengan meminta klien mengulang inti informasi dengan kata-katanya sendiri.

Anamnesis: Wawancara klinis sistematis yang menggali riwayat reproduktif, penyakit, obat, kebiasaan, konteks sosial, nilai, dan tujuan hidup klien.

Audit mutu: Peninjauan terstruktur atas catatan dan proses layanan untuk menemukan kesenjangan rencana–praktik dan memicu perbaikan.

Beers Criteria: Daftar obat yang lebih berisiko pada lansia sehingga perlu dihindari, diganti, atau dipantau ketat.

Budaya keselamatan: Nilai dan kebiasaan kerja yang menempatkan keselamatan klien sebagai prioritas, termasuk pelaporan insiden tanpa menyalahkan.

Catatan medis elektronik: Rekaman klinis digital yang ringkas namun bermakna, memuat tujuan klien, masalah aktif, rencana, indikator pemantauan, serta tindak lanjut.

Citra tubuh: Persepsi dan perasaan seseorang terhadap tubuhnya; pada lansia perempuan dipengaruhi perubahan pascamenopause dan keluhan urogenital.

Continuitas perawatan: Keberlanjutan asuhan lintas rumah, komunitas, layanan primer, dan rujukan dengan umpan balik yang kembali ke rencana komunitas.

Cultural humility: Sikap rendah hati budaya—mengakui keterbatasan pengetahuan, aktif belajar dari klien, dan menghindari asumsi.

Cultural safety: Kondisi layanan yang dirasakan aman, bebas prasangka dan tekanan relasi kuasa, dengan persetujuan yang benar-benar bermakna.

Delirium: Kebingungan akut yang fluktuatif, sering dipicu infeksi, dehidrasi, atau obat; memerlukan penanganan medis segera.

Depresi pada lansia: Gangguan suasana hati dengan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, gangguan tidur/nafsu makan, menurunkan fungsi harian.

Dukungan sosial: Bantuan emosional, informasi, dan praktis dari keluarga, tetangga, kader, atau kelompok sebaya yang memperkuat kemandirian.

Edukasi kesehatan: Proses dialogis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan klien menjalankan rencana asuhan yang disepakati.

Empati klinis: Kemampuan memahami pengalaman/perasaan klien dan mengomunikasikannya kembali secara menenangkan dan memberdayakan.

ESPEN (panduan gizi geriatri): Rekomendasi praktik gizi dan hidrasi pada lansia yang menekankan kecukupan energi, protein, mikronutrien, serta pencegahan dehidrasi.

Evaluasi mutu: Penilaian berkala indikator proses dan hasil (klinis, fungsional, pengalaman) guna mengarahkan perbaikan berkelanjutan.

Frailty (kerapuhan): Penurunan cadangan fisiologis lintas sistem sehingga rentan terhadap stresor kecil; tampak lemah, lambat, mudah lelah, berat badan turun.

Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM): Kumpulan keluhan urogenital pascamenopause seperti kering/nyeri vagina, gangguan berkemih, dan penurunan kenyamanan seksual.

Gizi seimbang lansia: Pola makan harian yang menekankan cukup protein, sayur-buah, hidrasi adekuat, serta pembatasan gula, garam, dan lemak berlebih.

Hidrasi adekuat: Kecukupan asupan cairan harian; penting untuk mencegah pusing saat berdiri, konstipasi, dan infeksi saluran kemih.

Higiene tidur: Kebiasaan/lingkungan yang mendukung tidur berkualitas—jadwal tetap, batasi kafein sore, redupkan cahaya, rutinitas relaksasi.

Hipotensi ortostatik: Penurunan tekanan darah saat berdiri yang menimbulkan pusing atau hampir jatuh; terkait obat, dehidrasi, atau gangguan otonom.

ICOPE (Integrated Care for Older People): Kerangka layanan terintegrasi WHO untuk menilai kapasitas intrinsik lansia dan memandu intervensi komunitas.

Inkontinensia urin: Kebocoran urin tak disengaja (stres, urgensi, campuran); ditangani dengan latihan dasar panggul dan modifikasi kebiasaan.

Interaksi obat: Perubahan efek obat karena kombinasi dengan obat lain, suplemen, atau jamu; risikonya tinggi pada lansia.

Jamu/herbal: Ramuan tradisional yang dapat memberi kenyamanan bila aman, bersih, tidak berinteraksi dengan obat dokter, dan waktunya disesuaikan.

Jejaring dukungan sosial: Para pihak yang saling terhubung mendukung lansia—keluarga, kader, tokoh agama, pemimpin lingkungan, kelompok sebaya.

Kebijakan ramah lansia: Penataan lingkungan/layanan publik yang memudahkan mobilitas, akses toilet, pencahayaan, tempat duduk, dan keselamatan.

Keluarga pengasuh: Anggota keluarga yang mendampingi kebutuhan harian; memerlukan dukungan, pembagian tugas, serta pencegahan kelelahan pengasuh.

Kemandirian fungsional: Kemampuan menjalankan ADL dan IADL tanpa atau dengan bantuan minimal; target utama pendampingan lansia.

Kesiapsiagaan darurat: Rencana sederhana menghadapi jatuh, banjir, kebakaran, gelombang panas; mencakup daftar kontak, tas siaga, dan latihan berkala.

Keselamatan pasien: Upaya proaktif mencegah cedera terkait layanan—pencegahan jatuh, pengelolaan obat, dan perlindungan data.

Kolaborasi interprofesional: Kerja tim lintas profesi dengan rencana tunggal, komunikasi terstruktur, dan umpan balik yang jelas.

Komorbiditas: Keberadaan ≥ 2 penyakit pada saat bersamaan yang saling memengaruhi rencana asuhan.

Komunikasi berbelas rasa: Interaksi yang menghormati martabat klien, peka pada topik sensitif, dan menghindari bahasa menghakimi.

Komunikasi terstruktur (SBAR): Format singkat Situation–Background–Assessment–Recommendation untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas.

Konseling berpusat pada klien: Pengambilan keputusan bersama yang menempatkan nilai dan preferensi klien sebagai pusat.

Konseling gizi: Dialog praktis untuk menyesuaikan pola makan dengan kondisi medis, budaya, dan kemampuan ekonomi klien.

Latihan dasar panggul: Kontraksi terarah otot lantai panggul untuk mengurangi kebocoran urin dan menunjang fungsi urogenital.

Lingkungan ramah lansia: Tata ruang rumah/komunitas yang aman: pencahayaan cukup, lantai tak licin, pegangan di titik rawan, jalur bebas hambatan.

Malnutrisi pada lansia: Kekurangan energi atau protein yang menurunkan berat badan, massa/kekuatan otot, dan menaikkan risiko jatuh.

Manajemen nyeri non-farmakologis: Strategi tanpa obat seperti kompres hangat/dingin, peregangan, penguatan bertahap, ergonomi, dan edukasi aktivitas aman.

Manajemen obat: Penataan terapi obat—daftar lengkap, kotak obat mingguan, label jelas, jadwal sesuai rutinitas, evaluasi berkala.

Menopause/pascamenopause: Henti haid permanen dan fase setelahnya disertai perubahan hormonal yang memengaruhi metabolisme, tulang, kulit, dan urogenital.

Monitoring dan evaluasi: Pengumpulan data terpilih secara konsisten untuk menilai proses/hasil lalu menyesuaikan rencana.

Navigasi pelayanan: Pendampingan memilih jalur layanan yang logis, menyiapkan berkas rujukan, dan memastikan tindak lanjut kembali ke komunitas.

Nyeri muskuloskeletal: Nyeri pada sendi, otot, atau tulang yang membatasi mobilitas; ditangani dengan kombinasi edukasi, latihan, dan ergonomi.

Obat berisiko tinggi pada lansia: Obat yang meningkatkan risiko kantuk, kebingungan, jatuh, atau efek organ sehingga perlu pengawasan ketat/alternatif.

Otonomi pasien: Hak klien memilih atau menolak intervensi setelah memahami informasi relevan.

Pencegahan jatuh: Kombinasi latihan kekuatan/keseimbangan, modifikasi rumah, pemeriksaan penglihatan/pendengaran, serta peninjauan obat.

Pelibatan keluarga: Keterlibatan terstruktur anggota keluarga sebagai mitra asuhan tanpa menyingkirkan suara klien.

Pemantauan jarak jauh: Pelaporan parameter sederhana dari rumah (mis. tekanan darah, jumlah langkah, kejadian pusing) untuk keputusan tepat waktu.

Pemeriksaan uroginekologis: Penilaian aman dan privat terhadap keluhan berkemih dan organ panggul dengan pendekatan non-invasif bila memungkinkan.

Pengkajian holistik: Penilaian menyeluruh aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, kultural, fungsional, dan lingkungan.

Perspektif gender: Cara pandang yang menyadari pengalaman seumur hidup perempuan memengaruhi risiko dan peluang kesehatan pada usia tua.

Persetujuan tindakan kedokteran: Izin yang diberikan klien setelah mendapat informasi lengkap tentang tujuan, manfaat, risiko, alternatif, dan konsekuensi.

Pijat aman pada lansia: Pijatan ringan berdurasi singkat, menghindari tekanan kuat pada tulang rapuh/area nyeri; bertujuan relaksasi.

Polifarmasi: Penggunaan banyak obat sekaligus, termasuk suplemen/jamu, dengan risiko interaksi dan efek samping lebih tinggi.

Posyandu lansia: Kegiatan komunitas berkala untuk skrining sederhana, edukasi, senam, dan tindak lanjut yang dipandu bidan dan kader.

Privasi dan kerahasiaan: Perlindungan data/percakapan klinis agar tidak diakses atau dibagi tanpa persetujuan sah.

Rekonsiliasi obat: Mencocokkan daftar obat yang digunakan klien dengan resep yang direncanakan untuk mencegah duplikasi dan interaksi.

Rencana asuhan: Dokumen ringkas memuat tujuan, langkah, indikator, peran tiap pihak, jadwal evaluasi, serta tanda bahaya.

Risiko jatuh: Peluang lansia terjatuh akibat faktor intrinsik (kekuatan otot, hipotensi ortostatik, penglihatan) dan ekstrinsik (lantai licin, pencahayaan).

Rujukan terencana: Pengalihan pelayanan ke fasilitas yang lebih tepat disertai ringkasan klinis jelas dan pertanyaan rujukan spesifik.

Senam lansia: Latihan kelompok berintensitas ringan–sedang untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan dalam suasana menyenangkan.

SMART (tujuan asuhan): Spesifik, Terukur, dapat dicapai, Relevan, dan terbatas Waktu—kerangka merumuskan target jangka pendek/panjang.

Skrining kekerasan/penelantaran: Pemeriksaan privat, tidak menghakimi, untuk mendeteksi kekerasan fisik, psikologis, seksual, finansial, atau penelantaran.

Skrining nutrisi: Penilaian ringkas status gizi melalui perubahan berat badan, nafsu makan, kemampuan mengunyah/menelan, serta tanda dehidrasi.

Spiritualitas: Sumber makna, harapan, dan ketenangan batin—praktik ibadah atau nilai hidup yang menuntun keputusan perawatan.

Telekesehatan: Konsultasi klinis jarak jauh yang menjaga kontinuitas asuhan, dengan persetujuan jelas, ruang privat, dan ringkasan rencana tertulis.

Tidur sehat: Pola tidur dengan durasi/kualitas cukup sehingga memulihkan energi, menstabilkan emosi, dan menurunkan persepsi nyeri.

Tokoh masyarakat: Figur berpengaruh (pemuka agama/ketua lingkungan) yang memperkuat penerimaan pesan kesehatan dan program ramah lansia.

Uji bangkit dari kursi: Penilaian sederhana kekuatan tungkai dan risiko jatuh dengan menghitung kemampuan berdiri dari kursi beberapa kali tanpa bantuan.

Uroginekologi: Bidang yang membahas kesehatan saluran kemih bawah dan organ panggul perempuan, termasuk inkontinensia dan prolaps.

Validasi perasaan: Mengakui emosi klien secara tulus agar ia merasa didengar dan siap menerima informasi atau perubahan perilaku.

Vasomotor (gejala): Rasa panas tiba-tiba dan keringat malam pascamenopause yang mengganggu tidur dan kualitas hidup.

WHO ICOPE: Pedoman WHO untuk asesmen berpusat-orang dan jalur intervensi primer guna mempertahankan kapasitas dan kemandirian lansia.

PROFIL PENULIS



Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes. Lahir di Jombang, 05 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Akbid Alifa Pringsewu lulus tahun 2010. Jenjang D4 Kebidanan di Universitas Malahayati Lulus Tahun 2012. Jenjang Magister Kesehatan di Universitas Malahayati Peminatan Kesehatan Reproduksi Lulus Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Doktor pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010-2014 di Akbid Alifa, selanjutnya mengabdikan diri di Universitas Aisyah Pringsewu Mulai 2014 hingga saat ini. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang Sebagian dalam lingkup kebidanan, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anikristianingsih@aisyahuniversity.ac.id

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Pendekatan Holistik dalam Asuhan Kebidanan: Dari Remaja Hingga Lansia hadir sebagai kontribusi akademik dan praktis dalam memperkaya khasanah ilmu kebidanan. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan perempuan di setiap fase kehidupannya.

Bab pertama membahas asuhan kebidanan pada remaja dengan pendekatan holistik, mulai dari konsep dasar, karakteristik remaja, pengkajian, hingga perencanaan dan implementasi asuhan. Pembahasan ini menekankan kebutuhan khusus remaja dan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan yang komprehensif pada masa transisi menuju dewasa.

Bab kedua dan ketiga berfokus pada masa pra konsepsi, kehamilan, dan nifas. Asuhan kebidanan dalam bab ini dikupas secara mendalam dengan menyoroti persiapan menyeluruh sebelum hamil, pemeliharaan kesehatan ibu selama kehamilan, serta dukungan yang diperlukan ibu pasca persalinan. Aspek nutrisi, dukungan emosional, promosi menyusui, serta pencegahan komplikasi menjadi inti dari pendekatan yang ditawarkan.

Bab keempat menitikberatkan pada pendampingan kebidanan holistik bagi lansia. Pembahasan meliputi profil kesehatan lansia perempuan, peran bidan, intervensi klinis non-farmakologis, intervensi berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Integrasi kearifan lokal, etika, serta perlindungan hak lansia menjadikan asuhan lebih manusiawi dan peka budaya. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, bidan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia.

Buku Bunga Rampai Pendekatan Holistik dalam Asuhan Kebidanan: Dari Remaja Hingga Lansia hadir sebagai kontribusi akademik dan praktis dalam memperkaya khasanah ilmu kebidanan. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan perempuan di setiap fase kehidupannya.

Bab pertama membahas asuhan kebidanan pada remaja dengan pendekatan holistik, mulai dari konsep dasar, karakteristik remaja, pengkajian, hingga perencanaan dan implementasi asuhan. Pembahasan ini menekankan kebutuhan khusus remaja dan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan yang komprehensif pada masa transisi menuju dewasa. Bab kedua dan ketiga berfokus pada masa pra konsepsi, kehamilan, dan nifas. Asuhan kebidanan dalam bab ini dikupas secara mendalam dengan menyoroti persiapan menyeluruh sebelum hamil, pemeliharaan kesehatan ibu selama kehamilan, serta dukungan yang diperlukan ibu pasca persalinan. Aspek nutrisi, dukungan emosional, promosi menyusui, serta pencegahan komplikasi menjadi inti dari pendekatan yang ditawarkan.

Bab keempat menitikberatkan pada pendampingan kebidanan holistik bagi lansia. Pembahasan meliputi profil kesehatan lansia perempuan, peran bidan, intervensi klinis non-farmakologis, intervensi berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Integrasi kearifan lokal, etika, serta perlindungan hak lansia menjadikan asuhan lebih manusiawi dan peka budaya.

Dengan penyajian yang sistematis, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, bidan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

